

治験届の手引き

2024 年 3 月

公益社団法人 東京医薬品工業協会
薬事法規委員会
第四研究部会

はじめに

本手引き書は、医薬品の治験計画届書等を作成する際の留意点について法令、通知等を根拠にまとめたものです。

本版では、最新の治験届書関連通知及び治験届書のオンライン提出が可能となったことに伴い、2022 年（令和 4 年）3 月に発行された「治験届の手引き」の改訂を行いました。また、治験届書のオンライン提出のセクションを新設するとともに、諸作業についての本手引き書検討グループ各社の事例など、業務担当者の実務の助けになるような情報を盛り込むよう努めました。

業務担当者として治験計画届書等の作成・確認・届出等を行う際に役立てて頂ければ幸いです。

本手引き書については、当局の校閲や確認を得たものではありませんので、ご利用の際には十分ご注意頂きますようお願いします。

<本手引き書の留意事項>

- ・ 企業が行う治験のうち、医薬品（薬物）を対象とした。
- ・ 本文においては、2024 年 1 月時点の法令、通知等を参考とした。令和 5 年 3 月 30 日 薬生薬審発 0330 第 3 号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知を基本通知と位置付け、本手引き書を作成した。

<本手引き書の見方>

冊子中の表記	内容
【事例】	本手引き書検討グループ各社の治験届に関する PMDA への問合せ事項や通知等にはない対応を事例として収載した。 なお、【事例】内容は、提供会社の事例であり、必ずしも事例どおり適用できるものではないことに留意頂き、事例を踏まえて適宜 PMDA へ確認されたい。
【運用】	通知や PMDA ウェブサイト等の当局から発出・発信されたもの以外の運用等には【運用】を付した。

目 次

治験届の手引き 早見表	1
Ⅰ. 申請電子データシステムを利用した治験計画届書等のオンライン提出	5
1 オンライン提出の対象	6
2 使用するゲートウェイシステムの機能について	6
3 オンライン提出について	7
4 オンライン提出時の受付時間、提出方法等について	7
1. ゲートウェイシステムにおける「提出日時」、治験届書の届出年月日、PMDA の受付年月日及び受付完了メールの送付日、30 日調査の起算開始日について	7
2. 提出方法	9
3. 審査マネジメント部への差替えについて	23
4. 受付不可について	24
5. 問い合わせについて	24
6. 受付完了メールについて	25
Ⅱ. 治験計画届書	27
1 治験計画の届出の対象	27
2 治験計画届書の提出時期等	30
1. 30 日調査対象の治験計画届書	30
2. 「1. 30 日調査対象の治験計画届書」以外の治験計画届書	31
3. 緊急に実施する治験において治験開始後 30 日以内に治験計画の届出を行う場合	32
4. その他	33
3 治験計画届書の作成に関する一般的注意事項	34
1. 様式	34
2. 届書の記載に関する一般的事項	35
3. 添付資料の作成に関する一般的事項	35
(1) 30 日調査対象となる届書（届出区分「1」に該当）に添付すべき資料	35
(2) 30 日調査に該当しない届書（届出区分「2」に該当）に添付すべき資料	38
潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中 DNA 反応性（変異原性）不純物の評価及び管理（ICH-M7）ガイドライン関連について	40
主たる治験について	44
4 治験計画届書の提出に関する一般的注意事項	46
1. 提出の方法	46

(1) ゲートウェイシステムを利用したオンライン提出	46
(2) 郵送・受付窓口提出	46
(3) 問合せについて	47
2. 届書の提出様式	47
3. 添付資料の提出様式	48
4. 治験の実施状況等の登録について	50
5 治験計画届書の記載上の注意事項	51
1. 治験届出共通事項	51
(1) 主たる被験薬の治験成分記号	51
(2) 治験の種類	52
(3) 主たる被験薬の初回届出受付番号	52
(4) 主たる被験薬の初回届出年月日	52
(5) 主たる被験薬の届出回数	52
(6) 当該治験計画届出受付番号	53
(7) 当該治験計画届出年月日	53
2. 主たる被験薬に関する届出事項	53
(1) 届出年月日	53
(2) 届出分類	53
(3) 変更回数	53
(4) 届出区分	54
(5) 主たる被験薬の 30 日調査対応被験薬区分	54
(6) 中止情報	55
(7) 主たる被験薬の製造所又は営業所の名称及び所在地	55
(8) 主たる被験薬の成分及び分量情報	55
(9) 主たる被験薬の製造方法	57
(10) 主たる被験薬の予定される効能又は効果情報	57
(11) 主たる被験薬の予定される用法及び用量情報	57
(12) 治験計画の概要	57
(13) 主たる被験薬のその他の情報	61
(14) 当該届出に関するその他の情報	62
(15) 備考	63
(16) 届書添付資料	65
(17) 治験届出者に関する情報	66
(18) 海外依頼者、外国製造業者に関する情報	66
3. 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の情報	66
(1) 医薬品／医療機器／再生医療等製品の別	66
(2) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の記号・名称等	67

(3) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当区分情報	67
(4) 国内における承認状況	67
(5) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の届出 事項	68
4. 実施医療機関ごとの事項	68
(1) 実施医療機関の名称・実施診療科、所在地及び代表電話番号	68
(2) 治験責任医師に関する情報	68
(3) 治験分担医師に関する情報	69
(4) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の数量情報	69
(5) 実施医療機関予定被験者数	69
(6) 実施医療機関被験者数	70
(7) 治験の実施に係る業務の一部を実施医療機関から受託する者（治験施設支援機関 （SMO）等）の氏名、住所及び委託する業務の範囲	70
(8) 治験審査委員会に関する情報	70
(9) その他	70
(10) 脚注	70
5. 参照する治験届出情報	70
6. ケース別事例のまとめ	72
(1) 製造販売後臨床試験への切替え（事例）	72
(2) 共同開発、会社合併、承継等、治験届に他社が関係する場合の事例（一部再掲）	72
(3) 初回治験計画届と n 回治験計画届を同時期に提出する場合の事例（再掲）	74
治験計画届後に発出された照会事項（参考情報）	75
薬効分類	77
大学番号一覧	81
6 ファイル名、提出方法等	82
1. ファイル名	82
(1) PDF 形式	82
(2) XML 形式	83
(3) 非臨床安全性試験（毒性試験及び安全性薬理試験）の最終報告書の zip ファイルのフ ァイル名	83
2. 全般的な留意事項	83
3. 資料情報	84
4. ファイルへの入力形式	84
5. 初めてヒトに投与する薬物に係る治験の計画の届出時における非臨床安全性試験（毒性試験 及び安全性薬理試験）の最終報告書の提出方法	84
III. 治験計画変更届書	86

1 治験計画変更届の届出の対象.....	86
2 治験計画変更届書の提出時期.....	86
変更後 6 ヶ月を目安に届出可能な事項.....	88
3 治験計画変更届書の作成に関する一般的注意事項.....	90
1. 治験計画変更届共通事項.....	90
2. 添付資料の作成に関する一般的事項.....	90
(1) 30 日調査対象となる治験計画変更届書（届出区分「1」に該当）の場合.....	90
(2) 追加する被験薬が 30 日調査に該当しない治験計画変更届書（届出区分「2」に該当） の場合.....	90
(3) (1)(2)以外の届書.....	90
4 治験計画変更届書の提出に関する一般的注意事項.....	91
1. 治験計画変更届共通事項.....	91
5 治験計画変更届書の記載上の注意事項.....	92
1. 治験届出共通事項.....	92
(1) 主たる被験薬の治験成分記号.....	92
(2) 主たる被験薬の初回届出受付番号.....	93
(3) 当該治験計画届出受付番号.....	93
(4) 当該治験計画届出年月日.....	93
2. 主たる被験薬に関する届出事項.....	93
(1) 届出年月日.....	93
(2) 届出分類.....	93
(3) 変更回数.....	93
(4) 届出区分.....	94
(5) 主たる被験薬の製造所又は営業所の名称及び所在地.....	94
(6) 主たる被験薬の成分及び分量情報.....	94
(7) 主たる被験薬の製造方法.....	94
(8) 治験計画の概要.....	95
(9) 当該届出に関するその他の情報.....	96
(10) 備考.....	96
(11) 届書添付資料.....	97
(12) 治験届出者に関する情報.....	97
3. 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の情報.....	98
4. 実施医療機関ごとの事項.....	99
(1) 実施医療機関の名称・実施診療科、所在地及び電話番号.....	99
(2) 治験責任医師に関する情報.....	100
(3) 治験分担医師に関する情報.....	100

(4) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の数量情報・実施医療機関予定被験者数.....	101
(5) 治験の実施に係る業務の一部を実施医療機関から受託する者（治験施設支援機関（SMO）等）の氏名、住所及び委託する業務の範囲.....	101
(6) 治験審査委員会の設置者の名称及び所在地.....	102
IV. 治験中止届書.....	103
1 治験中止届の届出の対象.....	103
2 治験中止届書の提出時期.....	103
3 治験中止届書の作成に関する一般的注意事項.....	103
4 治験中止届書の提出に関する一般的注意事項.....	103
5 治験中止届書の記載上の注意事項.....	103
1. 治験届出共通事項.....	103
(1) 当該治験計画届出受付番号.....	103
(2) 当該治験計画届出年月日.....	104
2. 主たる被験薬に関する届出事項.....	104
(1) 届出年月日.....	104
(2) 届出分類.....	104
(3) 届出区分.....	104
(4) 中止情報.....	104
(5) 予定被験者数情報.....	104
(6) 届書添付資料.....	104
3. 実施医療機関ごとの事項.....	104
V. 治験終了届書.....	106
1 治験終了届の届出の対象.....	106
2 治験終了届書の提出時期.....	106
3 治験終了届書の作成に関する一般的注意事項.....	106
4 治験終了届書の提出に関する一般的注意事項.....	106
5 治験終了届書の記載上の注意事項.....	106
1. 治験届出共通事項.....	106
(1) 当該治験計画届出受付番号.....	106
(2) 当該治験計画届出年月日.....	106
2. 主たる被験薬に関する届出事項.....	106
(1) 届出年月日.....	106
(2) 届出分類.....	106

(3) 届出区分	107
(4) 予定被験者数情報	107
(5) 届書添付資料	107
3. 実施医療機関ごとの事項	107
VI. 開発中止届書	110
1 開発中止届の届出の対象	110
2 開発中止届書の提出時期	111
3 開発中止届書の作成に関する一般的注意事項	111
4 開発中止届書の提出に関する一般的注意事項	111
5 開発中止届書の記載上の注意事項	111
1. 主たる被験薬に関する届出事項	111
(1) 届出年月日	111
(2) 届出分類	111
(3) 届出区分	111
(4) 中止情報（中止時期、中止理由を含む）	112
(5) 届書添付資料	112
引用通知一覧	113

治験届の手引き 早見表

治験届の項目 ¹⁾	治験届の手引きの該当項目 ^{2) 3) 4)}				
	II. 治験計画届書	III. 治験計画変更届書	IV. 治験中止届書	V. 治験終了届書	VI. 開発中止届書
1) 治験届出共通事項	p51 1.	p92 1.	p103 1.	p106 1.	
(1) 主たる被験薬の治験成分記号	○ p51 (1)	○ p92 (1)	○	○	○
(2) 治験の種類	○ p52 (2)	○	○	○	○
(3) 主たる被験薬の初回届出受付番号	○# p52 (3)	○ p93 (2)	○	○	○
(4) 主たる被験薬の初回届出年月日	○ p52 (4)	○	○	○	○
(5) 主たる被験薬の届出回数	○ p52 (5)	○	○	○	—
(6) 当該治験計画届出受付番号	× p53 (6)	○ p93 (3)	○ p103 (1)	○ p106 (1)	—
(7) 当該治験計画届出年月日	○ p53 (7)	○ p93 (4)	○ p104 (2)	○ p106 (2)	—
2) 主たる被験薬に関する届出事項	p53 2.	p93 2.	p104 2.	p106 2.	p111 1.
(1) 届出年月日	○ p53 (1)	○ p93 (1)	○ p104 (1)	○ p106 (1)	○ p111 (1)
(2) 届出分類	○ p53 (2)	○ p93 (2)	○ p104 (2)	○ p106 (2)	○ p111 (2)
(3) 変更回数	× p53 (3)	○ p93 (3)	×	×	—
(4) 届出区分	○ p54 (4)	○ p94 (4)	○ p104 (3)	○ p107 (3)	○ p111 (3)
(5) 主たる被験薬の 30 日調査対応被験薬区分	△ p54 (5)	△	△	△	—
(6) 中止情報	p55 (6)		p104 (4)		p112 (4)
①中止日年月日	×	×	○	×	○
②中止理由	×	×	○	×	○
③その後の対応状況	×	×	○	×	—
(7) 主たる被験薬の製造所又は営業所（治験薬提供者）の名称及び所在地	○ p55 (7)	○ p94 (5)	○	○	—
(8) 主たる被験薬の成分及び分量情報	p55 (8)	p94 (6)			
①成分及び分量	○	○	○	○	—
②剤形コード情報	○	○	○	○	—
(9) 主たる被験薬の製造方法	○ p57 (9)	○ p94 (7)	○	○	—
(10) 主たる被験薬の予定される効能又は効果情報	○ p57 (10)	○	○	○	—
(11) 主たる被験薬の予定される用法及び用量情報	○ p57 (11)	○	○	○	—
(12) 治験計画の概要	p57 (12)	p95 (8)			
①実施計画書識別記号	○ p57 1)	○	○	○	—
②開発の相	○ p57 2)	○	○	○	—
③試験の種類	○ p58 3)	○	○	○	—
④目的	○ p60 4)	○	○	○	—
⑤予定被験者数情報	○ p60 5)	○ p95 1)	○ p104 (5)	○ p107 (4)	—
⑥主たる被験薬の対象疾患	○ p60 6)	○	○	○	—
⑦主たる被験薬の用法及び用量情報	p60 7)	p95 2)			
1. 用法及び用量	○	○	○	○	—

治験届の項目 ¹⁾	治験届の手引きの該当項目 ^{2) 3) 4)}				
	II. 治験計画届書	III. 治験計画変更届書	IV. 治験中止届書	V. 治験終了届書	VI. 開発中止届書
2. 投与経路コード情報	○	○	○	○	—
⑧実施期間	p60 8)	p95 3)			
1. 開始日年月日	○	○	○	○	—
2. 終了日年月日	○	○	○	○	—
⑨有償の理由等	△ p60 9)	△	△	△	—
⑩治験の費用負担者に関する情報	× p60 10)	×	×	×	—
⑪治験調整医師又は治験調整委員会構成医師に関する情報	△ p60 11)	△ p95 4)	△	△	—
⑫治験の依頼及び管理に関する業務の全部又は一部を受託する者（開発業務受託機関（CRO））の氏名、住所及び委託する業務の範囲	△ p61 12)	△ p96 5)	△	△	—
(13) 主たる被験薬のその他の情報	p61 (13)				
①カルタヘナ法の対象となる薬物を用いる治験	○ p61 1)	○	○	○	—
②生物由来製品に指定が見込まれる薬物を用いる治験	○ p61 2)	○	○	○	—
③対応するコンパニオン診断薬等の開発	○ p61 3)	○	○	○	—
④コンビネーション製品に関する治験	○ p61 4)	○	○	○	—
⑤その他	△ p62 5)	△	△	△	—
(14) 当該届出に関するその他の情報	p62 (14)	p96 (9)			
①臨床試験の位置づけ	○ p62 1)	○	○	○	—
②国際共同治験	○ p62 2)	○	○	○	—
③ゲノム検査等を含む治験	○ p62 3)	○	○	○	—
④マイクロドーズ臨床試験を利用した開発品目	○ p62 4)	○	○	○	—
⑤当該届出に関する治験に併用する機械器具等の記載	○ p63 5)	○	○	○	—
⑥その他	△ p63 6)	△	△	△	—
(15) 備考	△ p63 (15)	△ p96 (10)	△	△	○
(16) 届書添付資料	○ p65 (16)	△ p97 (11)	△ p104 (6)	△ p107 (5)	△ p112 (5)
(17) 治験届出者に関する情報	p66 (17)	p97 (12)			
①治験届出者の種別	○	○	○	○	○
②届出者の名称	○	○	○	○	○
③届出者の（代表者の）氏名	○	○	○	○	○
④所在地	○	○	○	○	○
⑤業者コード	○	○	○	○	○
⑥届出担当者の情報	○	○	○	○	○

治験届の項目 ¹⁾	治験届の手引きの該当項目 ^{2) 3) 4)}				
	II. 治験計画届書	III. 治験計画変更届書	IV. 治験中止届書	V. 治験終了届書	VI. 開発中止届書
(18) 海外依頼者、外国製造業者に関する情報	△ p66 (18)	△	△	△	—
3) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の情報	p66 3.	p98 3.			
(1) 医薬品／医療機器／再生医療等製品の別	△ p66 (1)	△	△	△	—
(2) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の記号・名称等	△ p67 (2)	△	△	△	—
(3) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当区分情報	△ p67 (3)	△	△	△	—
(4) 国内における承認状況	△ p67 (4)	△	△	△	—
(5) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の届出事項	p68 (5)				
①30 日調査対応被験薬区分	△	△	△	△	—
②製造所又は営業所（治験薬提供者）の名称及び所在地	△	△	△	△	—
③成分及び分量情報	△	△	△	△	—
④製造方法	△	△	△	△	—
⑤予定される効能又は効果情報	△	△	△	△	—
⑥予定される用法及び用量情報	△	△	△	△	—
⑦治験計画の概要	△	△	△	△	—
⑧その他の情報	△	△	△	△	—
⑨海外依頼者、外国製造業者に関する情報	△	△	△	△	—
⑩その他備考	△	△	△	△	—
⑪副作用報告の有無	△	△	△	△	—
4) 実施医療機関情報					
(1) 実施医療機関ごとの事項	p68 4.	p99 4.	p104 3.	p107 3.	
①実施医療機関の名称	○ p68 (1)	○ p99 (1)	○	○	—
②実施診療科	○ p68 (1)	○ p99 (1)	○	○	—
③所在地	○ p68 (1)	○ p99 (1)	○	○	—
④電話番号	○ p68 (1)	○ p99 (1)	○	○	—
⑤治験責任医師に関する情報	p68 (2)	p100 (2)			
1. 治験責任医師の氏名	○	○	○	○	—
2. 大学番号	○	○	○	○	—
3. 卒業年	○	○	○	○	—
4. 氏名よみかな	○	○	○	○	—
⑥治験分担医師に関する情報	p69 (3)	p100 (3)			

治験届の項目 ¹⁾	治験届の手引きの該当項目 ^{2) 3) 4)}				
	Ⅱ. 治験計画届書	Ⅲ. 治験計画変更届書	Ⅳ. 治験中止届書	Ⅴ. 治験終了届書	Ⅵ. 開発中止届書
1. 治験分担医師の氏名	○	○	○	○	—
2. 氏名よみかな	○	○	○	○	—
⑦治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当数量情報	p69 (4)				
1. 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の名称	○	○	○	○	—
2. 予定交付（入手）数量	○	○ p101 (4)	○	○	—
3. 交付数量	×	×	○	○	—
4. 使用数量	×	×	○	○	—
5. 回収数量	×	×	○	○	—
6. 廃棄数量	×	×	○	○	—
⑧実施医療機関予定被験者数	○ p69 (5)	○ p101 (4)	○	○	—
⑨実施医療機関被験者数	×	p70 (6)	○	○	—
⑩治験の実施に関する業務の一部を実施医療機関から受託する者（治験施設支援機関（SMO）等）の氏名、住所及び委託する業務の範囲	△ p70 (7)	△ p101 (5)	△	△	—
⑪治験審査委員会に関する情報	○ p70 (8)	○ p102 (6)	○	○	—
⑫その他	△ p70 (9)	△	△	△	—
(2) 脚注	△ p70 (10)	△	△	△	—
5) 参照する治験届出情報	p70 5.				
(1) 医薬品／医療機器／再生医療等製品の別	△	△	△	△	—
(2) 治験成分記号又は治験識別記号	△	△	△	△	—
(3) 届出回数	△	△	△	△	—
(4) 参照の区分	△	△	△	△	—
(5) 参照の詳細	△	△	△	△	—

注意事項

1) 届出項目はXML文書の構造定義（スキーマ）による記載

2) 手引き本文中の見出しは、通知の内容を反映しているため、本早見表の項目名と一部異なる場合がある。

3) 各項目に対する記載がない場合は空欄とした。

なお、Ⅲ. 治験計画変更届書、Ⅳ. 治験中止届書、Ⅴ. 治験終了届書の空欄については、Ⅱ. 治験計画届書を参照すること。

4) ○：記載必須

（#：初回治験計画届書の場合は記載不可（空欄））

なお、各変更事項と提出時期の関係は、「Ⅲ. 治験計画変更届書 2 治験計画変更届書の提出時期（p86）」を参照

△：必要に応じて記載

×

×：記載不可（空欄）

—：届出項目なし

I. 申請電子データシステムを利用した治験計画届書等のオンライン提出

令和 5 年 1 月 11 日から、書面等を提出する方法に代えて、申請電子データシステム（以下「ゲートウェイシステム」という）を利用して治験計画届書等をオンライン提出することが可能となった。治験計画届書等をオンライン提出する場合は、本冊子の各章で記載の書面等の窓口・郵送提出は行う必要はない。

令和 5 年 4 月 1 日以降は、治験計画届書等の電子メールでの提出は受け付けておらず、「ゲートウェイシステムを利用したオンライン提出」又は「窓口・郵送提出」された治験届書を受け付けている。

治験届書等がオンライン提出された場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）の受付印が押印された治験届書の写し（控え）を治験届出者に返送することはしない。そのため、これまで PMDA の受付印が押印された治験届書の写し（控え）を用いていた対応については以下の対応で良いとされている。

- ① 「治験に係る文書又は記録」として、治験届書の控え（治験計画届書（控）、治験計画変更届書（控）、治験終了届書（控）、治験中止届書（控）又は開発中止届書（控））を保存する場合は、治験届書等のオンライン提出後、PMDA における受付が完了した際に PMDA から送付される電子メール（以下「受付完了メール」という）及び PMDA に提出した治験届書の写しを保存することで差し支えない。
- ② 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る医薬品等の通関の際における取扱要領」第 2（5）イの治験計画届書（写）については、受付完了メール及び PMDA に提出した治験計画届書の写しを税関に提示することで差し支えない。

〔R4.11.16 薬生薬審発 1116 第 4 号、薬生機審発 1116 第 1 号、薬生監麻発 1116 第 2 号〕

また、令和 5 年 8 月 21 日以降は、審査マネジメント部審査企画課において受け付けた治験届のうち、30 日調査等の対象となる治験届について、当該調査を担当する PMDA 審査部（以下「審査部」という。）からの照会に対する回答及び審査部への差替え資料を提出する場合にもゲートウェイシステムを利用したオンライン提出が可能となった。ただし、PMDA から提出者へのゲートウェイシステム経由のファイル共有はできないため、PMDA からの照会は従前どおりの方法で送付される。

〔R5.8.17 審査マネジメント部文書〕

オンライン提出に関する主な通知、留意点などについては、PMDA ウェブサイトに掲載されている（ホーム>審査関連業務>治験関連業務>治験計画届出制度）。

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0005.html>

ゲートウェイシステムを利用するには、認証局より発行される電子証明書（個人）を取得後、ゲートウェイシステムへのユーザー登録が必要である。具体的な操作は、「申請電子データシ

システム操作マニュアルー申請企業向け共通編ー」（PMDA ウェブサイト申請電子データシステム操作マニュアルダウンロードページ <https://esg.pmda.go.jp/files/manual.html>）の記載に従うこと。なお、予め「申請電子データシステム .NET クライアントアプリケーション」をダウンロードしてインストールしておくこと。「申請電子データシステム .NET クライアントアプリケーション」は以下のページからダウンロードできる。

<https://esg.pmda.go.jp/Ssk/comm001p01.init>

1 オンライン提出の対象

オンライン提出の対象となる治験の計画の届出は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第 269 条、同第 275 条、同第 275 条の 4 に基づく治験計画届書、治験計画変更届書、治験終了届書、治験中止届書及び開発中止届書である。

〔R5.3.22 薬生薬審発 0322 第 1 号、薬生機審発 0322 第 2 号、薬生安発 0322 第 1 号、薬生監麻発 0322 第 2 号〕

なお、審査マネジメント部審査企画課にて受け付けられた治験届について、治験届の受付時の提出方法がゲートウェイシステムを利用したかによらず、審査部から了解が得られた場合は、審査部からの照会に対する回答及び審査部への差替え資料についてもオンライン提出の対象となる。

〔R5.8.17 審査マネジメント部文書〕

2 使用するゲートウェイシステムの機能について

ゲートウェイシステムの「FD 申請対象外の手続」の機能を使用する。具体的には、次頁の図のとおり、「申請・届出ポータル」画面を表示し、〔FD 申請様式外〕タブ、又は〔メニュー〕タブの〔FD 申請形式以外の申請、届出または申出等〕ボタンを選択する（その後の具体的な手順は本冊子の I.4.2.を参照すること）。

〔R5.3.22 薬生薬審発 0322 第 1 号、薬生機審発 0322 第 2 号、薬生安発 0322 第 1 号、薬生監麻発 0322 第 2 号別添〕

又は

メニュー	FD申請／届出等	FD申請（医療用医薬品／再生医療等製品）	FD申請様式外	お知らせ通知	お問い合わせ一覧	管理機能
FD申請形式による申請、届出または申出等 (eCTD／試験データを提出する申請を除く)		フレキシブルディスク（以下「FD」という。）等を用いて行うことができる承認又は許可等に係る申請、届出又は申出の手続きはこちら。 (添付資料をeCTD形式で提出する申請は含まない)				
FD申請形式による申請 (医療用医薬品／再生医療等製品)		主に医療用医薬品や再生医療等製品の承認申請等、eCTD形式または試験データを添付資料として提出する際の手続きはこちら。				
FD申請形式以外の申請、届出または申出等		FD申請様式の定めのない申請、届出または申出等の手続きはこちら。				
お知らせ通知		行政機関からのお知らせ通知を表示します。				
お問い合わせ一覧		グループ内でのお問い合わせ一覧を表示します。				
管理機能		パスワード変更などのユーザ管理機能や、送信テスト機能を利用する画面を表示します。				

3 オンライン提出について

治験計画届書等は、オンライン提出することが望ましい。

〔R5.3.22 薬生薬審発 0322 第 1 号、薬生機審発 0322 第 2 号、薬生安発 0322 第 1 号、薬生監麻発 0322 第 2 号別添〕

審査部からの照会に対する回答及び差替え資料は、従前どおり電子メール又は電子媒体（CD-R 若しくは DVD-R）による提出も可能であるが、審査部の了解を得ることでオンライン提出することも可能である。その場合、ゲートウェイシステムを介した資料の授受を確実に行うことができるよう、提出予定（時期、資料内容等）を審査部の主担当と事前に確認すること。

〔R5.8.17 審査マネジメント部文書〕

4 オンライン提出時の受付時間、提出方法等について

オンライン提出時の受付時間、提出方法等については、「治験計画等の届出の取扱い（申請電子データシステムを利用したオンライン提出）の留意点について（令和 5 年 3 月 30 日付け審査マネジメント部文書）」及び「30 日調査等の対象となる治験計画等の届出に係る担当審査部による照会に対する回答等の提出時（申請電子データシステムを利用したオンライン提出）の留意点について（令和 5 年 8 月 17 日付け審査マネジメント部文書）」を参照すること。

1. ゲートウェイシステムにおける「提出日時」、治験届書の届出年月日、PMDA の受付年月日及び受付完了メールの送付日、30 日調査の起算開始日について

ゲートウェイシステムを利用したオンラインによる治験計画届等の届出について、ゲートウェイシステムはメンテナンス等による停止時間を除き 24 時間 365 日利用できる。

<https://esg.pmda.go.jp/files/operation-time.pdf>

審査マネジメント部が受付可能と判断した治験届書について、PMDA での受付年月日及び PMDA より送付する受付完了メールの送付日は、下表のとおりとなる。16：00～23：59 にオンライン提出された治験届書について、審査マネジメント部は翌営業日に確認及び受付処理を行う。

ゲートウェイシステムにおける「提出日時」	治験届書における届出年月日	PMDA の受付年月日及び受付完了メールの送付日
当日の 0：00～当日の 15：59	当日	当日
当日の 16：00～当日の 23：59	当日	翌営業日

治験届書の届出年月日に記載する年月日は、届出日の当日とすること（当日以外の日付〈翌営業日、翌々営業日等〉は記載しないこと）。

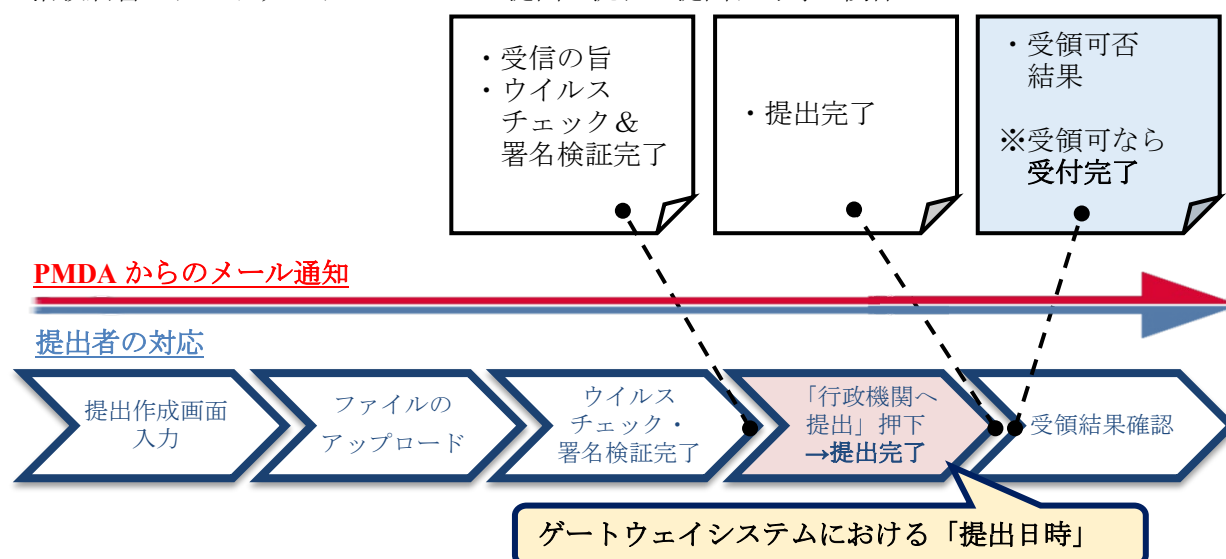
ゲートウェイシステムにおける「提出日時」は、下図に示すとおり、「行政機関へ提出」ボタンを押下し提出が完了した日時となり、「ファイルのアップロード」、「署名検証完了日時」ではないことに留意すること。

ウイルスチェック、署名検証等に時間がかかる場合もあるため、時間に余裕をもってオンライン提出すること。

30 日調査は、「受付年月日」ではなく、「治験届書における届出年月日」から起算される。例えば、下表のパターン②のように 2023 年 4 月 7 日（金）の 16：00～23：59 にオンライン提出した 30 日調査対象の治験届書については、「PMDA の受付年月日」である 2023 年 4 月 10 日（月）ではなく、30 日調査は、「治験届書における届出年月日」である 2023 年 4 月 7 日（金）から起算される。

以上の治験届書のゲートウェイシステムでの提出の流れと提出完了日時及び提出日時パターン別 PMDA の受付年月日と 30 日調査起算開始日の関係を次頁に示す。

＜治験届書のゲートウェイシステムでの提出の流れと提出日時等の関係＞



		ゲートウェイシステム における「提出日時」	治験届書における 届出年月日	PMDA の 受付年月日 及び 受付完了メール の送付日	30 日調査起算開始日 (30 日調査対象の 治験届書の場合)
パターン	①	2023 年 4 月 7 日 (金) の 0 : 00～15 : 59	2023 年 4 月 7 日 (金)	2023 年 4 月 7 日 (金)	2023 年 4 月 7 日 (金)
	②	2023 年 4 月 7 日 (金) の 16 : 00～23 : 59	2023 年 4 月 7 日 (金)	2023 年 4 月 10 日 (月)	2023 年 4 月 7 日 (金)

2. 提出方法

「申請書等のオンライン提出に係る取扱い等について」（令和 5 年 3 月 22 日付け薬生薬審発 0322 第 1 号、薬生機審発 0322 第 2 号、薬生安発 0322 第 1 号、薬生監麻発 0322 第 2 号）に従い、ゲートウェイシステムを利用して、電子ファイルで提出すること。具体的なオンライン提出の操作は、「申請電子データシステム操作マニュアル申請・届出者向け オンライン申請・届出編（FD 申請様式外）」（PMDA ウェブサイト申請電子データシステム操作マニュアルダウンロードページ <https://esg.pmda.go.jp/files/manual.html>）の記載に従うこと。

1 回のオンライン提出あたり 1 つの届出とすること（1 回のオンライン提出時に複数の届出をまとめて提出しないこと）。

具体的な手順：

治験届の提出、審査部への差替えまたは照会に対する回答の提出の手順は共通するところが多い。そのため、共通の手順を【共通の手順】、異なる手順をそれぞれ【治験届書の提出】、【審査部への差替え、照会に対する回答の提出】と表記し以降区別する。なお、【審査部への差替え、照会に対する回答の提出】の手順を行う場合、ゲートウェイシステムを介した資料の

提出予定（時期、資料内容等）については審査部の主担当に事前に確認しておくこと。

(1) [共通の手順]

ゲートウェイシステムにログインし、「申請・届出ポータル」画面を表示し、[メニュー] タブの [FD 申請形式以外の申請、届出または申出等] ボタン又は、[FD 申請様式外] タブを選択し、[新規提出作成へ] ボタンをクリックする。

ログアウト
ようこそ、プロジェクトA
製薬 花子さん
前回ログイン時刻: 2021/12/24 11:58

お問い合わせはこちら

メニュー FD申請/届出等 FD申請 (医療用医薬品/再生医療等製品) FD申請様式外 お知らせ通知 お問い合わせ一覧 管理機能

FD申請形式による申請、届出または申出等 (eCTD/試験データを提出する申請を除く) フレキシブルディスク（以下「FD」という。）等を用いて行うことができる承認又は許可等に係る申請、届出又は申出の手続きはこちら。
(添付資料をeCTD形式で提出する申請は含まない)

FD申請形式による申請 (医療用医薬品/再生医療等製品) 主に医療用医薬品や再生医療等製品の承認申請等、eCTD形式または試験データを添付資料として提出する際の手続きはこちら。

FD申請形式以外の申請、届出または申出等 FD申請様式の定めのない申請、届出または申出等の手続きはこちら。

お知らせ通知 行政機関からのお知らせ通知を表示します。

お問い合わせ一覧 グループ内でのお問い合わせ一覧を表示します。

管理機能 パスワード変更などのユーザ管理機能や、送信テスト機能を利用する画面を表示します。

申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）ー（ver.1.7）より引用

ログアウト
ようこそ、プロジェクトA
製薬 花子さん
前回ログイン時刻: 2022/02/24 17:45

お問い合わせはこちら

メニュー FD申請/届出等 FD申請 (医療用医薬品/再生医療等製品) **FD申請様式外** お知らせ通知 お問い合わせ一覧 管理機能

新規提出作成へ

検索条件

提出名称

状況 ☒ 提出前 ☒ 提出済 ☐ 終了 ☐ 取消済 GW受付番号

手続きの分類1

手続きの分類2

検索結果件数 ☐ 1000件を超えても検索を続ける

検索

提出一覧

1件 状況について

状況	通知	GW受付番号	提出名称	手続きの分類

申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）ー（ver.1.7）より引用

(2) [共通の手順]

「提出作成＜入力＞」画面にて、次表を参考に「提出情報」の各項目に入力し、内容を確認し、[確認画面へ] ボタンをクリックする。

[治験届書の提出]

「提出名称」	「提出名称」に記載された内容と、オンライン提出した資料の内容に齟齬がある場合、受付不可となる可能性があるので注意すること。 i) 治験計画届書、治験終了届書、治験中止届書の場合 「主たる被験薬の治験成分記号※_届出回数_届出分類**_【届出者名】」 例：TYK-123_03_S_【東薬製薬】 ii) 治験計画変更届書の場合 「主たる被験薬の治験成分記号※_届出回数_届出分類**_変更回数_【届出者名】」 例：TYK-123_03_H_14_【東薬製薬】 iii) 開発中止届書の場合は、届出回数を「00」とする。 「被験薬の治験成分記号※_00_届出分類**_【届出者名】」 例：TYK-123_00_END_【東薬製薬】 ※機械器具等又は加工細胞等の場合は、主たる被験薬の治験成分記号の代わりに主たる被験機器又は主たる被験製品の治験識別記号を記載すること。 ※※届出分類は以下のとおり。 治験計画届書：K 治験計画変更届書：H 治験終了届書：S 治験中止届書：C 開発中止届書：END
「提出者名」	● 提出担当者は、ゲートウェイシステムを操作して届出の提出を行う者であり、治験届書の届出担当者と別の者を設定することでも差支えない。なお、差替え又は受付不可について PMDA から電話連絡を行う場合は、提出担当者宛でなく治験届書の届出担当者宛に行うので、治験届書の届出担当者欄には必ず連絡がつく担当者及び電話番号を記載すること。 ● オンライン提出の提出担当者と治験届書の届出担当者が異なる場合は、連携ができる体制としておくこと。 [R5.2.6 開催「改正医薬品医療機器等法関連通知及び治験届オンライン提出説明会」] ● 治験届書の届出者等と契約関係にある者（例えば行政書士や CRO、選任製販業者等）がゲートウェイシステムを利用し、当該契約関係にある者自身のユーザーアカウントで、オンライン提出に関する作業を代行することは可能であるが、代行する者が交代する場合に備えて、ゲートウェイシステムには治験届書の届出者等の名義でグループを作成し、その中に代行する者のユーザーを登録する等の形態を取ることが

	望ましい。なお、この場合において代行する者が当該グループのユーザー管理者となることで差し支えない。 〔R3.8.31 届出等のオンライン提出に関する質疑応答集（Q&A）について Q3・A3〕
「手続き分類 1」	「医薬品治験届」、「機器治験届」又は「再生治験届」を選択する。
「手続き分類 2」	「治験計画届」、「治験計画変更届」、「治験終了届」、「治験中止届」、「開発中止届」又は「その他」を選択する。
「提出窓口」	「手続き分類 1」及び「手続き分類 2」を選択することで「提出窓口」は自動的に入力される。
「備考（通信欄）」	「初めてヒトに投与する薬物に係る治験の計画の届出時における非臨床安全性試験の最終報告書の提出について」（R1.6.20 薬機審長発第 0620003 号）の対象となる治験届書を提出する場合は、提出する非臨床安全性試験の最終報告書のファイル数を「備考（通信欄）」に記載すること。

[審査部への差替え、照会に対する回答の提出]

「提出名称」	「提出名称」には受付番号（ない場合は省略）、治験成分記号/治験識別記号、審査部及び審査部主担当者名を必ず入れること。同一の治験届について複数回の資料提出を行う場合には必要に応じて、資料の詳細、提出回数、提出日等を提出名称に入れること。 i) 差替えの場合 「受付番号（ない場合は省略）_治験成分記号/治験識別記号_審査部名_審査部主担当氏名」 例：2099-XXXX_TYK-123_新薬審査第〇部_〇〇 ii) 照会に対する回答の場合 「受付番号（ない場合は省略）_治験成分記号/治験識別記号_照会回答●回目_提出日_審査部名_審査部主担当氏名」 例：2099-XXXX_TYK-123_照会回答 2 回目_20yyymmdd_新薬審査第〇部_〇〇
「提出者名」	提出担当者は、ゲートウェイシステムを操作して資料の提出を行う者であり、届書の届出担当者と別の者を設定することでも差し支えない。
「手続き分類 1」*	「医薬品治験届」、「機器治験届」又は「再生治験届」を選択する。
「手続き分類 2」*	「担当部署への提出（受付済みの治験届が対象）」を選択する。
「手続き分類 3」*	「担当分野/領域/部室等」を選択する。
「提出窓口」	該当する審査部を選択する。

*：手続き分類を間違えた場合には提出先の部署で適切に資料を受領することができないため、十分に注意すること。

入力 確認 完了

プロジェクトA
製薬 花子さん

提出作成

提出情報の概要登録を行ってください。

お問い合わせはこちら

GW受付番号		提出者名	X製薬
提出名称	ABC案件に伴う提出	提出担当者	製薬 花子
電話番号	0312345678	FAX番号	0312345677
メールアドレス	seiyaku-hanako@pmda.go.jp		
手続き分類1	1004:医薬品治験届		
手続き分類2	2021:治験計画届		
提出窓口	51:総合機構	3:審査マネジメント部	
備考(通信欄)			

戻る 確認画面へ

申請電子データシステム操作マニュアル申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）－（ver.1.7）より引用
注：「提出名称」、「手続き分類」、「提出窓口」については実際の治験届書の提出画面と異なる（上図参照）

(3) [共通の手順]

表示される「申請・届出等作成<確認>」画面の内容を確認し、[実行] ボタンをクリックする。確認メッセージが表示されるので、申請・届出等を作成する場合は[OK] ボタンをクリックする。

入力 確認 完了

プロジェクトA
製薬 花子さん

提出作成

提出情報の概要登録を行ってください。

お問い合わせはこちら

GW受付番号		提出者名	X製薬
提出名称	ABC案件に伴う提出	提出担当者	製薬 花子
電話番号	0312345678	FAX番号	0312345677
メールアドレス	seiyaku-hanako@pmda.go.jp		
手続き分類1	1004:医薬品治験届		
手続き分類2	2021:治験計画届		
提出窓口	51:総合機構	3:審査マネジメント部	
備考(通信欄)			

戻る 実行

申請電子データシステム操作マニュアル申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）－（ver.1.7）より引用
注：「提出名称」、「手続き分類」、「提出窓口」については実際の治験届書の提出画面と異なる（上図参照）

(4) [共通の手順]

[メニュー] タブの [FD 申請形式以外の申請、届出または申出等] ボタン又は、[FD 申請様式外] タブを選択し、提出一覧から、電子ファイルをアップロードしたい提出名称のリンクをクリックする。

ログアウト
ようこそ、プロジェクトA
製薬 花子さん
前回ログイン時刻 2022/02/24 17:45

PMda 医薬品医療機器総合機構 申請電子データシステム

申請・届出ポータル

お問い合わせはこちら

メニュー FD申請/届出等 FD申請（医薬用医薬品/再生医療等製品） **FD申請様式外** お知らせ通知 お問い合わせ一覧 管理機能

新規提出作成へ

検索条件

提出名称

状況 ☒ 提出前 ☒ 提出済 ☐ 終了 ☐ 取消済

GW受付番号

手続きの分類1

手続きの分類2

検索結果件数 ☐ 1000件を超えても検索を続ける

検索

提出一覧

1件 状況について

10件 50件 100件

状況	通知	GW受付番号	提出名称	手続きの分類
提出前		2121358444000	ABC案件に伴う提出	1004:医薬品治... 2021:治験計画届

修正へ

申請電子データシステム操作マニュアル申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）－（ver.1.7）より引用
注：「提出名称」については実際の治験届書の提出画面と異なる（上図参照）

(5) [共通の手順]

「提出詳細（提出者）」画面が表示されたら、内容を確認し、[ファイル登録へ] ボタンをクリックする。

提出詳細（提出者）

項目	内容	項目	内容
GW受付番号	212135844000	提出番号	X製薬
提出名称	ABC案件に伴う提出	提出担当	製薬 花子
電話番号	0312345678	FAX番号	0312345677
メールアドレス	seiyaku-hanako@pmda.go.jp		
手続きの分類1	1004：医薬品治療薬		
手続きの分類2	2021：治験計画届		
提出窓口	S1：PMDA		

備考(提出者)

3：審査マネジメント部

ファイル登録へ 取消へ 担当者が設定へ 修正

検索条件

項目	内容	件名	通知日
提出	☒ 未読のみ ☐ 既読のみ ☐ 全件		
重要度	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低		

通知一覧

表示するデータがありません。

戻る 画面再表示

申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）ー（ver.1.7）より引用
注：「提出名称」、「手続き分類」、「提出窓口」については実際の治験届書の提出画面と異なる（上図参照）

(6) [共通の手順]

[ファイル登録へ] ボタンをクリックすると確認画面が表示される。[申請電子データシステム FD 申請様式外.NET クライアントアプリケーションを開く] をクリックする。

申請電子データシステム FD申請様式外.NETクライアントアプリケーションを開きますか？

https://esg.pmda.go.jp がこのアプリケーションを開く許可を求めています。

☐ esg.pmda.go.jp でのこのタイプのリンクは常に関連付けられたアプリで開く

申請電子データシステム FD申請様式外.NETクライアントアプリケーションを開く キャンセル

申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）ー（ver.1.7）より引用

(7) [共通の手順]

「FD 申請様式外 ファイルアップロード」画面が表示される。アップロードするフォルダーをフォルダー欄にドラッグ&ドロップするか、[選択] ボタンをクリックして、ファイルアップロードするフォルダーを選択する。

<提出するファイルの準備及びファイルアップロード時の注意点>

・PDF 形式で提出するものについては、スキャンにより作成した画像ではなく、テキスト情報を

含んだ PDF ファイルを作成すること。

[R5.3.30 審査マネジメント部文書]

- ・ 提出するファイル名は、基本通知の別添 2 に従うこと (p82 参照)。

[R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号 別添 2 [一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、
R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号]]

- ・ 提出ファイルのアップロードできるファイルサイズの上限は、1 ファイルあたり 1 GB、1 回の送信あたり 10 GB である。提出する電子媒体は、原則、zip ファイルでまとめて提出すること。
Zip ファイルのファイル名は「提出名称」と同一にすること (ゲートウェイシステムにファイルをアップロードする際、ファイルでなくフォルダーを指定することになるが、そのフォルダー名についての規定等は特にない) 。Zip ファイルにまとめると 1 GB を超える場合は、1 ファイルごと提出することで差支えない。なお、1 ファイルあたり 1 GB を超えるファイルを提出する場合、又は 1 回の送信の合計ファイルサイズが 10 GB を超える場合は、事前に審査マネジメント部審査企画課に連絡し、指示を仰ぐこと。

[R5.3.30 審査マネジメント部文書]

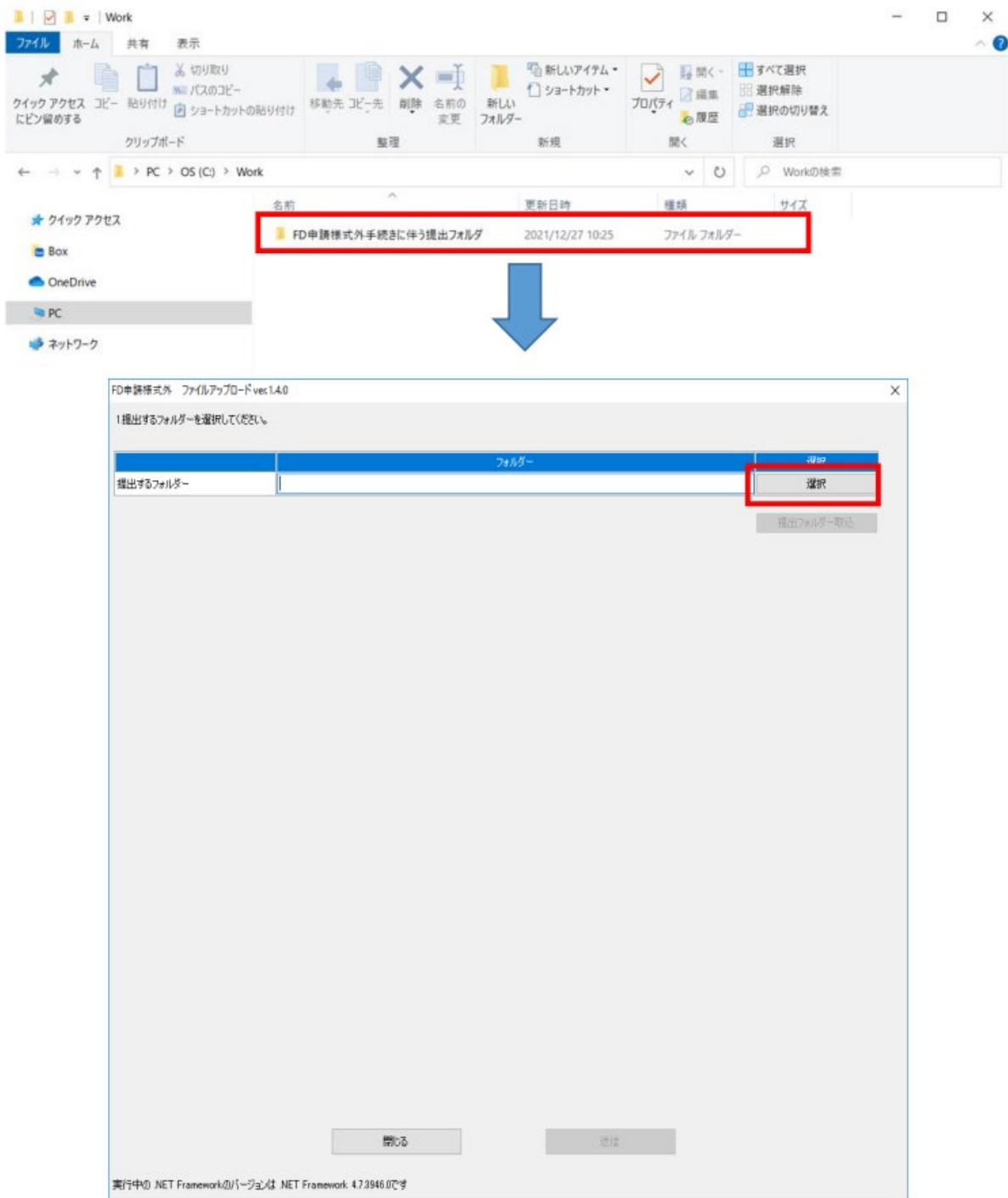
- ・ ファイルのアップロードは複数回に分けず 1 回にまとめて行うこと。PMDA へ提出する前にファイルの不足又は不備が認められた場合は、すべてのファイルを削除した上で、再度アップロードし直すこと。

[R5.3.30 審査マネジメント部文書]

- ・ zip ファイル内のフルパス (総文字数) は 199 文字以内とすること、ファイルアップロードできない拡張子、使用できないファイル名のルール等、その他の提出ファイルの注意点については、「申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編 (FD 申請様式外) ー」の「提出ファイルの注意点」及び「申請書等のオンライン提出に係る取扱い等について」 (令和 5 年 3 月 22 日付け薬生薬審発 0322 第 1 号、薬生機審発 0322 第 2 号、薬生安発 0322 第 1 号、薬生監麻発 0322 第 2 号) 別添の「オンライン提出に係る電子ファイル作成等要領 2. 全体的な留意事項 (1) 電子ファイルに関する事項」を参照のこと。
- ・ 提出完了後 (=終了後) に提出者側でファイルの追加・修正・削除、提出の取消を行うことはできない。提出は、提出情報や提出するファイルに誤りが無いことを十分に確認の上、行うこと。提出後に不備や誤りに気付いた場合、具体的な手順は (18) <注意点>を参照すること。

【事例】

- ・ 提出名称欄には入力可能だがファイル名や zip ファイル名には使用できない記号等がある。治験成分記号に「/」が含まれている場合に zip ファイル名に「/」を省略して名称をつけ、「提出名称」欄にも zip ファイル名と同一の名称を入力して提出したところ、PMDA より、提出名称欄には「/」が入力可能であるため入力するようにして欲しいと指摘があった。



申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）－（ver.1.7）より引用
注：「フォルダー名」については実際のものと異なる

(8) [共通の手順]

選択したフォルダーに間違いがないことを確認し、[提出フォルダー取込] ボタンをクリックする。

FD申請様式外 ファイルアップロード ver.1.4.0

1. 提出するフォルダーを選択してください。

提出するフォルダー	フォルダー	選択
	C:\Work\FD申請様式外手続きに伴う提出フォルダ	選択

提出フォルダー取込

申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）－（ver.1.7）より引用
注：「フォルダー名」については実際のものと異なる

(9) [共通の手順]

「提出フォルダー取込」ボタンをクリックすると、選択したフォルダー内に存在するファイル、自身のパソコンに保存してある個人証明書が表示される。内容を確認し、[送信] ボタンをクリックする。[送信] ボタンをクリックすると、ユーザー登録時にゲートウェイシステムに登録した個人証明書と一致しているかチェックが行われる。不一致の場合は、エラーメッセージが表示されるので、個人証明書の選択を変更してからファイルアップロードを行うこと。

FD申請様式外 ファイルアップロード ver.1.4.0

1. 提出するフォルダーを選択してください。

提出するフォルダー	フォルダー	選択
	C:\Work\FD申請様式外手続きに伴う提出フォルダ	選択

提出フォルダー取込

2. ファイル説明を入力してください。

ファイル名	ファイル種別
提出ファイル_01 .pdf	
提出ファイル_02 .pdf	
提出ファイル_03 .pdf	
提出ファイル_04 .zip	
提出ファイル_05 .zip	

3. 使用する電子証明書を選択してください。

発行機関	発行名	発行者	企業名	組織	氏名	有効期限
☒	Medicertified TYPE...	THE MEDICAL INF...	THE MEDICAL INF...	Medicertified TYPE...		2023/03/04
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						

閉じる 送信

申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）－（ver.1.7）より引用
注：「フォルダー名」及び「zip ファイル名」については実際のものと異なり「zip ファイル名」は「提出名称」と同一にする
注：治験届書の提出ファイルは原則 zip ファイル 1 件のみとなる
（詳細は手順 (7) の＜提出するファイルの準備及びファイルアップロード時の注意点＞参照）

(10) [共通の手順]

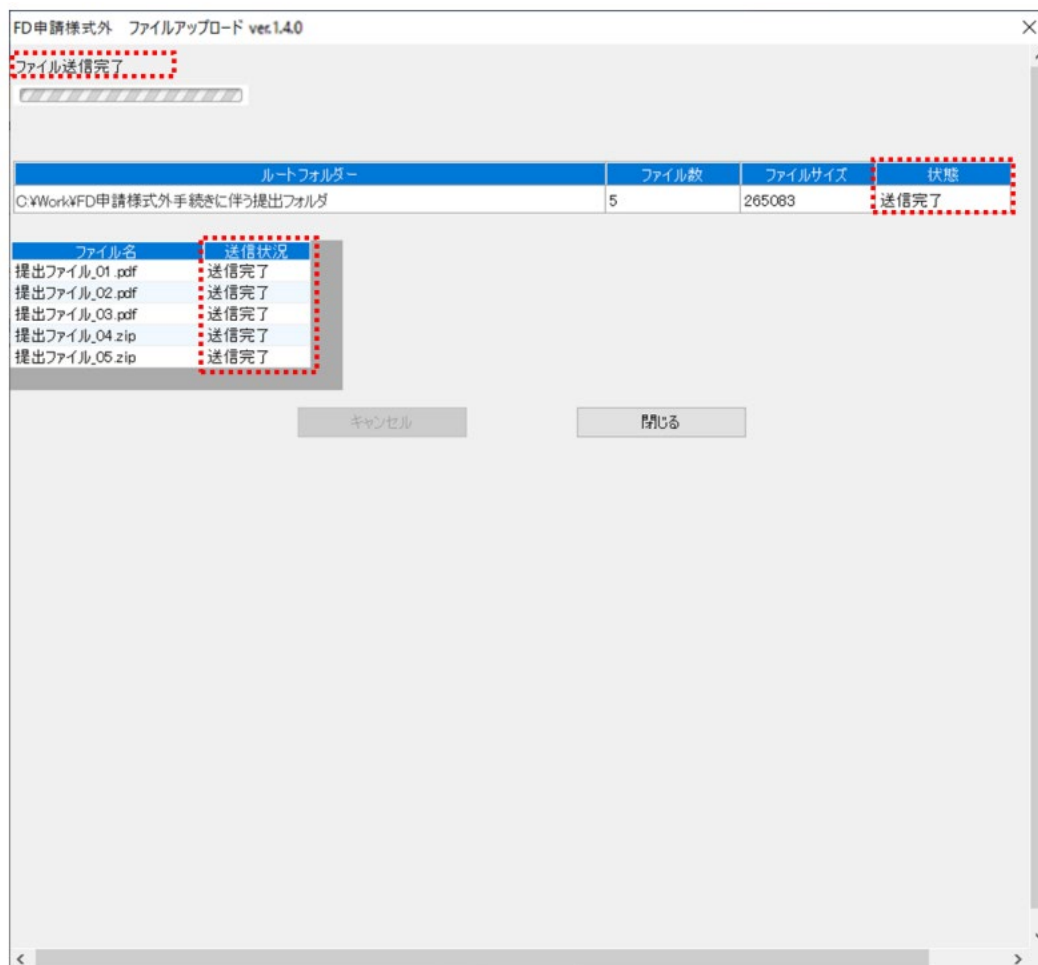
個人証明書が一致していると、確認メッセージが表示されるので問題がなければ「はい」ボタンをクリックする。



申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）－（ver.1.7）より引用

(11) [共通の手順]

ファイル送信が開始され、完了するとルートフォルダー内の各ファイルの送信状況が更新される。またすべての送信が完了したら、ルートフォルダーの状態が「送信完了」、ステータスバー上の表示がファイル送信完了となる。



申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）－（ver.1.7）より引用

注：「フォルダー名」については実際のもとは異なる治験届書の提出ファイルは原則 zip ファイル 1 件のみとなる
（詳細は手順 (7) の<提出するファイルの準備及びファイルアップロード時の注意点>参照）

(12) [共通の手順]

ファイルのアップロードが完了すると、確認メッセージが表示されるので、[はい] ボタンをクリックし「ファイルアップロード」画面を閉じる。

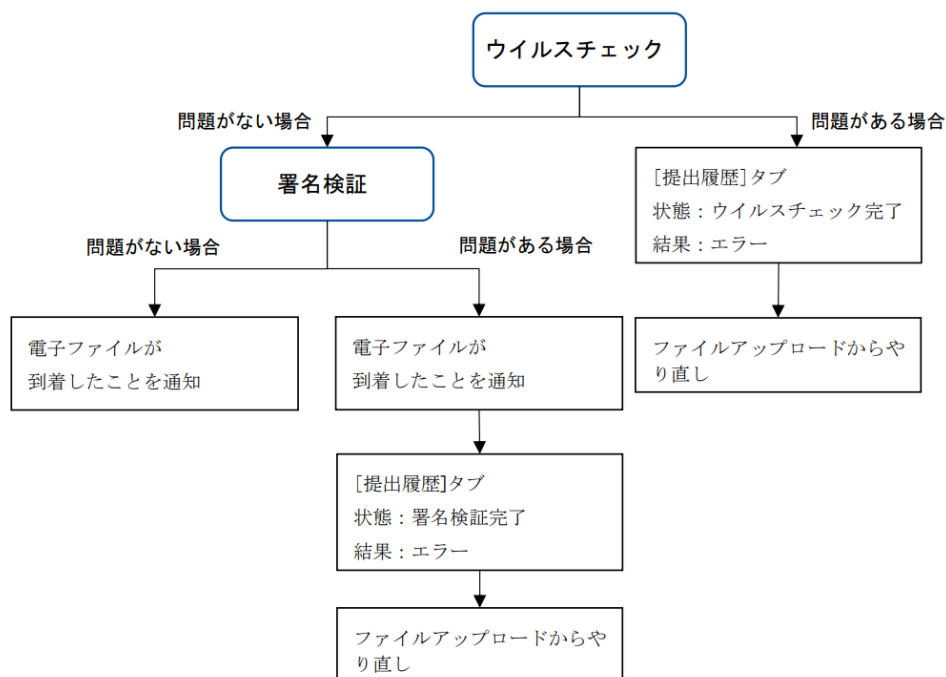


申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）ー（ver.1.7）より引用

(13) [共通の手順]

ファイルアップロード後、ゲートウェイシステム内で電子ファイルのウイルスチェック、署名検証が行われる。チェック結果は、同じグループの提出担当者全員に対して通知される。

（通知は、メールと「提出詳細（提出者）」画面の[通知]タブに表示される。）各チェックによって問題があった場合は、ファイルアップロードからやり直す。また、[提出履歴]タブで、ゲートウェイシステムを利用してオンライン提出した電子ファイルの提出状態を確認することができる。[提出履歴]タブをクリックすることで、提出状態の表示内容を更新することができる。ファイルアップロード後のチェックの流れを次に示す。



申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）ー（ver.1.7）より引用

(14) [共通の手順]

署名検証まで完了すると「提出詳細（提出者）」画面の「通知」タブからウイルスチェック結果通知が確認できる。

提出詳細（提出者）

GW受付番号: 2121358444000
提出名称: ABC案件に伴う提出
電話番号: 0312345678
メールアドレス: setyaku-hanako@pmda.go.jp
手続済の分類1: 1004: 医薬品治験届
手続済の分類2: 2021: 治験計画届
提出窓口: 51: PMDA
備考(添付欄): 3: 審査マネジメント部

通知 | 提出履歴

通知一覧

通知ID	通知日時	通知内容	通知種別
1	2021/12/27 14:15:58	「ABC案件に伴う提出」の提出に対する、受信、ウイルスチェックおよび署名検証が完了したことを、ご連絡いたします。	ウイルスチェック結果通知

通知詳細

通知ID: 1
通知日時: 2021/12/27 14:15:58
通知種別: ウイルスチェック結果通知

「ABC案件に伴う提出」の提出に対する、受信、ウイルスチェックおよび署名検証が完了したことを、ご連絡いたします。

FD申請様式外提出情報
FD申請様式外提出名称: ABC案件に伴う提出
FD申請様式外提出者名: X製薬
GW受付番号: 2121358444000

詳しくは、「FD申請様式外提出詳細」画面の「提出履歴」タブにて必ず結果確認をお願いします。
なお、結果がエラーの場合は再送信をお願いします。
再送信ができない場合は、ヘルプデスクまでご連絡ください。

申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）ー（ver.1.7）より引用
注：「提出名称」については実際の治験届書の提出画面と異なる（上図参照）

(15) [共通の手順]

各ファイルの状態は「提出履歴」タブから確認できる。

提出詳細（提出者）

GW受付番号: 2121358444000
提出名称: ABC案件に伴う提出
電話番号: 0312345678
メールアドレス: setyaku-hanako@pmda.go.jp
手続済の分類1: 1004: 医薬品治験届
手続済の分類2: 2021: 治験計画届
提出窓口: 51: PMDA
備考(添付欄): 3: 審査マネジメント部

通知 | **提出履歴**

提出履歴

ファイル名	ファイル説明	状態	結果	署名検証完了日時	提出状態	提出日時	受信状況	受信可否結果入力メモ
提出ファイル_01.pdf	ファイル種別01	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済		受付済	
提出ファイル_02.pdf	ファイル種別02	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済		受付済	
提出ファイル_03.pdf	ファイル種別03	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済		受付済	
提出ファイル_04.zip	ファイル種別04	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済		受付済	
提出ファイル_05.zip	ファイル種別05	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済		受付済	

申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）ー（ver.1.7）より引用
注：「提出名称」については実際の治験届書の提出画面と異なる（上図参照）
注：治験届書の提出ファイルは原則 zip ファイル 1 件のみとなる
（詳細は手順 (7) の＜提出するファイルの準備及びファイルアップロード時の注意点＞参照）

(16) [共通の手順]

「提出詳細（提出者）」画面（「提出詳細（提出者）」画面の表示方法は手順（4）を参照のこと）で申請・届出等の内容と各ファイルのチェックが完了していることを確認し、[行政機関へ提出] ボタンをクリックする。

提出情報

GW受付番号	212135844000	提出者名	X製薬
提出名称	ABC薬品に係る提出	提出担当	製薬 花子
提出番号	0312345678	FAX番号	0312345677
メールアドレス	seiyaku-hanako@pmda.go.jp		
手続の分類1	1004：医薬品治療		
手続の分類2	2021：治験計画		
提出種別	51：PMDA		
備考(提出者)			

ファイル登録へ 取消へ 担当者設定へ 修正

通知 提出履歴一覧

ファイル名	ファイル説明	状態	結果	署名検証完了日時	提出状態	提出日時	受領状況	受領可否結果入力メモ	削除
提出ファイル_01.pdf	ファイル種別01	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済		受付済		削除
提出ファイル_02.pdf	ファイル種別02	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済		受付済		削除
提出ファイル_03.pdf	ファイル種別03	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済		受付済		削除
提出ファイル_04.zip	ファイル種別04	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済		受付済		削除
提出ファイル_05.zip	ファイル種別05	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済		受付済		削除

戻る 画面再表示

行政機関へ提出

申請電子データシステム操作マニュアル申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）－（ver.1.7）より引用
注：「提出名称」については実際の治験届書の提出画面と異なる（上図参照）
注：治験届書の提出ファイルは原則 zip ファイル 1 件のみとなる
（詳細は手順（7）の＜提出するファイルの準備及びファイルアップロード時の注意点＞参照）

(17) [共通の手順]

確認メッセージが表示され、提出を行う場合は [OK] ボタンをクリックする。提出を行わない場合は [キャンセル] ボタンをクリックし、手順（16）に戻る。

申請電子データシステム操作マニュアル申請・届出者向けオンライン申請・届出編（FD 申請様式外）－（ver.1.7）より引用

(18) [共通の手順]

確認メッセージにて [OK] ボタンをクリックすると、行政機関への提出が完了となる。提出が完了すると [提出履歴] タブの [提出状態] が提出済となり、[提出日時] に提出した日時が設定される。また提出が完了すると、提出担当者にメール通知が配信される。

<注意点>

- 署名検証完了後、提出完了後及び受領可否判定後にはそれぞれメール通知が配信されるほか、「提出詳細（提出者）」画面の [通知] タブにも各種通知が表示される。[提出履歴] タブからは提出者による提出状況や PMDA による受領状況の確認が可能である。これらの情報を踏

まえ、オンライン提出の状況を適切に把握すること。

[治験届書の提出]

- 一度オンライン提出した治験届書について、追加のファイル登録は避けること。一度オンライン提出した治験届書について、届出者側で不備に気づいた場合には、「取消へ」ボタンや「修正」ボタンの押下は行わず、必ず審査マネジメント部審査企画課に対応を問い合わせること。

[審査部への差替え、照会に対する回答の提出]

- 提出完了後に提出情報や提出ファイルに誤りがあったことに気が付いた場合、次の①～③の対応が考えられるが、審査部主担当者により個別に指示がある場合は指示に従うこと。
 - ① 「手続きの分類」、「提出窓口」を間違えた場合、審査部主担当者に連絡し、間違いの内容、GW 受付番号を伝える。PMDA 側で提出物の確認が可能か、再提出が必要かを確認する。
 - ② 「手続きの分類」、「提出窓口」以外の、「提出名称」、「アップロードする提出物」等に間違いがあった場合は、審査部主担当者に間違いの内容を電話またはメール等により連絡する。必要に応じて新規案件として再提出等を行う。
 - ③ 追加の提出物がある場合は、新規案件として提出する。その際、追加提出であることが分かるように、提出名称や備考（通信欄）に説明を記載する。
- 審査部からの照会に対する回答、差替え資料の提出は「提出と同時に終了する手続き」である。提出先の行政機関による受領可否判断は行われない。また、行政機関から提出者への差戻しも行われない。

[R5.3.30 審査マネジメント部文書、R5.8.17 審査マネジメント部文書]

 医薬品医療機器総合機構 申請電子データシステム

提出詳細 (提出者)

ログアウト
ようこそ、プロジェクトA
製薬 花子さん
前回ログイン時刻 2022/02/24 15:33

お問い合わせはこちら

提出情報	提出者名	X 製薬
GW 受付番号	212135844000	
提出名称	ABC 案件に伴う提出	提出担当者
電話番号	0312345678	FAX 番号
メールアドレス	seiyaku-hanako@pmda.go.jp	0312345677
手続きの分類	1004 : 医薬品治験届	
手続きの分類	2021 : 治験計画届	
提出窓口	51 : PMDA	3 : 審査マネジメント部
備考(通信欄)		

ファイル登録へ 取消へ 担当者設定へ 修正

提出窓口へ問い合わせ

通知 提出情報

提出情報一覧

ファイル名	ファイル説明	状態	結果	署名検証完了日時	提出日時	提出日	受領状況	受領可否結果入力メモ
提出ファイル_01.pdf	ファイル種別01	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済	2021/12/27 15:12:23	受付済	
提出ファイル_02.pdf	ファイル種別02	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済	2021/12/27 15:12:23	受付済	
提出ファイル_03.pdf	ファイル種別03	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済	2021/12/27 15:12:23	受付済	
提出ファイル_04.zip	ファイル種別04	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済	2021/12/27 15:12:23	受付済	
提出ファイル_05.zip	ファイル種別05	署名検証完了	OK	2021/12/27 14:15:58	提出済	2021/12/27 15:12:23	受付済	

戻る 画面再表示

行政機関へ提出

申請電子データシステム操作マニュアルー申請・届出者向けオンライン申請・届出編 (FD 申請様式外) - (ver.1.7) より引用
注 : 「提出名称」については実際の治験届書の提出画面と異なる (上図参照)
注 : 治験届書の提出ファイルは原則 zip ファイル 1 件のみとなる
(詳細は手順 (7) の<提出するファイルの準備及びファイルアップロード時の注意点>参照)

3. 審査マネジメント部への差替えについて

審査マネジメント部審査企画課における受付段階で資料の差替えが必要と判断した場合は、同課から治験届書の届出担当者へ電話連絡を行う。

差替え資料をオンライン提出する際には、当該治験届書の提出にあたりゲートウェイシステム上で発番されたゲートウェイ受付番号（以下、「GW 受付番号」という。）と同じ GW 受付番号の提出詳細（提出者）画面から、[ファイル登録へ] ボタンを押下し、差替えの資料を登録すること。備考（通信欄）には、差替え資料の提出であることがわかるように記載すること。

差替え資料のファイル名は、「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」（令和 2 年 8 月 31 日付け薬生薬審発 0831 第 10 号 [一部改正 令和 4 年 8 月 31 日付け薬生薬審発 0831 第 1 号、令和 5 年 3 月 30 日付け薬生薬審発 0330 第 3 号]）等の通知に従うこと※。なお、30 日調査等での照会対応に伴い差替えが生じる場合は、担当審査部から指示された方法に従って差替え資料を提出すること。

※差替えの場合は資料情報に続けてバージョン番号を記載する。1 回目の差替え時には「1」を設定し、差し替えるごとに番号を 1 つずつ大きくすること。差替えの場合には、差替えファイルのみを記録することで差し支えない。

例：初回提出「TYK-123_01_K_P.pdf」、差替え 1 回目「TYK-123_01_K_P1.pdf」

[R5.3.30 審査マネジメント部文書]

【事例】

- ・ 審査マネジメント部として治験届書及び添付資料を受領できるかどうかにより、以下の 2 つのパターンで指示に従い、資料の差替えを行った。

【パターン 1（PMDA として治験届書及び添付資料を受理できると判断されたが資料の差替えは必要であった場合）】

提出⇒「受領可のお知らせ」メールの受領⇒差替え指示⇒差替え資料提出（なお、差替え資料提出後の「受領可のお知らせ」メール配信等の当局からの受領連絡はなし）

【パターン 2（PMDA としてファイル名の誤り等で受領可とする前に資料の差替えが必要とされた場合）】

提出⇒差替え指示⇒差替え資料提出⇒「受領可のお知らせ」メールの受領

4. 受付不可について

[治験届書の場合]

受付不可の場合は、PMDA から受付不可の連絡（治験届書の届出担当者への電話連絡又はゲートウェイを介した受領不可連絡）を下表のとおり行う。当日の 16:00～当日の 23:59 にオンライン提出された治験届書について、審査マネジメント部は翌営業日に確認し、翌営業日に受付不可の連絡を行う。なお、受付不可の場合、PMDA ではゲートウェイシステムの差戻し機能は利用しない。

ゲートウェイシステムにおける「提出日時」	治験届書における届出年月日	PMDA からの受付不可の連絡日
当日の 0:00～当日の 15:59	当日	当日
当日の 16:00～当日の 23:59	当日	翌営業日

受付不可の連絡を受けた場合には、新たな GW 受付番号にて再提出を行うこと。具体的には、「I.4.2.提出方法」の (1) 以降の手順に従い、[メニュー] タブの [FD 申請形式以外の申請、届出または申出等] ボタン又は、[FD 申請様式外] タブを選択し、[新規提出作成へ] ボタンをクリックし、再提出を行う。

PMDA から受付不可の連絡を翌営業日に受けた場合、又は PMDA から受付不可の連絡を当日に受けたが当日中に再提出できない場合は、治験届書の届出年月日は改めて提出する届出年月日を記載し、新たな GW 番号にて提出すること（例えば、翌営業日に改めてオンライン提出する場合、治験届書の届出年月日を翌営業日に修正し提出すること。）

[R5.3.30 審査マネジメント部文書]

[審査部への差替え、照会に対する回答の場合]

受領可否判断は行われない。また、提出者への差戻しも行われない。

5. 問い合わせについて

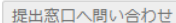
1) 差替え又は受付不可等に伴い審査マネジメント部審査企画課へ問い合わせる場合

電話又はゲートウェイシステムの「提出詳細（提出者）」画面の [提出窓口へ問い合わせ]

 ボタンを押下することで、治験問い合わせメールアドレス（tiken-toiawase@pmda.go.jp）宛に問い合わせを行うことが可能である。なお、ゲートウェイシステムに関する問い合わせは、審査マネジメント部審査企画課でなくオンラインヘルプデスク宛に問い合わせること。

[R5.3.30 審査マネジメント部文書]

2) 照会回答や差替え資料に伴い審査部へ問い合わせる場合

照会に対する回答、及び差替え資料の提出において、「提出詳細（提出者）」画面の提出窓口へ問い合わせ  ボタンは無いため、提出窓口（審査部）への問合せは電話又は電子メール等により行うこと。

[R5.8.17 審査マネジメント部文書]

3) オンラインヘルプデスク宛へ問い合わせる場合

ゲートウェイシステムの「申請・届出ポータル」画面の右上にある [お問い合わせはこちら](#) ボタンを押下し、必要事項を記載することで問い合わせを行うことができる。システムにログインできない場合は、問い合わせ票に記入の上、<ols_help@pmda.go.jp>宛に連絡すること。提出予定時において、突発的なシステムトラブルにてゲートウェイシステムを利用したオンライン提出ができない場合は、オンラインヘルプデスク宛に問い合わせを行い、可能な限りゲートウェイシステムのトラブル解決を試みる。ゲートウェイシステムのトラブルを速やかに解決できず、かつ当日中に届出が必要な場合は、受付時間内に審査マネジメント部審査企画課へ問い合わせを行い、その指示を仰ぐこと。

〔R5.2.6 開催「改正医薬品医療機器等法関連通知及び治験届オンライン提出説明会」〕

〔R5.3.30 審査マネジメント部文書〕

6. 受付完了メールについて

〔治験届書の場合〕

PMDA が受付可能と判断した治験届書について、下図に例として示した受付完了メールが送付される（PMDA より送付する受付完了メールの送付日は、I. 4 1.の表（p8）を参照すること）。

受付完了メールの受領をもって、通常に受付が完了したと判断すること。

治験届書をオンライン提出したにもかかわらず受付完了メールが I. 4 1.の表で示した「PMDA より送付する受付完了メールの送付日」中に届かない場合は、その送付日の翌営業日に審査マネジメント部審査企画課に問い合わせること。なお、受付完了メールの送付時刻は当日の治験届書の届出件数等によって変動するため、受付完了メールが来ていないことについて、I. 4 1.の表で示した「PMDA より送付する受付完了メールの送付日」中に審査マネジメント部審査企画課に問い合わせることは控えること。

受付完了メールへは返信しないこと（受付完了メールを受信した旨の連絡等）。受付完了メールに関する問合せがある場合は、審査マネジメント部審査企画課（tiken-toiawase@pmda.go.jp）に問い合わせること。

〔R5.3.30 審査マネジメント部文書〕

<受付完了メールの文例>

申請電子データシステム：【提出名称】受領可のお知らせ

【提出名称】FD 申請様式外提出担当者様

いつも『申請電子データシステム』をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

【提出名称】の提出に対する、受領可否結果をご連絡いたします。

FD 申請様式外提出情報

〔FD 申請様式外提出名称〕 【提出名称】

〔FD 申請様式外提出者名〕 東薬製薬

[GW 受付番号] 1234567890123

[提出ファイル名] ◆◆

[結果] 受領可

[補足メッセージ] 受付年月日：yyyy/mm/dd 受付番号※：20●●●-●●●●●

詳しくは、「ポータル」画面の「FD 申請/届出等以外」タブにて必ず結果確認をお願いいたします。

本メールにお心当たりのない場合、お手数ですがヘルプデスク<ols_help@pmda.go.jp>までご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

【利用規約】

<<<https://esg.pmda.go.jp/files/terms-of-use.pdf>>>

※ PMDA が治験届書を受け付けた際に発番する番号

[審査部への差替え、照会に対する回答の場合]

審査部からの照会に対する回答、及び差替え資料の提出に対する受付完了メールは送付されない。

Ⅱ. 治験計画届書

1 治験計画の届出の対象

- ・本書において「治験」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「薬機法」という。）第2条第17項に規定するとおり、薬機法第14条第3項（同条第15項及び第19条の2第5項において準用する場合を含む。）の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。

- ・治験の依頼をしようとする者が、薬機法第80条の2第2項及び第80条の3第4項並びに規則第268条の規定により、PMDAにその計画を届け出なければならない治験は、平成9年3月27日薬発第421号（以下「局長通知」という。）第8の3の（1）のアからカに示す被験薬に係る治験であること（ただし、イからカに示す被験薬について生物学的同等性試験を行う場合を除く。）。また、治験の計画等の届出は被験薬の数によらず、原則として治験実施計画書ごとに届け出ること。原則1つの治験実施計画書（プロトコール）に対して1通の治験計画を届け出ること。

ア 日本薬局方に収められている医薬品及び既製造販売承認医薬品と有効成分が異なる薬物

イ 日本薬局方に収められている医薬品及び既製造販売承認医薬品と有効成分が同一の薬物であって投与経路が異なるもの

ウ 日本薬局方に収められている医薬品及び既製造販売承認医薬品と有効成分の配合割合、効能、効果、用法又は用量が異なる薬物（ア及びイに示すもの並びに医療用以外の医薬品として製造販売承認申請を行うことを予定しているものを除く。）

エ 日本薬局方に収められている医薬品及び既製造販売承認医薬品と有効成分が異なる医薬品として製造販売の承認を与えられた医薬品であってその製造販売承認のあった日後再審査期間を経過していないものと有効成分が同一の薬物

オ 生物由来製品であることが見込まれる薬物（アからエまでに示すものを除く。）

カ 遺伝子組換え技術を応用して製造される薬物（アからオまでに示すものを除く。）

〔H9.3.27 薬発第421号、H15.5.15 医薬発第0515017号〕

- ・被験薬、治験使用薬の定義と考え方は以下のとおりである。被験薬を含む治験使用薬が治験副作用等報告の対象である。

① 被験薬*

被験薬とは、治験の対象とされる薬物であり、当該治験の試験成績をもって当該薬物の製造販売承認申請を目的とするものを指す。主たる被験薬とは、治験計画届出時に被験薬が1つの場合にはその被験薬を指し、複数の被験薬がある場合には、治験依頼者が選択した1つの被験薬を指す。また、当該治験の試験成績をもって製造販売承認申請を目的とする医

療機器（以下「被験機器相当」という。）及び再生医療等製品（以下「被験製品相当」という。）は、基本通知の「被験薬」と同様の取扱いとすること。

* 治験計画届書に記載された薬物のうち、主たる被験薬の他、併用する薬物等であっても製造販売承認申請を要するものを含む。

② 治験使用薬

治験使用薬とは、治験実施計画書において被験薬の有効性及び安全性の評価に使用することを規定された被験薬、対照薬、併用薬、レスキュー薬、前投与薬等を指す。なお、治験使用薬は、その有効成分の国内外での承認の有無は問わない。

また、治験実施計画書において被験薬の有効性及び安全性の評価に使用することを規定された医療機器（以下「治験使用機器相当」という。）及び再生医療等製品（以下「治験使用製品相当」という。）についても、基本通知の「治験使用薬」と同様の取扱いとすること。

・ 以下①、②のようなマスタープロトコールを使用した治験の場合においても 1 通での治験届出が可能である。

① バスケット型マスタープロトコールを使用した治験

単一の治療法を用いた複数の疾患を対象とした試験（例：ある分子標的型抗がん剤について、臓器横断的な効果を検証する試験）であり、単一の治療法の有効性等の検証を、複数の疾患を対象に同時並行的に進めることができる。治験実施中に判明した内容を踏まえ、プロトコールの目的の追加、プロトコールの計画変更等は治験計画変更届出で対応できる。

② アンブレラ型マスタープロトコールを使用した治験

単一の疾患に対する複数の治療法を対象とした試験（例：肺癌について、バイオマーカー別に個別の治療法を検討する試験）であり、1 つの共通部分のあるプロジェクトに登録された患者が、個別の治験に割り振られる。

〔R3.6.8 開催 医薬品医療機器等法改正説明会資料〕

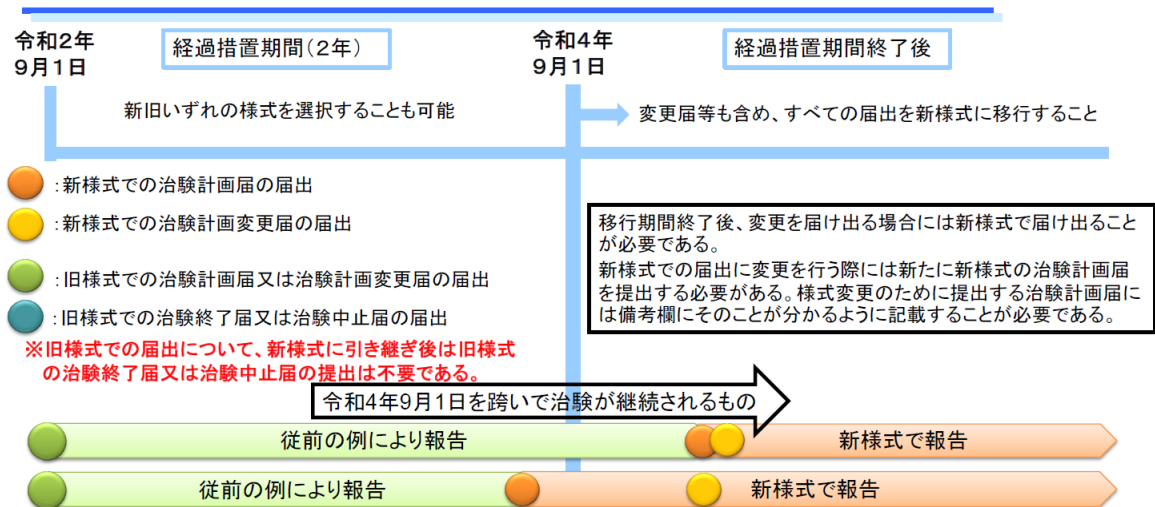
・ 局長通知により、従来の体外診断用医薬品の臨床試験は「臨床性能試験」に改められ、体外診断用医薬品は薬機法第 80 条の 2 の治験の対象から除外され、治験計画の届出の対象にはならない。

〔H9.3.27 薬発第 421 号〕

・ 抗悪性腫瘍薬について、抗悪性腫瘍薬ガイドラインに基づいた第 III 相試験（延命効果を中心に評価する臨床試験）又は第 III 相試験のための予備試験（併用療法により第 III 相試験を実施するための予備試験等）を承認申請後に開始する場合であっても、薬機法第 80 条の 2 第 2 項に基づく治験計画の届出を行うこと等、治験として所要の手続きを採ること。また、当該医薬品の承認日以降に第 III 相試験を開始する場合には、承認までに当該試験の実施計画書（又はその骨子）を PMDA に提出すること。個別品目の提出時期については、PMDA の指示に従うこと。

- 基本通知に従った様式（新様式）は、令和 2 年 9 月 1 日以降に届け出る治験届について適用される。
- 令和 4 年 9 月 1 日を跨いで治験が継続される場合、治験届の様式切り替えについては以下の点に留意する。
 - 経過措置期間終了後、変更を届け出る場合には、新様式での治験計画変更届を提出する必要がある。
 - 平成 25 年 5 月 31 日に発出された治験届に係る通知に従った様式（旧様式）から新様式での届出に変更する際には、新たに新様式での治験計画届を提出する必要がある。様式変更のために提出する治験計画届には備考欄にそのことが分かるよう記載する。
- 経過措置期間終了後、治験終了届又は治験中止届のみを提出する場合のみ、旧様式で届出を提出することは可能である。

治験届の切り換えのタイミングと副作用等報告について



[R3.6.8 開催 医薬品医療機器等法改正説明会資料]

2 治験計画届書の提出時期等

1. 30 日調査対象の治験計画届書

- ・「30 日調査」とは、薬機法第 80 条の 2 第 3 項にある、「治験の対象とされる薬物等につき初めて同項の規定による届出をした者に対し、厚生労働大臣が行う、当該届出に係る治験の計画に関し保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な調査」をいう。厚生労働大臣が定める届出をした治験依頼者は、厚生労働大臣への届出をした日から起算して 30 日経過した後でなければ、治験を医療機関に依頼してはならないこととされており、必要な調査の全部又は一部を PMDA に行わせることができることとされている。

PMDA ウェブサイト（ホーム>審査関連業務>治験関連業務>治験計画届出制度）より一部改変

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0005.html>

- ・30 日調査の対象となる薬物については、局長通知第 8 の 4 により通知されたところであるが、次の点に留意すること。

30 日調査の対象となる薬物は、次に示す被験薬に係る治験の計画のうち、当該被験薬を本邦において初めて人に投与するものであること。

- ① 既承認医薬品等と有効成分が異なる薬物（なお、マイクロドーズ臨床試験を利用した場合には、マイクロドーズ臨床試験以降の試験が該当する。）
- ② 既承認医薬品等と有効成分が同一の薬物であって投与経路が異なるもの（投与経路が同じであっても、例えばナノ技術を応用すること等で徐放化等の薬剤学的な変更により用法等を異にすることを目的とした新たな剤形の薬物のうち、有効成分を内包する等の製剤設計により有効成分の体内分布や標的部位への移行性が大きく異なると想定されるものを含む。）
- ③ 既承認医薬品等と有効成分の配合割合が異なる薬物（①及び②に示すもの、類似処方医療用配合剤として製造販売承認申請を行うことを予定しているもの並びに医療用以外の医薬品として製造販売承認申請を行うことを予定しているものを除く。）

〔R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号〔一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号〕〕

- ・治験計画届書の提出時期については、原則として次によること。

ア 当該届出に係る治験の計画が 30 日調査の対象となるものについては、実施医療機関との予定契約締結日の少なくとも 30 日以上前に届け出ること。なお、当該届出をした日から起算して 30 日を経過した後でなければ治験の契約を締結してはならないこと。

イ 当該届出に係る治験の計画が「「医薬品の臨床試験及び製造販売承認申請のための非臨床安全性試験の実施についてのガイダンス」について」（平成 22 年 2 月 19 日付け薬食審査発 0219 第 4 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）で定義されているマイクロドーズ臨床試験に該当する場合においては、実施医療機関との予定契約締結日の少なくとも 30 日程度前を目安として届け出ることとし、当該被験薬物に係る治験についてマイクロ

ドーズ臨床試験以降初めて届け出る治験の計画が 30 日調査の対象となること。

- ウ 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売承認（外国製造販売承認等を含む。）を与えられている医薬品（以下「既承認医薬品等」という。）と有効成分及び投与経路が同一であるが、例えばナノ技術を応用すること等で徐放化等の薬剤学的な変更により用法等を異にすることを目的とした新たな剤形の薬物のうち、有効成分を内包する等の製剤設計により有効成分の体内分布や標的部位への移行性が大きく異なると想定される薬物を用いた治験を届け出る場合には、上記アと同様に治験の計画を届け出ること。
- エ 上記ア～ウ以外の治験計画届書については、実施医療機関との予定契約締結日の少なくとも 2 週間程度前を目安として届け出ること。ただし、当該届出に係る治験の計画が第 I 相試験等に該当する場合においては、その届出時期についてあらかじめ PMDA に相談することが望ましい。

- ・ 移行性が異なるように設計されている場合は、原則として、基本通知の記の 1. (6) ①ウに該当する薬物であると考え。しかし、薬物動態に影響を及ぼさない軽微な変更等では該当しない場合もあるので、判断に迷う場合、詳細については、PMDA に相談することが可能である。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q13・A13〕

- ・ 「「医薬品の臨床試験及び製造販売承認申請のための非臨床安全性試験の実施についてのガイダンス」について」（平成 22 年 2 月 19 日付け薬食審査発 0219 第 4 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）に示されているアプローチ 3 以降の早期探索的臨床試験の後に引き続いて行う第 I 相試験等に該当する場合においては、その届出時期についてあらかじめ PMDA に相談することが望ましい。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q14・A14〕

- ・ 5 月連休や年末年始の前においては、30 日調査期間を勘案して早めに届書を提出するよう、「治験計画届等の提出に関するお願い」が PMDA より発信される。PMDA ウェブサイトを参照のこと。

（ホーム>審査関連業務>治験関連業務>治験計画届出制度>治験計画届書等の受付業務について）

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0021.html>

2. 「1. 30 日調査対象の治験計画届書」以外の治験計画届書

- ・ 実施医療機関との予定契約締結日の少なくとも 2 週間程度前を目安として届け出ること。

【事例】

- ・ 同一薬物について本邦で 30 日調査対象の初回の治験と第 2 回の治験をほぼ同時期に行う場合、30 日調査対象の初回治験計画届と対象外の治験計画届書の提出時期について

PMDA（担当審査部及び審査マネジメント部）に相談することが望ましい。状況により、下記のような対応をするよう指示を受けた。

- 30 日調査が終了するまで第 2 回治験計画届（以降）の届は提出しない
 - 30 日調査が終了する 2 週間程度前に第 2 回治験計画届（以降）の届を提出する
 - 複数の治験計画届書を同時に提出するが、第 2 回治験計画届以降の届書について「30 日調査での指摘事項を第 2 回治験計画届以降の届書に反映させる、30 日調査終了まで第 2 回治験計画届以降の届書にかかる治験を開始しない」との内容を記載した念書を添付する
- ・ 30 日調査対象の初回治験計画届と第 2 回の治験計画届を同時に提出する場合の「念書」について審査マネジメント部に確認したところ、「初回治験計画届で資料の差替えが必要とされた場合には、その内容が第 2 回治験計画届にも該当する場合には、同じく差替えを行う」ことについても記載するよう連絡を受けた。なお、念書の差出人と宛先は、届書が代表者から PMDA 理事長宛に提出されるものであるため、それに倣って念書も代表者から PMDA 理事長宛としていることが多い。
 - ・ 30 日調査・n 回治験計画届（第 2 回以降の治験計画届）の調査にかかわらず、PMDA から調査の完了に係る連絡はないが、担当の新薬審査部へ問い合わせると状況を確認することができる。
 - ・ n 回治験計画届に関しても、照会事項が発出されることはある。まれに、調査期間を過ぎて照会事項が発出されることがあり、その際は、治験開始（医療機関との契約）への影響等、適宜、PMDA 担当者と相談しながら対応した。
 - ・ 年末及びゴールデンウィーク前に n 回治験計画届を提出したところ、通常の 14 日間よりも長い調査期間（例：21 日間、営業日で 14 日間、等）を求められた。
 - ・ 30 日調査対象外であれば「実施医療機関との予定契約締結日の少なくとも 2 週間程度前を目安として届け出ること」とされているが、予定契約締結日の 12 日前（予定契約締結日を含まず）に提出したところ受付不可とされた。

3. 緊急に実施する治験において治験開始後 30 日以内に治験計画の届出を行う場合

- ・ 「薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平成 15 年 5 月 15 日付け医薬発第 0515017 号厚生労働省医薬局長通知）Ⅲの（2）のアの③に規定する緊急に実施する治験において治験開始後 30 日以内に治験計画の届出を行う場合は、治験開始日までに、当該局長通知の別紙様式 1 を利用し、医薬局医薬品審査管理課に第一報の連絡をすること。なお、治験計画の届出以前に変更がある場合には、適宜連絡すること。
- ・ 緊急に実施する治験とは以下のいずれにも該当する治験である。
 - ①被験者の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある疾患その他の健康被害の防止のために緊急に使用されることが必要な薬物*であり、かつ、当該薬物の使用以外に適当な方法がないこと。
 - ②その用途に関し、本邦と同等の水準にあると認められる医薬品の承認制度等を有する国にお

いて承認されているものであること。

③当該薬物について、既に他の治験の計画の届出がなされ、本邦で実施されていること。

* 救急の医療において用いられる薬物その他医療上緊急に必要と認められるもの

〔H15.5.15 医薬発第 0515017 号、H15.6.12 医薬審発第 0612004 号〕

4. その他

- ・人又は動物由来の細胞・組織を加工（薬剤処理、生物学的特性改変、遺伝子工学的改変等をいう。）した医薬品又は医療機器（以下「細胞・組織加工医薬品等」という。）に係る治験の依頼をしようとする者は、従前、「細胞・組織を利用した医療用具又は医薬品の品質及び安全性の確保について」（H11.7.30（H22.11.1 改正、H23.8.31 廃止）医薬発第 906 号）により、治験計画の届出を行う前に、厚生労働大臣に当該治験薬又は治験機器の安全性及び品質の確認を求める必要があったが、平成 23 年 7 月 1 日よりレギュラトリーサイエンス（RS）戦略相談に代替されることとなった。

〔H23.6.30 薬食発 0630 第 2 号、H23.6.30 薬機発第 0630007 号〕

- ・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15 年法律第 97 号。以下「カルタヘナ法」という。）の対象となる遺伝子組換え生物等を含有し又は遺伝子組換え生物等から構成される医薬品の第一種使用等（遺伝子組換え生物等の拡散を防止しないで行う使用等）をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の第一種使用等に関する規程を定め、カルタヘナ法第 4 条に基づき、厚生労働大臣及び環境大臣の承認を受けなければならないこと。カルタヘナ法の対象となる遺伝子組換え生物等を用いて医薬品等を製造する業者は、カルタヘナ法第 13 条に基づき、あらかじめ厚生労働大臣による第二種使用等の承認を受けなければならないこと。ただし、GILSP 遺伝子組換え微生物告示により規定された GILSP 遺伝子組換え微生物を用い、拡散防止措置省令により定められている拡散防止措置を執って製造を行う場合はこの限りではないこと。

〔H16.2.19 薬食発第 0219011 号、H28.7.14 薬生発 0714 第 2 号、R3.9.30 薬生発 0930 第 5 号、R3.11.25 薬生発 1125 第 1 号、R4.2.3 薬生薬審発 0203 第 1 号、薬生機審発 0203 第 1 号〕

3 治験計画届書の作成に関する一般的注意事項

- ・主な通知、Q&A などについては、PMDA ウェブサイトに掲載されている（ホーム>審査関連業務>治験関連業務>治験計画届出制度>医薬品（薬物））。

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0004.html>

- ・治験届出における「参照する治験届出情報」の取扱い、改正薬機法関連通知の追加説明事項及び治験計画等の届出の取扱い（申請電子データシステムを利用したオンライン提出）の留意点について製薬協ウェブサイトにて解説されている。

https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/message/online_submission_briefing_20230206.htm

1

- ・治験届の受付において多く見られる不備事項のチェックリストが PMDA ウェブサイトに掲載されているので、届出前に確認すること（ホーム>審査関連業務>治験関連業務>治験計画届出制度>治験計画届書等の受付業務について）。

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0021.html>

（チェックリスト） <https://www.pmda.go.jp/files/000244166.xlsx>

- ・抗悪性腫瘍剤分野及びバイオ品質分野の 30 日調査照会事項チェックリストが PMDA ウェブサイトに掲載されているので、届出前に確認すること（ホーム>審査関連業務>治験関連業務>治験計画届出制度>医薬品（薬物）>30 日調査照会事項チェックリスト）。

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0024.html>

（抗悪性腫瘍剤分野） <https://www.pmda.go.jp/files/000252155.pdf>

（バイオ品質分野） <https://www.pmda.go.jp/files/000252156.pdf>

1. 様式

- ・基本通知に基づく様式で届け出る場合は、様式等のバージョン情報にその旨入力すること。
- ・治験計画届書、治験計画変更届書、治験中止届書、治験終了届書について原則として同一様式とし、該当する事項について入力、記載すること。
- ・XML 文書の構造定義（スキーマ）については、基本通知の別添 3 によること。なお、PMDA ウェブサイトからの入手も可能である。

〔R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号〔一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号〕〕

- ・治験計画届書の大きさは、日本産業規格（JIS）A4 とする。添付資料についても A4 版とする。
〔H15.5.15 医薬発第 0515017 号〕

2. 届書の記載に関する一般的事項

- ・PMDA 理事長宛に提出すること。

[H16.3.25 薬食発第 0325013 号]

- ・該当する内容がない場合は、空欄とすること。
- ・届出事項のうち年月日を届け出るものについては、西暦を用いることとし、半角数字 8 桁 (YYYYMMDD) で入力すること。

[R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号 [一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号]]

- ・記載事項のすべてを所定欄に記載出来ない場合には別紙を添付する。その場合、当該欄に「別紙 () のとおり」と記載し、届書添付資料欄に該当する資料名を記載する。
- ・生物由来製品であることが見込まれる薬物については、生物由来製品に係る薬機法の規定を踏まえ、使用者に対する説明と理解、製造・使用に係る記録の保存等の措置に関して治験の計画の届出に明示し、臨床試験の実施の基準に従い、被験者が適切な補償を受けられるよう措置を講じておくこと。

[H15.5.15 医薬発第 0515017 号]

3. 添付資料の作成に関する一般的事項

- ・添付資料については、届出の種類*に応じ、原則として次によること。

* 届出区分：30 日調査対象の届書は「1」、基本通知の記の 1. (6) ①エ及び②ウに該当する届書は「2」

(1) 30 日調査対象となる届書 (届出区分「1」に該当) に添付すべき資料

- 1) 当該治験の依頼を科学的に正当と判断した理由を記した文書
- 2) 治験実施計画書
- 3) インフォームド・コンセントに用いられる説明文書及び同意文書
(複数の実施医療機関で同じ内容のものが用いられる場合には、そのうちの一つを添付することで差し支えないこと。)
- 4) 症例報告書の見本 (治験実施計画書において、症例報告書に記載すべき事項が十分に読み取れる場合は、提出は不要であること。)
- 5) 最新の治験薬概要書 (ただし、治験の依頼をしようとする者が、複数の被験薬を用いる治験を実施する場合で、自らが製造販売する予定の被験薬と併用するものの、他社が製造販売している等の理由で、治験薬概要書を準備出来ない場合は、本邦で既承認の有効成分であり、治験の依頼をしようとする者が当該被験薬を治験に用いるにあたり被験薬の安全性を担保出来ると考える場合に限り、当該被験薬の治験薬概要書に代わり、当該被験薬の最新の科学的知見を記載した文書 (添付文書、インタビューフォーム、学術論文等) とすることで差し支えない。)。なお、学術論文等を提出する場合は、概略をまとめた文書もあわせて添付すること。
- 6) 被験薬以外の治験使用薬に係る最新の科学的知見を記載した文書 (添付文書、インタビューフォーム、学術論文等)。なお、学術論文等を提出する場合は概略をまとめた文書

もあわせて添付すること。

※科学的知見を記載した文書に該当する文書が本邦既承認製剤の添付文書の場合、届書添付資料の備考欄に、その旨入力することで、添付は要しない。海外の添付文書が英語以外の言語の場合は、日本語訳を添付すること。科学的知見を記載した文書に該当する文書がインタビューフォームの場合、届書添付資料の欄に、「科学的知見を記載した文書に該当する文書（インタビューフォーム）」と記載すること。また、当該文書そのものを添付すること。科学的知見を記載した文書に該当する文書が学術論文等の場合、届書添付資料の欄に、「科学的知見を記載した文書に該当する文書（学術論文等）」と記載すること。また、必要な情報を取りまとめた文書を作成し、根拠となった学術論文等とともに添付すること。

- 〔R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号〔一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号〕、R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q19・A19、Q20・A20〕
- 7) 説明文書に動画等が含まれる場合、スクリーンショットやスクリプト（台本）等、その内容が把握できる文書を PDF 形式で添付すること。なお、動画等が参考資料に含まれ、治験計画届出者が治験依頼者である場合、動画等の内容が把握できる文書を PDF 形式で添付することは任意である。
- 〔R5.3.30 事務連絡 薬物、機械器具又は加工細胞等に係る治験の計画の届出に関する質疑応答集（Q&A）について Q1・A1〕

被験薬については、必要に応じて次の資料を添付すること。

- 8) （バイオテクノロジー応用医薬品等は対象外）：DNA 反応性（変異原性）不純物の評価及び管理に関する資料（ICH-M7）
- 〔R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号〔一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号〕、H27.11.10 薬生審査発 1110 第 3 号〔一部改正 H30.6.27 薬生薬審発 0627 第 1 号〕〕
- 9) （バイオテクノロジー応用医薬品・ワクチンの場合）：株化された細胞を用いて製造されるタンパク質性医薬品等の品質に関する資料
- 株化された細胞を用いて製造されるタンパク質性医薬品等の治験薬の 30 日調査時には、当該被験薬に特有の公衆衛生上の観点等も踏まえて調査を行うため、①被験薬の製造フロー図、②セルバンクが感染性物質（細菌、真菌、マイコプラズマ、ウイルス（セルバンクがヒト又は動物細胞の場合））に汚染されていないか、③精製前の培養液が細菌、真菌、マイコプラズマ、迷入ウイルス等の病原体によって汚染されていないか、④ヒト又は動物由来原材料を使用している場合は、生物由来原料基準への適合性、⑤被験薬製造で動物細胞又は生物由来の原材料が使用されている場合は、被験薬のウイルス安全性、⑥不純物の除去状況、原薬及び製剤の規格試験のうち、安全性に関する試験（目的物質由来不純物や製造工程由来不純物に関する試験、無菌試験、不溶性異物検査、不溶性微粒子試験、エンドトキシン試験等）の暫定規格等を確認している。そのため、初回治験

計画書の届出時には、参考資料としてこれらの情報を必要に応じ別途添付すること。

[R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答 (Q&A) の改正について Q27・A27]

10) (初めてヒトに投与する薬物に係る治験計画届※の場合) : 非臨床安全性試験の最終報告書

初めてヒトに投与する薬物に係る治験計画届出時は、非臨床安全性試験（毒性試験及び安全性薬理試験）の最終報告書（最終報告書が英語で記載されている場合は日本語訳の必要はないが、英語以外の外国語で記載されている場合は日本語訳が必要）を提出する。対象となる治験計画届書においては、届書添付資料に関する備考欄に、非臨床安全性試験の最終報告書を提出すること（最終報告書を提出しない場合には提出を不要と判断した理由）を記載する（p65 参照）。オンライン提出する場合、提出する非臨床安全性試験の最終報告書のファイル数を「備考（通信欄）」に記載すること。

※対象となる治験計画届：国内及び海外において、いかなる投与経路においてもヒトに投与した実績が無い薬物に係る治験計画届かつ 30 日調査の対象となるものが対象。海外で先行して投与が開始される予定がある、又は海外でヒトに投与された実績がある等の状況であっても、届出の段階で、届出者としてヒトに投与した際の安全性に関する具体的な情報を入手していない場合も対象となる。

[R1.6.20 薬機審長発第 0620003 号、薬機審長発第 0620004 号、R5.3.30 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 審査マネジメント部 治験計画等の届出の取扱い（申請電子データシステムを利用したオンライン提出）の留意点について]

【事例】

- ・ 国際共同治験で用いる被験薬以外の治験使用薬について、国内の施設では国内流通品を使用しているが、治験使用薬の SUSAR が現地の当局報告対象になっている国が試験実施国に含まれる。そのため SmPC あるいは USPI を治験届の最新の科学的知見を記載した文書として記載し、安全性参照文書として統一して用いることで、報告対象症例及び伝達対象症例に国による相違がないよう運用してよいか審査マネジメント部に確認し、問題ないことを確認した。
- ・ 現在国内でのみ実施している治験であるが、将来的にグローバル展開する可能性のある治験で用いられている被験薬以外の治験使用薬の安全性参照文書について、国内治験のみ実施している時期から海外添付文書（SmPC、USPI 等）を設定することは可能であるか、審査マネジメント部に確認したところ、科学的知見を記載した文書（SF）は、国内流通品を使用する場合、国内添付文書を利用するのが大前提だが、USPI や SmPC を SF としても、国内添付文書から不足はなく、最新の情報が反映された SF として、治験依頼者が担保するのであれば、USPI や SmPC を SF とすることを完全に否定するものではない、との回答を得た。
- ・ 被験薬以外の治験使用薬について、治験開始時より重篤副作用の予測性は共同開発先から提供されている英文の治験薬概要書に基づき判断していた。当該治験について、新様式の

治験届を提出する際に、英文の治験薬概要書を添付資料として提出することを審査マネジメント部に確認し受け入れられた。

- 株化された細胞を用いて製造されるタンパク質性医薬品に限らず、ワクチン全般の 30 日調査においても、参考資料として令和 4 年 8 月 31 日付け審査管理課事務連絡「薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について」の Q27・A27 に記載のある品質に関する資料を添付して提出した。
- 届書に添付資料名を「株化された細胞を用いて製造されるタンパク質性医薬品等の品質に関する資料」と記載し、実際の添付資料の表題を「XX の品質に関する補足資料」としていたところ、届出日当日に審査マネジメント部より同じ資料を指しているかという問い合わせがあった。届書に記載の添付資料名と、実際の添付資料の表題が異なる場合には、添付資料の表題に括弧書きで届書に記載の資料名を付す等し、同じ資料であることがわかるようにとの指示があった。
- コンビネーション製品として捉える医薬品の治験計画届（30 日調査対象）であっても、国内未承認で新規性の高い医療機器であれば治験機器概要書を求められた。届出後に PMDA から指摘されて提出し最終的には受け入れられたが、本来は PMDA に事前確認することが望ましい。また、海外で既承認であるが、本邦で未承認の他社製品を輸入して使用する場合、詳細な資料を入手できないこともあるため、どの程度の資料を概要書として提出するかを PMDA に事前確認することが薦められる。
- 同成分を含有し投与経路が異なる製剤について、主たる被験薬及び従たる被験薬として 1 つの初回治験計画届を提出する場合の「30 日調査対応被験薬区分」について PMDA に確認したところ、主たる被験薬及び従たる被験薬のいずれに対しても「新有効成分」とすること、なお治験薬概要書がそれぞれの投与経路ごとに必要となることに留意すること、との指示を受けた。その他の添付資料についても、それぞれ用意し提出した。通知の事例に従い治験薬概要書のファイル名を付けたところ（例：TYK-123_01_K_IB_A.pdf、TYK-123_01_K_IB_B.pdf）、主たる被験薬及び従たる被験薬の治験薬概要書として同一のものを使用していたことから、いずれのファイルが主たる被験薬又は従たる被験薬に対応した治験薬概要書であるのか判別できないため、主たる被験薬に対応する方の治験薬概要書の表紙に主たる被験薬に対応した治験薬概要書であることがわかるよう追記すること、との指示を受けた。識別を記載した上紙をつけることを提案し、了承された。その後、PMDA から 2 冊は内容が同じものであるか、口頭で確認された。

(2) 30 日調査に該当しない届書（届出区分「2」に該当）に添付すべき資料

- 1) 当該治験の依頼を科学的に正当と判断した理由を記した文書（前回届出以降の新たな試験結果及び情報の概要に関する記述を含むものであること。）
- 2) 治験実施計画書
- 3) インフォームド・コンセントに用いられる説明文書及び同意文書
（複数の実施医療機関で同じ内容のものが用いられる場合には、そのうちの一つを添付することで差し支えないこと。）

- 4) 症例報告書の見本（治験実施計画書において、症例報告書に記載すべき事項が十分に読み取れる場合は、提出は不要であること。）
- 5) 最新の治験薬概要書（ただし、治験の依頼をしようとする者が、複数の被験薬を用いる治験を実施する場合で、自らが製造販売する予定の被験薬と併用するものの、他社が製造販売している等の理由で、治験薬概要書を準備出来ない場合は、本邦で既承認の有効成分であり、治験の依頼をしようとする者が当該被験薬を治験に用いるにあたり被験薬の安全性を担保出来ると考える場合に限り、当該被験薬の治験薬概要書に代わり、当該被験薬の最新の科学的知見を記載した文書（添付文書、インタビューフォーム、学術論文等）とすることで差し支えない。）。なお、学術論文等を提出する場合は、概略をまとめた文書もあわせて添付すること。
- 6) 被験薬以外の治験使用薬に係る最新の科学的知見を記載した文書（添付文書、インタビューフォーム、学術論文等）。なお、学術論文等を提出する場合は、概略をまとめた文書もあわせて添付すること。

〔R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号〔一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、
R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号〕〕

- 7) 説明文書に動画等が含まれる場合、スクリーンショットやスクリプト（台本）等、その内容が把握できる文書を PDF 形式で添付すること。なお、動画等が参考資料に含まれ、治験計画届出者が治験依頼者である場合、動画等の内容が把握できる文書を PDF 形式で添付することは任意である。

〔R5.3.30 事務連絡 薬物、機械器具又は加工細胞等に係る治験の計画の届出に関する
質疑応答集（Q&A）について Q1・A1〕

被験薬については、必要に応じて次の資料を添付すること。

- 8) （バイオテクノロジー応用医薬品等は対象外）：DNA 反応性（変異原性）不純物の評価及び管理に関する資料（ICH-M7）

〔R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号〔一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、
R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号〕、H27.11.10 薬生審査発 1110 第 3 号〔一部改正
H30.6.27 薬生薬審発 0627 第 1 号〕〕

潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中 DNA 反応性（変異原性）不純物の評価及び管理（ICH-M7）ガイドライン関連について

〔H27.11.10 薬生審査発 1110 第 3 号〔一部改正 H30.6.27 薬生薬審発 0627 第 1 号〕〕

1. 対象

- ・ 本ガイドラインは、新原薬及び新製剤について、臨床開発段階及びその後の製造販売承認申請時における指針を示すことを目的としている。本ガイドラインは、市販製品の承認後申請、及び既承認製剤に含まれている原薬を用いた製剤の新規製造販売承認申請に対しても適用されるものの、いずれも以下の場合にのみ適用する。
 - 原薬の合成法の変更により、新規の不純物が生じるか、既存の不純物に対する判定基準が高くなる場合。
 - 製剤処方や組成、製造工程の変更により、新規の分解生成物が生じるか、既存の分解生成物に対する判定基準が高くなる場合。
 - 適応症又は投与方法の変更により、許容される発がんリスクレベルに著しく影響を及ぼす場合。
- ・ 本ガイドラインに示される不純物の変異原性の評価は、次に掲げるものを対象としていない。
 - 生物学的製剤／バイオテクノロジー応用医薬品、ペプチド、オリゴヌクレオチド、放射性医薬品、醗酵生成物、生薬及び動植物由来の医薬品の原薬及び製剤
 - ICH S9（4）の適用範囲において定義されている進行がんを適応症とする医薬品の原薬及び製剤他の適応症についても、原薬が治療濃度で遺伝毒性を有し、発がんリスクの増加を招くことが予想される場合がある。このような場合、変異原性不純物への曝露は、その原薬の発がんリスクを著しく増加させるとは考えられない。したがって、非変異原性不純物に対する許容レベルで不純物を管理できると考えられる。
 - 矯味剤、着色剤、香料、及び既存の市販製品に用いられている医薬品添加剤
 - 製剤の包装に関連する溶出物
- ・ M7 ガイドライン（薬生薬審発 0627 第 1 号）の 2 に記載のある目的から、被験薬以外の治験使用薬を本ガイドラインでは対象としないことで差し支えない。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q25・A25〕

〔平成 28 年 4 月 22 日 第 13 回医薬品評価フォーラム〕

- ・ M7 ガイドラインの 2 で M7 の対象外とされていることが明確なバイオテクノロジー応用医薬品などの場合、資料の添付は不要である。

- ・ 経過措置の適用等により M7 対象外となる場合には、治験計画届の備考欄に添付しない理由を簡潔に記載する。

2. 経過措置

- ・ 本ガイドラインは、平成 28 年 1 月 15 日以降に届け出られる治験の計画の届出に適用される。ただし、本ガイドラインの付録に含まれる「ガイドラインの実施」の趣旨等を踏まえ、以下の経過措置を設けることとする。

(1) 後期第 II 相臨床試験又は第 III 相臨床試験の成績を添付する申請等に係る経過措置

- ・ 新有効成分含有医薬品、新医療用配合剤、新効能医薬品など、後期第 II 相臨床試験又は第 III 相臨床試験の成績を評価資料として添付する申請の場合、当該申請に際して添付すべき資料については、申請に係る評価資料として試験成績が提出される後期第 II 相臨床試験又は第 III 相臨床試験が平成 26 年 7 月 14 日までに開始されている場合に限り、当分の間、本ガイドラインを適用しなくても差し支えない。
- ・ また、前段の申請に際して添付する臨床試験成績に関する資料の収集を目的とする治験の計画の届出に添付する資料についても、当該申請に係る評価資料として試験成績が提出されることが予定される後期第 II 相臨床試験又は第 III 相臨床試験が平成 26 年 7 月 14 日までに開始されている場合に限り、当分の間、本ガイドラインを適用しなくても差し支えない。

3. 資料の位置付け

- ・ M7 ガイドラインの 9 に記載のある DNA 反応性（変異原性）不純物の評価及び管理に関する資料（以下「M7 関連資料」という。）は治験計画届書の参考資料として別途添付することで差し支えない。これらの資料を参考資料として治験計画届書に添付する場合は、治験計画届書の届書添付資料の欄に、資料名「DNA 反応性（変異原性）不純物の評価及び管理に関する資料」として記載すること。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q26・A26〕

4. 資料の内容

- ・ 14 日以内の第 I 相臨床試験については、M7 ガイドラインの 7 で概説している、クラス 1 及びクラス 2 の不純物及び「cohort of concern」に含まれる不純物に焦点を置き、変異原性不純物のリスクを軽減する取り組みに関する説明を含めること。

〔平成 28 年 4 月 22 日 第 13 回医薬品評価フォーラム〕

【記載例】 14 日以内の第 I 相臨床試験の場合

M7 ガイドラインに従って原薬●●の合成スキームを検討した結果、cohort of concern に含まれる不純物、クラス 1 及びクラス 2 の不純物は含まれないことを確認した。

- ・ 14 日を超える第 I 相臨床試験及び第 IIa 相臨床試験については、分析管理を要するクラス 3 の不純物も含めること。
- ・ 第 IIb 相及び第 III 相臨床試験については、(Q)SAR により評価した不純物の一覧を含めるべきであり、すべてのクラス 1、クラス 2、又はクラス 3 の実際の不純物及び潜在的な不純物について、管理計画とともに説明すること。評価に使用した *in silico* (Q)SAR システムについて記述すること。実際の不純物に関する細菌を用いる変異原性試験の結果を報告すること。
- ・ 第 IIb 相試験及び第 III 相試験に該当する場合においては、治験薬 GMP に準拠して製造される原薬及び製剤の製造工程流れ図についても添付すること。また、不純物の変異原性に関する評価結果等については、以下の記載例を参考にすること。

【記載例】 第 IIb 相以降の試験の場合

図 1. 原薬の製造工程流れ図

… (省略) …

図 2. 製剤の製造工程流れ図

… (省略) …

表 1. 不純物の変異原性に関する評価結果及び変異原性不純物の管理

不純物名 ／構造	(Q)SAR システム 1	(Q)SAR システム 2	細菌を用いた変異原性 試験の結果	クラス分類	変異原性不純物 の管理

表 2. 原薬ロット中の変異原性不純物の分析結果

変異原性不純物	許容限度値	ロット番号		
合計				

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答 (Q&A) の改正について Q26・A26〕

【事例】

《資料の添付について》

- ・ 原薬及び製剤ともに国内市販製剤と同一の製法で製造された治験薬を利用する場合は、備考欄にその旨を記載することで M7 関連資料の添付は不要と PMDA から回答を得た。
- ・ 上記に該当する場合であったが、既承認の用法用量及び投与期間を超えていたことか

ら、M7 関連資料の提出を求められた。

- ・ M7 ガイドラインの対象外と判断した試験の治験計画届に対して、「M7 関連資料の添付が不要と判断したならばその理由を説明頂きたい」と PMDA から指摘を受けた。説明の方法は、「備考欄に記載」又は「添付資料として添付」のいずれでも問題なく受け付けられた。
- ・ がんを予定する効能効果として開発を進めている薬剤であっても、健康成人を対象として実施する治験の計画届を提出する場合には、M7 関連資料を添付資料として提出することを要求された。

《資料の内容について》

- ・ 製剤についてのリスクは特になかったことから、原薬の結果のみを M7 関連資料に記載して提出したところ、製剤についてのリスクがないのであればその旨を追記するよう PMDA から指示を受けた。

《資料の別送について》

- ・ 他社に製造委託している原薬の製造に関する情報（製造プロセス）を、当該原薬製造会社から PMDA に別送する方法を審査マネジメント部に確認したところ、以下の指示を受けた。
 - 治験計画届と別送資料が別々に PMDA に届くため、治験計画届の受付番号を別送資料に記載して提出すること。
 - 別送資料中に「製造方法が機密情報であるため開示せずに別送」とした旨及び問い合わせ先担当者の連絡先を記載すること。
- ・ A 社と B 社の共同開発品目で、各社からそれぞれ治験計画届を提出し、M7 関連資料は A 社のみから提出した。B 社は、審査マネジメント部に事前確認した以下の内容を治験計画届の届書添付資料に関する備考欄に記載して、M7 関連資料の提出を省略した。

『本品目は A 社との共同開発品目であり、「〇〇〇〇（治験成分記号）の DNA 反応性（変異原性）不純物の評価及び管理に関する資料」については A 社からのみ提出する。』

主たる治験について

主たる治験の定義

- ・ 人道的見地から実施される治験（拡大治験）が整理されたことに伴い、国内開発の最終段階である治験（通常、効能・効果及び用法・用量が一連の開発を通じて設定された後に実施される有効性及び安全性の検証を目的とした治験）が主たる治験として定義された。また、主たる治験は、適応疾患に関わらず、新医療用医薬品としての承認申請（効能追加等を含む）が見込まれるすべての治験薬が対象となる。ただし、長期投与試験は主たる治験に該当しない。

〔H28.1.22 薬生審査発 0122 第 7 号、R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 3 号、R4.8.31 事務連絡〕

主たる治験の情報公開

- ・ 主たる治験又は拡大治験として治験計画届を提出し、それらの治験の情報を PMDA のホームページに追加する際には、以下の PMDA のホームページより「治験情報登録用フォーマット」をダウンロードし、必要事項を入力の上、薬物の連絡先リストのみの場合は kakudaitiken@pmda.go.jp 宛てに、被験機器相当又は被験製品相当も届け出ている場合は ks-kakudaitiken@pmda.go.jp 宛てにも可能な限り速やかに送付すること。メールの件名は「【人道的見地からの治験】【追加】治験届出者名_提出年月日（YYYYMMDD）」とすること。薬物と被験機器相当又は被験製品相当も届け出ている場合は、2 つのアドレスを宛先にして、1 通のメールを送ることにより。

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0016.html>

- ・ 主たる治験及び拡大治験に係る被験薬、被験機器相当又は被験製品相当が薬事承認された場合、治験中止届又は開発中止届が提出された場合には、当該治験に係る情報の削除を依頼する旨のメールを PMDA（kakudaitiken@pmda.go.jp）に送付すること。メールの件名は「【人道的見地からの治験】【削除】治験届出者名_提出年月日（YYYYMMDD）」とし、メール本文に削除したいリストの内容、治験計画届受付番号及び承認内容（承認日、承認番号、販売名、一般名等）又は治験中止届書等の情報（届出日、受付番号等）を記載すること。
- ・ 治験計画届書として PMDA に届け出られたもののうち、主たる治験及び拡大治験に係る情報は届出翌月末を目処に PMDA のホームページで公開される。
- ・ 治験届出者の連絡先は、以下の PMDA のホームページより、「治験届出者連絡先情報登録用フォーマット」をダウンロードし、必要事項を入力の上、薬物の連絡先リストのみの場合は kakudaitiken@pmda.go.jp 宛てに、被験機器相当又は被験製品相当も届け出ている場合は ks-kakudaitiken@pmda.go.jp 宛てにも送付すること。これら 2 つのアドレスを宛先にする必要がある場合、1 通のメールを送ることにより。メールの件名は「【人道的見地からの治験】【連絡先】治験届出者名_提出年月日（YYYYMMDD）」とすること。

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0016.html>

- ・ 治験届出者の連絡先の登録を行っていない場合は、治験計画届書を届け出た翌月の 15 日までに提出すること。治験届出者の連絡先の内容に変更がある場合、PMDA に連絡すること。内容変更は、毎月 15 日までに連絡があった場合には当月末を目処に、16 日以降に連絡があった場合は翌月末を目処に情報の更新が行われることから、連絡がとれなくなることがないように計画的な変更努めること。
- ・ 治験届出者の連絡先（電話番号、FAX、電子メール等）は治験届出者に一任されるが、連絡がとれる手段とし、電話による連絡でない場合は、営業日の一両日中に要望者に要望を受けた旨の回答は行うこと。

〔H28.1.22 薬生審査発 0122 第 7 号、R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 3 号、R4.8.31 事務連絡〕

【事例】

- ・ 会社合併等に伴う主たる治験情報及び治験届出者の連絡先の変更について審査マネジメント部に確認したところ、以下の回答を得た。
○月 1 日付けで合併する場合、「○月の前月末に公開される情報で新たな会社名・連絡先に変更する」又は「○月前月末に公開される情報で新旧の情報を併記する」等の対応が可能である。

4 治験計画届書の提出に関する一般的注意事項

1. 提出の方法

- ・届書については、以下の方法に基づき提出すること。

(1) ゲートウェイシステムを利用したオンライン提出

（「I. 申請電子データシステムを利用した治験計画届書等のオンライン提出」（p5）を参照）

(2) 郵送・受付窓口提出

- ・XML ファイル及び PDF ファイルを、CD-R 又は DVD-R（以下「電子媒体」と総称する。）に格納し提出すること。
- ・届書 1 枚目（少なくとも主たる被験薬の治験成分記号、届出分類、届出回数及び変更回数の項目が入ったもの）を紙資料で 2 部提出すること。（【運用】社印等の押印は不要）当該届書 1 枚目の 1 部は、PMDA の受領印を押印し治験届出者に返送するため、PMDA に提出した届書の写しとともに、治験に係る文書として保存すること。

〔R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号 別添 2〔一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号〕〕

1) 郵送による届出

- ・届書を郵送する場合は、次の区分ごとに封筒を分け、封筒の外面の見やすい場所に略語を大きく赤字で記載すること。また、電子媒体は原則として CD-R 又は DVD-R とする。

【略語】

「治験 A」：薬物の治験計画届書関係の略語

「治験 B」：機械器具等及び加工細胞等の治験計画届書関係の略語

「治験 C」：自ら治験を実施する者に係る治験計画届書関係（薬物）の略語

「治験 D」：自ら治験を実施する者に係る治験計画届書関係（機械器具等及び加工細胞等）の略語

- ・PMDA に到着する日付と届出年月日が一致するよう日付指定の上、郵送すること。
- ・なお、郵送の場合は、当日 16 時までに到着するように郵送すること。受理ができない場合にはその旨を届出者へ連絡して対応を調整する。
- ・また、届書の控えを返送するため、控え用の写しとともに、送り先を明記し切手や信書使用着払い伝票等を貼付した返信用封筒を同封すること。

送付先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 審査マネジメント部 審査企画課

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 10 階

TEL : 03-3506-9438

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0021.html>

【事例】

- ・ 郵送で提出する場合、届書の届出日より前に届くのは基本的に不可であることを PMDA に確認した。
- ・ 郵送で提出する場合、治験届は信書に該当するので郵便局のレターパック又は運送会社の信書便を利用した。なお、郵送の際は、返送用にレターパックを同封した。
- ・ 治験届の受理に関する電話での問合せはしない方が好ましい。

2) 受付窓口での届出

- ・ 窓口での提出には事前予約が必要となる。PMDA ウェブサイトの「受付業務について」から予約画面（外部サイト：Air リザーブ）に移行し、必要事項を記載して予約すること。なお、申込方法等の詳細は PMDA ウェブサイトで確認すること。
- ・ 受付日：月曜日から金曜日までの毎日（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始を除く）。
午前 9 時 30 分から正午までに提出する。

<https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/procedures/0021.html>

※なお、5 月連休や年末年始の前には「治験計画届等の提出に関するお願い」が PMDA より発信される。PMDA ウェブサイトを参照のこと（ホーム>審査関連業務>治験関連業務>治験計画届出制度>治験計画届書等の受付業務について）。

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0021.html>

(3) 問合せについて

- ・ 緊急の場合を除き、「治験届及び治験副作用／不具合等報告の提出に関する問合せ票」に必要事項を記入の上、ファクシミリ又はメールにて問い合わせること。緊急の場合は下記、受付時間に限らず、電話にて一報を入れること。
- ・ 基本的に回答期日の指定の要望には応えてもらえない旨留意すること。また、緊急の場合を除き原則メールで問い合わせること。

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0020.html>

受付時間：原則、午前 9 時から午後 5 時

問合せ先：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 審査マネジメント部 審査企画課

TEL 03-3506-9438（ダイヤルイン）

FAX 03-3506-9443

メール tiken-toiawase@pmda.go.jp

2. 届書の提出様式

- ・ 基本通知の別添 3 に示された XML 文書の構造定義（スキーマ）に従って届出事項を入力した

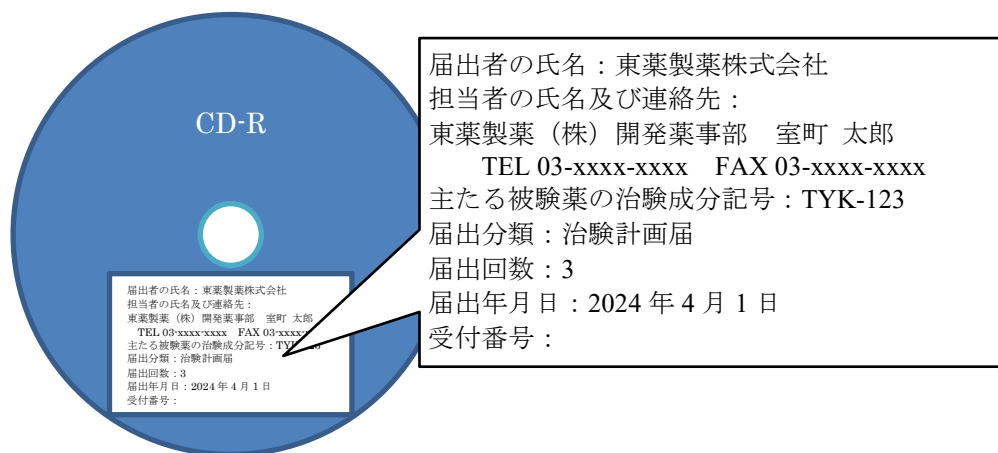
XML ファイルを作成する。また、作成した XML ファイル及び PDF ファイルを、ゲートウェイシステムを利用したオンライン提出又は記録した CD-R 又は DVD-R（以下本項において「電子媒体」と総称する。）を窓口・郵送提出する。電子媒体への記録は、追記不可能な形式（ディスクアットワンス）で行うこと。

- ・届書の XML ファイルを格納した電子媒体には、以下の事項を記載したラベルを貼付又は直接記載すること。
 - (1) 届出者の氏名（法人にあつては法人の名称）並びに届出担当者の氏名、所属及び電話・FAX 番号又はメールアドレス
 - (2) 主たる被験薬の治験成分記号、届出分類（例：治験計画届）、該当する治験計画届書の届出回数※
 - (3) 届出年月日（提出する届書の届出年月日）
 - (4) 受付番号（PMDA で記載するため、記載欄のみ作成しておくこと。）

※治験計画変更届、治験終了届、治験中止届の場合でも、該当する治験計画届書の届出回数を記載する。

開発中止届の場合は届出回数の記載は不要。

<ラベルの記載例>



3. 添付資料の提出様式

- ・治験計画届書に添付する資料については、PDF ファイル又はこれを記録した電子媒体を提出すること。
 - (1) オンライン提出の場合、1 回のオンライン提出あたり 1 つの届出とすること（1 回のオンライン提出時に複数の届出をまとめて提出しないこと）。窓口・郵送提出の場合、電子媒体は原則として、1 つの届出ごとに 1 枚を提出することとし、複数の届出を 1 つの電子媒体に記録しないこと。提出する電子媒体は、原則として CD-R 又は DVD-R とする。

- (2) 窓口・郵送提出の場合、電子媒体は、追記不可能な形式（ディスクアットワンス）で記録すること。
- (3) 下記の①から⑧はPDF形式とし、スキャニングにより作成したものではなく、テキスト情報を含んだPDFファイルを作成すること。作成したファイルにはパスワードやダウンロード制限等のセキュリティ設定を行わないこと。また、③と⑥のファイルについては、平成9年3月13日中薬審第40号「中央薬事審議会答申」に記載している項目タイトルを参考に、しおりをつけること。なお、差替えの場合は差替えファイルのみを記録し、新旧対照表は同一資料のファイルに含めてPDFを作成すること。

① 届書

② 当該治験の依頼を科学的に正当と判断した理由を記した文書

③ 治験実施計画書

④ インフォームド・コンセントに用いられる説明文書及び同意文書

⑤ 症例報告書の見本（治験実施計画書において、症例報告書に記載すべき事項が十分に読み取れる場合は、提出は不要であること。）

⑥ 最新の治験薬概要書

⑦ 被験薬以外の治験使用薬に係る最新の科学的知見を記載した文書（添付文書、インタビューフォーム、学術論文等）

⑧ その他

- ・ 電子媒体に保存するファイルには、基本通知の別添2に従いファイル名をつけること（p82 参照）。
- ・ 電子媒体には、届書と同様の事項を記載したラベルを貼付又は直接記載すること。

〔一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第1号、R5.3.30 薬生薬審発 0330 第3号 別添2〕

- ・ 初めてヒトに投与する薬物に係る治験計画届出時に非臨床安全性試験（毒性試験及び安全性薬理試験）の最終報告書を提出する場合、各最終報告書のファイルを1つのフォルダにまとめ、当該フォルダをzipにし、提出すること。

〔R1.6.20 薬機審査長発第 0620003 号、薬機審長発第 0620004 号、R5.5.30 薬生薬審発 0330 第3号〕

【事例】

- ・ M7 関連資料は、「⑧その他」として添付した。
- ・ （バイオテクノロジー応用医薬品・ワクチンの場合）品質に関する資料を提出する場合は、「⑧その他」として添付した。
- ・ PMDA からの修正指示、30 日調査に伴う照会回答等により届書又は添付資料を差替える場合、期限、提出先、提出方法（該当部分のみ差替えの可否）等を確認した。
- ・ 差替えの場合でも、提出日は最初の提出日と同日にするよう指示を受けた。PMDA の受領

印は、同日付の場合と差替えた日付の場合があった。

- ・ 治験実施計画書にしおりがついていなかったため、差替え提出の指示を受けた。

- ・ 治験計画等の届出に関する FAQ は、PMDA ウェブサイトを参照すること。

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0022.html>

4. 治験の実施状況等の登録について

- ・ 治験の実施状況等を第三者に明らかにし、治験の透明性を確保し、もって被験者の保護、医療関係者及び国民の治験情報へのアクセスの確保、治験の活性化に資するため、治験計画届書を届け出た場合には、国内の臨床試験情報登録センター（jRCT（Japan Registry of Clinical Trials））に当該治験に係る情報を登録すること。ただし、生物学的同等性試験についてはその限りではない。

[R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 9 号]

5 治験計画届書の記載上の注意事項

1. 治験届出共通事項

(1) 主たる被験薬の治験成分記号

- ・主たる被験薬の治験成分記号を入力すること。
- ・自社で定めた治験成分記号（アルファベット及び数字の組み合わせで計 20 桁以内）を半角文字で入力すること。
- ・投与経路が異なる被験薬には、別の記号を用いること。なお、既に治験計画の届出が行われた製剤（以下「届出製剤」という。）の開発のために、届出製剤と同一成分を有する投与経路の異なる製剤を用いて試験を行う場合であって、当該製剤の開発を行う意図がない場合にあっては、当該製剤の治験成分記号は届出製剤と同一とし、既届出製剤の n 回届として治験計画を届け出ること差し支えないこと。この場合にあっては、n 回届出ではあるが 30 日調査の対象となることから、基本通知の 30 日調査の対象となる場合の取扱いに準じて届出を行うこと。基本通知の記の 1. (6) ①ウに該当する場合には既承認医薬品等とは異なる治験成分記号とすること。また、投与経路が同一であっても徐放化製剤等で用法及び用量が異なる製剤の場合等は、別の治験成分記号としても差し支えないこと。
- ・治験成分記号は上記を除き、一連の治験を通して一つとすること。
- ・初回治験計画届出時に届け出た治験成分記号を変更する場合は、変更を届け出る届書にて、変更区分、変更年月日及び変更理由を明らかにすること。
- ・治験成分記号を変更する場合には、届出の際に変更前後の治験成分記号、変更前の治験成分記号で届け出られた初回届出受付番号、変更の対象となる治験計画届書の届出回数を記載した書面を 1 部提出すること。

【事例】

- ・ XML 入力規則上での禁則文字があり、届出後に指摘された（事例："&"）。
- ・ 治験成分記号中のスペース有無は識別されるので、入力の際は注意すること（「ABC123」と「ABC 123」は区別された）。
- ・ 「投与経路が同一であっても徐放化製剤等で用法及び用量が異なる製剤の場合等は、別の治験成分記号としても差し支えないこと。」とされているが、PMDA より同一とするように指示を受け、治験計画届の差替え提出を求められた。そのため、別の治験成分記号を用いて治験計画届を提出する場合については、事前に PMDA に確認しておくことが望ましい。
- ・ 治験成分記号を変更しなければならない場合、備考欄に以下の 2 つの情報を記載することによって、PMDA 内で変更前の治験成分記号でこれまで実施してきた治験と一連の試験として紐付けが行われ、30 日調査対象となることはなかった。
 - 治験成分記号名変更の旨（例：当該届出は国際共同治験のため治験成分記号を ABC123 から DEF456 に変更し運用する）
 - 変更の経緯及び理由を届出に別添（様式自由）

- ・ 既承認の成分を別の会社が単独で開発する場合、新規の治験成分記号を設定できるが、治験計画届の備考欄に、本薬は異なる治験成分記号で他社により国内開発が実施されている旨を記載した。

(2) 治験の種類

- ・ 半角数字を用いて「1」と入力すること。

(3) 主たる被験薬の初回届出受付番号

- ・ 当該届書が初回の治験計画届書に該当する場合には、空欄とすること。
- ・ 主たる被験薬と同一治験成分記号に係る初回の治験計画届書等の受付番号を入力すること。
その際「審第〇〇-〇〇〇〇号」は、「〇〇-〇〇〇〇」又は「〇〇〇〇-〇〇〇〇」のように半角数字及び半角ハイフンを用いて入力すること。また、平成 9 年 4 月以前に初回届を届け出して受付番号のない場合には、当該治験成分記号の届出について最初に付けられた受付番号を入力すること。

【事例】

- ・ 治験使用薬（主たる被験薬ではない被験薬）として届け出て 30 日調査を実施した製剤を、主たる被験薬として初めて届け出る場合の記載方法について、以下の通り記載するよう PMDA に確認した。
 - 主たる被験薬の初回届出受付番号について、治験計画届は空欄で提出し、治験計画変更届は当該計画届を提出後に付番された（主たる被験薬としての）初回届出受付番号を記載する。

(4) 主たる被験薬の初回届出年月日

- ・ 主たる被験薬と同一治験成分記号に係る初回の治験計画届書等を届け出た年月日を入力すること。

【事例】

- ・ 治験使用薬（主たる被験薬ではない被験薬）として届け出て 30 日調査を実施した製剤を、主たる被験薬として初めて届け出る場合の記載方法について、以下の通り記載するよう PMDA に確認した。
 - 主たる被験薬の初回届出年月日について、当該計画届の（主たる被験薬としての）初回届出年月日を記載する。

(5) 主たる被験薬の届出回数

- ・ 主たる被験薬と同一治験成分記号に係る治験計画届書（変更届書等は含まない。）の通算の届出回数を入力すること。

- ・既承認医薬品について効能又は効果の追加等承認事項の一部変更承認申請のために治験を行う場合等であって、以前に当該主たる被験薬に係る治験計画届書を届け出たことがある場合には、連番で入力（例えば、以前に計 10 回の届出を行っている場合には半角数字で 11 と入力）すること。

【事例】

- ・ 未承認薬・適応外薬の開発要請を受けた品目等で、該当品目の開発・承認された時期が古すぎて、治験計画届の会社控が残っていない又は PMDA でも登録されていない場合は、届出回数は 1 回とすることで対応した。通常、届出 1 回の場合は 30 日調査となるが、過去に治験計画届を提出している旨を備考欄等に記載し、30 日調査対象外として取り扱われた。
- ・ 製造販売承認後の場合には、開発部門の関与なく医師主導治験にて治験計画届が提出されていることもあるため、効能追加等の治験計画届の際には、社内にて医師主導治験の有無と届出回数を把握することが望ましい。
- ・ 届出回数が間違っていた場合、PMDA から間違っていることは伝えられるものの、〇回が正しいとは伝えられないため依頼者自身で調べるよう案内を受けた。
- ・ 治験使用薬（主たる被験薬ではない被験薬）として届け出て 30 日調査を実施した製剤を、主たる被験薬として初めて届け出る場合の記載方法について、以下の通り記載するよう PMDA に確認した。
 - 主たる被験薬の届出回数：主たる被験薬としての届出回数として 1 と記載する。

(6) 当該治験計画届出受付番号

- ・ 空欄で届出すること。

(7) 当該治験計画届出年月日

- ・ 当該治験計画届書の届出年月日を入力すること。

2. 主たる被験薬に関する届出事項

(1) 届出年月日

- ・ 当該届出の届出年月日を入力すること。

(2) 届出分類

- ・ 「治験計画届」と入力すること。

(3) 変更回数

- ・ 【運用】 空欄で届出すること。

(4) 届出区分

- ・ 30 日調査対象の届書は「1」、基本通知の記の 1. (6) ①エ及び②ウに該当する届書は「2」、その他の届書は「3」を半角数字で入力すること。届出区分の考え方については下表を参考にすること。

【届出区分の考え方(イメージ表)】

	届出回数	変更回数	変更箇所	届出区分
治験計画届	3			「1」又は「2」(※1)
治験計画変更届	3	1	治験分担医師の追加	「3」
治験計画変更届	3	2	対象疾患の追加	「2」
治験計画変更届	3	3	CROの追加・変更	「3」
治験計画変更届	3	4	被験薬の追加、治験分担医師の追加	「1」又は「2」(※1)
治験計画変更届	3	5	備考欄の追加	「3」
治験計画変更届	3	6	目的の変更	「2」
治験計画変更届	3	7	届出担当者の変更	「3」
治験計画変更届	3	8	治験使用薬(被験薬を除く)の追加	「2」又は「3」(※2)
治験計画変更届	3	9	治験分担医師の削除	「3」
治験終了届	3			「3」

※1: 被験薬が30日調査対象である場合は「1」、被験薬が30日調査対象以外である場合は「2」

※2: 治験使用薬(被験薬を除く)が、本邦において安全性情報が十分に蓄積されていない治験使用薬(被験薬を除く)の場合「2」、それ以外の場合「3」

[R3.6.8 開催 医薬品医療機器等法改正説明会資料]

(5) 主たる被験薬の 30 日調査対応被験薬区分

- ・ 当該届出に係る治験の計画で用いられる主たる被験薬が 30 日調査の対象となる場合には、当該届出に係る治験において対象とされる被験薬の区分に応じ、「新有効成分」、「新投与経路」又は「新医療用配合剤」のいずれかを入力すること。
- ・ 平成 9 年 4 月 1 日以降新たに届出の対象とされた被験薬に該当するもののうち、初めての届出であっても、既に当該薬物について治験を実施しており、当該被験薬について初めて人に投与するものでない場合は空欄とし、「備考」欄にその旨を入力すること。
- ・ マイクロドーズ臨床試験の治験計画届書の場合、空欄で届け出ること。また、マイクロドーズ臨床試験以降初めて届け出る治験計画届書の場合は、「新有効成分」、「新投与経路」又は「新医療用配合剤」のいずれか対応する区分を選択して記載等すること。

[R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答 (Q&A) の改正について Q29・A29 及び Q30・A30]

【事例】

- ・ 同成分を含有し投与経路が異なる製剤について、主たる被験薬及び従たる被験薬として 1 つの初回治験計画届を提出する場合の「30 日調査対応被験薬区分」について PMDA に確認したところ、主たる被験薬及び従たる被験薬のいずれに対しても「新有効成分」とすること、と指示を受けた。

- ・ 既承認の成分を別の会社が単独で開発する場合、同一組成、同一投与経路であるならば、初回治験計画届であっても 30 日調査の対象外となった。なお、備考欄に開発の経緯を記載した。

(6) 中止情報

- ・ 【運用】 空欄で届出すること。

(7) 主たる被験薬の製造所又は営業所の名称及び所在地

- ・ 製造の場合は製造所、輸入の場合は営業所の名称及び所在地を入力すること。
- ・ 業者コード（9 桁）は半角数字で入力すること。なお、コードが付されていない場所で製造する場合には、薬機法上の許可を有している業者にあつては下 3 桁を「999」と入力し、薬機法上の許可を有していない業者にあつては「999999999」と入力すること。

【事例】

- ・ 所在地 1 の入力文字数の制限を超える場合、あるいはビルの名称等を入力する場合は所在地 2 に入力する。

(8) 主たる被験薬の成分及び分量情報

- ・ 主たる被験薬の成分及び分量について記載すること。
- ・ 成分名は、一般名（JAN 又は INN）を入力（英名及び日本名）し、一般名が決まっていない場合には治験成分記号を入力すること。
- ・ 分量は、剤形当たりの有効成分の含量が分かるように入力すること。
- ・ 剤形コード情報は日本薬局方が定めるコードに従って剤形コード（4 桁）のうちの頭の英数字 2 桁を半角文字で入力すること。

治験の計画の届出等に記載する剤形コード

経口投与する製剤 錠剤 カプセル剤 顆粒剤 散剤 経口液剤 シロップ剤 経口ゼリー剤 その他の経口投与する製剤	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AZ	耳に投与する製剤 点耳剤 その他の耳に投与する製剤	G1 GZ
口腔内に適用する製剤 口腔用錠剤 口腔用スプレー剤 口腔用半固形剤 含嗽剤 口腔用液剤 その他口腔内適用製剤	B1 B2 B3 B4 B5 BZ	鼻に適用する製剤 点鼻剤 その他の鼻に適用する製剤	H1 HZ
注射により投与する製剤 注射剤 その他注射投与製剤	C1 CZ	直腸に適用する製剤 坐剤 直腸用半固形剤 注腸剤 その他の直腸に適用する製剤	I1 I2 I3 IZ
透析に用いる製剤 透析用剤 その他の透析に用いる製剤	D1 DZ	膣に適用する製剤 膣錠 膣用坐剤 その他の膣に適用する製剤	J1 J2 JZ
気管支・肺に適用する製剤 吸入剤 その他気管支・肺適用製剤	E1 EZ	皮膚等に適用する製剤 外用固形剤 外用液剤 スプレー剤 軟膏剤 クリーム剤 ゲル剤 貼付剤 その他皮膚等適用製剤	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 KZ
目に投与する製剤 点眼剤 眼軟膏剤 その他の目に投与する製剤	F1 F2 FZ		

〔H24.10.1 事務連絡〕

【事例】

- 二重盲検試験において盲検維持のため錠剤の対照薬をカプセルに封入した製剤を使用する場合の治験届における適切な剤形コードについて PMDA に確認したところ、以下の回答を得た。
通知で明確に規定されているものではないため、錠剤としてもカプセル剤としても構わない。なお、盲検化のために錠剤を粉砕してカプセル詰めするような事例においても、治験届上は錠剤としてもカプセル剤としてもどちらでも良い。

(9) 主たる被験薬の製造方法

- ・主たる被験薬の製造方法について記載すること。
- ・原薬の製造方法については、化学合成、抽出、培養、遺伝子組換え等の区別を明らかにすること。
- ・製剤については、剤形を明確に入力（「化学合成した〇〇〇を日局製剤総則錠剤の項に準じて製する」等）することとし、徐放化製剤等特殊な剤形の場合は説明を付すこと。
- ・製造、輸入の別を入力することとし、輸入の場合には原薬の輸入か製剤の輸入かを明らかにし、輸入先の国名、製造業者の氏名又は名称及び輸入先における販売名を入力すること。

(10) 主たる被験薬の予定される効能又は効果情報

- ・主たる被験薬の薬効薬理等から期待される効能又は効果について、類薬を参考に入力すること。
- ・薬効分類番号（3桁）は、半角数字で入力すること。なお、薬効分類番号が2つ以上に跨るものは、主たる薬効分類番号を入力することで差し支えないこと。
- ・【運用】薬効分類番号は、医薬品製造販売指針、保険薬事典などを参照することもできる（p77～p80 参照）。

(11) 主たる被験薬の予定される用法及び用量情報

- ・主たる被験薬の予定される用法及び用量を入力すること。
- ・投与経路コード情報（2桁）は、半角数字で入力すること。

主な投与経路 コード	経口投与	11
	静脈内注射	21
	筋肉内注射	22
	皮下注射	23
	動脈内注射	24
	一般外用剤	31
	経皮吸収で全身作用を期待する製剤	32
	直腸、膣、尿道に適用する外用剤	34
	眼科用剤	35
	耳鼻科用剤	36
	吸入剤	37
	人工透析	70

[H26.10.27 薬食審査発 1027 第1号]

(12) 治験計画の概要

1) 実施計画書識別記号

当該治験実施計画書の識別記号があれば入力すること。

2) 開発の相

当該被験薬の開発段階について、「臨床試験の一般指針について」（平成10年4月21日

付け医薬審第 380 号厚生省医薬安全局審査管理課長通知。以下「一般指針通知」という。) に準じて、第Ⅰ相は「1」、第Ⅱ相は「2」、第Ⅲ相は「3」と開発相コードを半角数字で入力すること。また、これ以外の場合として「「医薬品の臨床試験及び製造販売承認申請のための非臨床安全性試験の実施についてのガイダンス」について」（平成 22 年 2 月 19 日付け薬食審査発 0219 第 4 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）で定義されている早期探索的臨床試験（アプローチ 1 又は 2 のマイクロドーズ試験及びアプローチ 3～5 の試験）に該当する場合は「0」、第Ⅰ/Ⅱ相は「4」、第Ⅱ/Ⅲ相は「5」、第Ⅰ/Ⅲ相は「6」と半角数字で入力すること。

3) 試験の種類

当該治験の種類について、一般指針通知に準じて、「臨床薬理試験」、「探索的試験」、「検証的試験」等と入力すること。

(参考) 臨床試験の一般指針(補遺)より抜粋

<https://www.pmda.go.jp/files/000250244.pdf> (ICH-E8 (R1))

試験の種類	試験の目的	試験の例
臨床薬理試験	・ 忍容性と安全性の評価 ・ 薬物動態及び薬力学の定義/記述 ・ 薬物代謝と薬物相互作用の探索 ・ 薬理活性及び免疫原性の評価 ・ 腎臓/肝臓に関する忍容性評価 ・ 心毒性の評価	・ 空腹/食後条件下のバイオアベイラビリティ/生物学的同等性試験 ・ 用量忍容性試験 ・ 単回投与及び反復投与の薬物動態及び/又は薬力学的試験 ・ 薬物相互作用に関する試験 ・ QT/QTc 評価試験 ・ 薬物送達デバイスにおけるヒューマンファクター試験
探索的試験	・ 標的とする適応症での使用の探索 ・ 以降の試験のための用量/レジメンの推定 ・ 用量反応/曝露反応関係の探索 ・ 検証的試験のデザインの基礎の提供 (例えば、対象集団、臨床的なエンドポイント、患者報告アウトカムの指標、治療効果に影響を及ぼす因子)	・ 代替又は薬理学的エンドポイント若しくは臨床的指標を用いた、明確に定義された限られた患者集団で実施する比較的短期間のランダム化比較臨床試験 ・ 用量探索試験 ・ バイオマーカー探索試験 ・ 患者報告アウトカムのバリデーション試験 ・ 探索的目的と検証的目的を組み合わせたアダプティブデザイン
検証的試験	・ 有効性の証明/検証 ・ より大規模かつより患者集団を反映する集団における安全性プロファイルの確立 ・ 薬事承認を支援するためのベネフィット/リスクの関係を評価するための適切な基盤の提供 ・ 用量反応/曝露反応関係の確立 ・ 特殊集団 (例えば、小児、高齢者) における安全性プロファイルの確立と有効性の検証	・ 有効性の確立を目的としたより大規模かつより患者集団を反映した集団におけるランダム化比較試験 ・ 用量反応試験 ・ 安全性に関する臨床試験 ・ 死亡率/罹患率をアウトカムとした試験 ・ 特殊集団を対象とした試験 ・ 単一の試験実施計画書で複数の薬剤の有効性を示すことを目的とする試験

【事例】

- ・ 「試験の種類」の項目は文字数制限があるため、試験の種類を「臨床薬理試験及び探索的試験」としたい場合は、以下の対応をするよう指示を受けた。

試験の種類はどちらか一方とし、備考欄に以下を記載する。

「本試験は『臨床薬理試験及び探索的試験』であるが、文字数制限のため、試験の種類は『臨床薬理試験』と記載している。」

4) 目的

目的を具体的に入力し、治験実施計画書に記載された目的と整合を図ること。

5) 予定被験者数情報

「予定被験者数（被験薬）」の項に被験薬が投与される予定の被験者数を半角数字で入力すること。治験の実施に伴って治験使用薬の交付数量に変更が生じた場合には、当該項目に係る変更の届出は原則として不要である。

「予定被験者数（合計）」の項に対照群がない場合には被験薬が投与される予定の被験者数を、対照群がある場合には対照群も含めた合計の被験者数を、国際共同治験の場合には日本国内における被験者数を入力すること。

6) 主たる被験薬の対象疾患

主たる被験薬の具体的な疾患名を入力すること。健康人を対象とする場合は、その旨を入力すること。

7) 主たる被験薬の用法及び用量情報

主たる被験薬の用いられる用法及び用量を詳細に入力すること。

投与経路コード情報（2桁）は半角数字で入力すること。投与経路コード（2桁）については「(11) 主たる被験薬の予定される用法及び用量情報（p57）」を参照のこと。

【事例】

- ・ 生物製剤や遺伝子治療用医薬品などの First In Human (Japanese) 試験において、安全性に配慮した慎重な設定を求められ、PMDA と事前に十分な協議を実施した（低用量・低頻度から1例ごとに安全性を担保する用法とするなど）。

8) 実施期間

実施医療機関ごとの治験の予定契約締結日のうち最も早い日から、実施医療機関における観察終了予定日のうち最も遅い日までを含む期間を年月日で入力すること。

9) 有償の理由等

無償の場合には、空欄とすること。治験はその趣旨からも原則無償であること。治験使用薬を有償で譲渡する場合には、その理由を記載すること。

10) 治験の費用負担者に関する情報

空欄とすること。

11) 治験調整医師又は治験調整委員会構成医師に関する情報

治験調整医師又は治験調整委員会に治験の細目について調整する業務を委嘱する場合には、治験調整医師又は治験調整委員会構成医師の氏名、所属機関及び所属を入力すること。

- 12) 治験の依頼及び管理に関する業務の全部又は一部を受託する者（開発業務受託機関（CRO））の氏名、住所及び委託する業務の範囲

治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、当該業務を受託する者の氏名、住所及び当該委託する業務の範囲を入力すること。

(13) 主たる被験薬のその他の情報

- 1) カルタヘナ法の対象となる薬物を用いる治験

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15 年法律第 97 号。以下「カルタヘナ法」という。）の対象となる遺伝子組換え生物を含む薬物を用いて治験を実施する場合には、「該当の有無等」の項に、「第一種」、「第二種」又は「第一種及び第二種」のいずれか該当するものを入力し、「該当する場合の詳述」の項に、以下の内容を入力すること。

- ・カルタヘナ法第一種使用規程の承認取得状況（「承認申請中（申請年月日）」、「承認済（承認日付及び通知番号）」）を入力すること。
- ・カルタヘナ法の対象となる薬物を用いて治験を実施する場合には、カルタヘナ法第二種使用等拡散防止措置確認の有無（「確認申請中」、「確認済（確認日付及び通知番号）」、「不要」）及び予定される作業レベル（「GILSP」、「カテゴリー1」、「その他」）を複数の施設がある場合には施設ごとに入力すること。

カルタヘナ法の対象となる遺伝子組換え生物を含む薬物を用いて治験を実施しない場合は「該当の有無等」の項に「該当なし」を入力し、「該当する場合の詳述」の項は空欄とすること。

- 2) 生物由来製品に指定が見込まれる薬物を用いる治験

生物由来製品に指定が見込まれる（又は指定された）薬物を用いて治験を実施する場合には、「該当の有無等」の項に「生物由来製品（見込み）」、「生物由来製品（指定済み）」、「特定生物由来製品（見込み）」又は「特定生物由来製品（指定済み）」のいずれかを入力し、生物由来製品に指定が見込まれる（又は指定された）薬物を用いて治験を実施しない場合は「該当なし」を入力すること。

- 3) 対応するコンパニオン診断薬等の開発

対応するコンパニオン診断薬等の開発を治験で実施する場合は「該当の有無」の項に「該当あり」、実施しない場合は「該当なし」を入力すること。

- 4) コンビネーション製品に関する治験

製造販売された際にコンビネーション製品に該当すると考えられる薬物、機械器具、加工

細胞等を用いて治験を実施する場合は「該当の有無」の項に「該当あり」、実施しない場合は「該当なし」を入力すること。

5) その他

対応するコンパニオン診断薬等の開発を治験で実施する場合は、「コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事項について（平成 25 年 7 月 1 日付け薬食審査発 0701 第 10 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）」に基づき、コンパニオン診断薬等の開発状況について可能な範囲で簡素に記載すること。

また、その他、特記事項があれば入力すること。

(14) 当該届出に関するその他の情報

1) 臨床試験の位置付け

「該当の有無等」の項に主たる治験を実施する場合は「主たる治験」、拡大治験を実施する場合は「拡大治験」、それ以外の治験を実施する場合は「該当なし」を入力すること。
なお、主たる治験及び拡大治験に係る情報については、PMDA のホームページで公開されるため、「人道的見地から実施される治験の実施について」の改正について（令和 4 年 8 月 31 日付け薬生薬審発 0831 第 3 号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知）に基づき別途必要な対応を行うこと。

2) 国際共同治験

国際共同治験を実施する場合は、「該当の有無」の項に「該当あり」、実施しない場合は「該当なし」を入力すること。

また、「内容」の項に把握している範囲で、当該国際共同治験に参加する国名又は地域情報、当該国際共同治験の予定被験者数及び当該国際共同治験の予定被験者数に対し本邦の被験者数が占める割合について入力すること。

なお、国際共同治験に関する事項については、当該事項の変更のみの治験計画変更の届出を行う必要はなく、他の理由により、治験計画変更の届出を行う機会があるときに併せて変更することで差し支えないこと。

3) ゲノム検査等を含む治験

医薬品の作用に関連するゲノム検査等（特定の遺伝子に由来するタンパクその他のゲノムの発現機序に関連したバイオマーカー等を対象とした検査を含む。）を利用した治験を実施する場合は「該当あり」、実施しない場合は「該当なし」を入力すること。

4) マイクロドーズ臨床試験を利用した開発品目

当該治験がマイクロドーズ臨床試験である場合は「該当あり」、それ以外の場合には「該当なし」を入力すること。

5) 当該届出に関する治験に併用する機械器具等の記載

機械器具等の治験の計画の届出を要しない治験機器を併用する場合は、「該当の有無」の項に「該当あり」と入力し、「内容」の項に治験機器の類別、一般的名称、クラス分類、の他治験機器を特定するために必要な事項並びに数量を入力すること。

6) その他

「拡大治験」を入力する場合は、「拡大治験、主たる治験の受付番号〇〇-〇〇〇〇」と入力すること。

また、その他、特記事項があれば入力すること。

(15) 備考

その他、特記事項があれば入力すること。

- ・ 被験者等に対する治験の説明に電磁的方法を利用する場合は、治験届の備考欄（薬物の治験届の場合、薬物企業治験届出通知・薬物医師治験届出通知の別添1「3. 主たる被験薬に関する届出事項（15）」の備考）に以下の旨を記載すること。

- 動画等が説明文書に含まれる場合、「動画等が説明文書に含まれる」
- 動画等を説明文書の参考資料と見なす場合、「動画等を説明文書の参考資料とみなす」

〔R5.3.30 事務連絡 薬物、機械器具又は加工細胞等に係る治験の計画の届出に関する質疑応答集（Q&A）について Q1・A1〕

【事例】

- ・ 国際共同治験の場合、参加国又は地域：〇〇、〇〇、他〇ヵ国。予定被験者数：〇〇名。本邦の被験者数が占める割合：約〇%（〇〇名）と記載した。
- ・ 国際共同治験等の治験計画届時に、治験参加施設の選定が部分的にしか完了していない場合には、当該施設での予定被験者数と治験全体の日本人目標被験者数が合致していなくてもよく、治験計画変更届にて満足することで構わない。
- ・ 国際共同治験において検査キットを輸入して用いる場合は、備考欄へは検査キット単位の数量を記載し、キットの詳細については届書添付資料として提出した。提出した添付資料を更新する場合は、軽微な変更該当するため、新旧対比表は不要、変更理由「（例）治験計画書変更に伴う内容更新のため」とした。
- ・ 治験計画届（写）等の提示により輸入資材として医療機器（Lab 資材等）を輸入する場合、メーカー名、商品名、個数などを記載した。
- ・ 治験計画において、ゲノム検査用の検体採取のみを行う場合、備考欄にはゲノム検査を実施する旨を記載する必要はない。仮に検査を実施することになった場合には、治験計画変更届にて追記する。
- ・ コンパニオン診断薬等の国内外の承認取得の有無、開発企業名、開発に関する連携状況を

可能な範囲で簡潔に記載した。その際、以下の通知を参考にした。

- 「コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事項について（平成 25 年 7 月 1 日 薬食審査発 0701 第 10 号）」
- 「コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品に関する質疑応答集（Q&A）について（平成 25 年 7 月 1 日 事務連絡）」の Q6・A6
- ・ A 社が承認会社である品目 X についての効能追加を B 社と共同開発するが、治験は B 社が単独で行う場合の届出内容について確認した。
 - 届出者について
 - ◇ 治験計画届は、B 社単独名でよい。
 - 備考欄への記載（治験届出と A 社との紐付け）
 - ◇ 本治験は、A 社（業者コード XX00XX000）との共同開発である。
 - ◇ 本治験は、A 社の製造販売承認品目である「品目 X（承認番号〇〇）」の製造販売承認事項一部変更承認申請のために実施するものである。
 - ◇ 本治験は、B 社が単独で治験依頼者となり実施するものである。
 - 治験成分記号については、A 社が過去に使用していた記号が望ましい。別の記号でも可能であるが、その場合は、以下の手続きが必要になる。
 - ◇ 第〇回治験計画届出～第〇回治験計画届出までは A 社が届出し、第〇回治験計画届出は B 社が届出した旨が分かるような一覧表を提出する。
 - ◇ 届出の備考欄への記載
 - 治験成分記号を●から▲に変更すること
 - 治験薬の製造方法及び製造所は共同開発会社で開発中の薬剤と同一であること
 - （既承認医薬品である場合）既承認医薬品であることに加え、投与経路を変更することなく使用すること
 - （既に別の治験成分記号を使用し初回治験計画届が提出され、かつ、バイオ医薬品でない場合）30 日調査には該当しないこと
 - 初回届出年月日・受付番号について
 - ◇ A 社の初回承認時の開発における初回の治験計画届出日を記載する。
なお、品目 X について平成 9 年 4 月以降の治験が無い場合は、初回届出受付番号は今回の治験計画届出時の受付番号になる。
 - 届出回数について
 - ◇ A 社が過去行っていた治験に続けて n 回治験計画届とする。
- ・ 治験使用薬（主たる被験薬ではない被験薬）として届け出て 30 日調査を実施した製剤を、主たる被験薬として初めて届け出る場合の記載方法について、以下の通り記載するよう PMDA に確認した。
 - 本届出が主たる被験薬として初めての届出となるが、主たる被験薬以外の被験薬として治験計画変更届出済み（届出区分 1）、30 日調査対応済みである旨を備考欄に記載した（PMDA に記載案の確認を受けた上で提出した）。

- ・ 記載情報が多い場合、順序番号を利用して項目を増やして対応した。
- ・ 記載情報が多い場合、別紙参照として対応した。
- ・ XML ファイルの脚注欄については、GCP 業務支援システムによっては入力文字に制限（全角で 512 文字、半角で 1024 文字）があるので、脚注に文字が入らない場合には、備考欄に一部を入力した。

(16) 届書添付資料

- ・ 届書に添付した資料名を示すこと。また、届書添付資料に関する備考欄には、特記事項があれば入力すること。
- ・ 初めてヒトに投与する薬物に係る治験計画届出においては、届書添付資料に関する備考欄に、非臨床安全性試験の最終報告書を提出すること（最終報告書を提出しない場合には提出を不要と判断した理由）を記載する。

例（１）初めてヒトに投与する薬物に該当するため、非臨床安全性試験の最終報告書を提出する。

例（２）初めてヒトに投与する薬物に該当するが、治験相談（相談番号）にて議論済みであるため、非臨床安全性試験の最終報告書は提出しない。

〔R1.6.20 薬機審長発第 0620003 号、薬機審長発第 0620004 号〕

【事例】

- ・ 国際共同治験などにおいて、社内で治験実施計画書、治験薬概要書の英語版を正本として扱っていた場合でも、治験計画届の添付資料としては和訳版が正本の扱いとなる（規則第 283 条（邦文記載）参照）。
- ・ 国際共同治験における治験実施計画書の実施施設一覧への掲載国範囲については、日本以外の施設情報は必須ではなかった。
- ・ 後期第 II 相試験の治験計画届提出後、治験薬概要書に記載した生殖発生毒性試験の状況について照会を受けた。
- ・ 治験計画届出時には、新添加物に関する資料について、PMDA から不要との回答を得た。
- ・ 同成分を含有し投与経路が異なる製剤について、主たる被験薬及び従たる被験薬として 1 つの初回治験計画届を提出する場合、治験薬概要書がそれぞれの投与経路ごとに必要となることに留意すること、との指示を受けた。その他の添付資料についても、それぞれ用意し提出した。通知の事例に従い治験薬概要書のファイル名を付けたところ（例：TYK-123_01_K_IB_A.pdf、TYK-123_01_K_IB_B.pdf）、主たる被験薬及び従たる被験薬の治験薬概要書として同一のものを使用していたことから、いずれのファイルが主たる被験薬又は従たる被験薬に対応した治験薬概要書であるのか判別できないため、主たる被験薬に対応する方の治験薬概要書の表紙に主たる被験薬に対応した治験薬概要書であることがわかるよう追記すること、との指示を受けた。識別を記載した上紙をつけることを提案し、了承された。その後、PMDA から 2 冊は内容が同じものであるか、口頭で確認された。

(17) 治験届出者に関する情報

- ・ 治験届出者の種別（治験依頼者、治験国内管理人の別）、氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）、住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）、業者コード（9 桁）、届出担当者の氏名、所属、電話番号及び FAX 番号又はメールアドレスを入力すること。電話番号、FAX 番号及びメールアドレスは半角文字で入力すること。

【事例】

- ・ 外国人の代表者名（カタカナ）が入力可能な文字数である全角で 50 文字（半角で 100 文字）を超えていたため、半角カタカナに修正した。
- ・ 代表者氏名に旧字が含まれていたため、常用漢字（JIS 第 1 水準又は第 2 水準）に替えて入力した。なお、外字を他の文字で置換えた場合、どのように外字を置換えたのかを説明する資料を作成し、届書添付資料として提出する必要がある（治験計画等の届出に関する FAQ（<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0022.html>） Q2-13・A2-13）。

(18) 海外依頼者、外国製造業者に関する情報

- ・ 海外依頼者、外国製造業者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）、住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）を邦文及び英文で入力すること。なお、海外依頼者、外国製造業者が複数ある場合は、海外依頼者を一番上に記載すること。

【事例】

- ・ 外国製造業者に関する情報について、治験国内管理人が置かれている場合にのみ記載し、通常は空欄として提出している。
- ・ 通知の解釈について、PMDA 審査マネジメント部に問い合わせ、以下の回答を得た。
 - 「海外依頼者」に関する情報は、治験計画届書の届出者が治験国内管理人である場合にのみ、治験依頼者となる海外のスポンサーを記載するという理解でよい。
 - 「外国製造業者」に関する情報は、主たる被験薬を海外から輸入する場合に、「製造方法」の項に記載する輸入先となる製造業者について、氏名、主たる事務所の所在地等を記載する必要があるという理解でよい。

3. 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の情報

(1) 医薬品／医療機器／再生医療等製品の別

- ・ 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）が、「医薬品」、「医療機器」、「体外診断用医薬品」又は「再生医療等製品」のいずれに当たるかを入力すること。

(2) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の記号・名称等

- ・「記号・名称等」の項に、以下のとおり入力すること。また、「記号・名称等の種類」の項に、「記号・名称等」の項に入力した内容に該当するものとして、「治験成分記号」、「治験識別記号」、「一般的名称」又は「その他」のいずれかを入力し、「その他」を入力した場合には、「その他の場合の詳述」の項に入力した内容を具体的に説明すること。
 - ・被験薬の場合は、治験成分記号を入力すること。治験成分記号は、「1. 治験届出共通事項 (1) 主たる被験薬の治験成分記号 (p51)」のとおりに入付すること。
 - ・被験薬以外の治験使用薬の場合は、一般的名称 (JAN を入力し、JAN が付されていない場合には INN) を入力すること。
 - ・治験使用機器相当、治験使用製品相当の場合は、治験識別記号を入力すること。
 - ・被験機器以外の治験使用機器相当又は被験製品以外の治験使用製品相当において、既承認品などで治験識別記号がない場合、「記号・名称等」の項に一般的名称又は国内外の販売名を入れてもよい。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する
質疑応答 (Q&A) の改正について Q39・A39〕

(3) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当区分情報

- ・「被験薬/対照薬/併用薬/レスキュー薬等の区別」の項に、治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）が、「被験薬」、「対照薬」、「併用薬」、「レスキュー薬」又は「その他」のいずれに当たるかを入力し、「その他」の場合は、「その他の場合の治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の別」の項に当該治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の治験実施計画書上の役割を具体的に入力すること。なお、被験機器相当又は被験製品相当の場合は「被験薬」を、対照機器又は対照製品の場合は「対照薬」を、併用機器又は併用製品の場合は「併用薬」をそれぞれ選択すること。該当する選択肢が複数ある場合には、被験薬、対照薬、併用薬、レスキュー薬、その他、の順で優先して選択すること。

(4) 国内における承認状況

- ・治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）について、「未承認」、「適応外」又は「既承認」のいずれに当たるかを入力すること。
- ・有効成分が国内未承認の場合、「未承認」を選択すること。なお、バイオ後続品を開発する目的で実施される治験において、海外で承認された先行バイオ医薬品を対照薬に用いる場合も、「未承認」を選択すること。有効成分が国内既承認であるが、適応外の使用になる場合、「適応外」を選択すること。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する
質疑応答 (Q&A) の改正について Q63・A63〕

【事例】

- ・ 治験使用薬として国内未承認のバイオ後続品を使用する治験において、先行品と同等性／同質性が確認されている他の薬剤が承認されていたが、当該治験使用薬の国内における承認状況の欄は「未承認」を選択するように PMDA より指示があった。

(5) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の届出事項

- ・ 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の「30 日調査対応被験薬区分」、「製造所又は営業所（治験薬提供者）の名称及び所在地」、「成分及び分量情報」、「製造方法」、「予定される効能又は効果情報」、「予定される用法及び用量情報」、「治験計画の概要（対象疾患、用法及び用量情報）」、「その他の情報（カルタヘナ法の対象となる薬物を用いる治験、生物由来製品に指定が見込まれる薬物を用いる治験、対応するコンパニオン診断薬等の開発、コンビネーション製品に関する治験）」及び「外国製造業者に関する情報」について、主たる被験薬の記載方法に倣い記載すること。被験薬以外の治験使用薬については、「成分及び分量情報」のみを記載し、その他の項目は空欄とすることでも差し支えない。
- ・ 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の届出事項に治験使用機器相当の情報を入力する際には、規則第 275 条を参考に、各項目を読み替えること。被験機器相当以外の治験使用機器相当については、「構造及び原理」のみを記載し、その他の項目は空欄とすることでも差し支えない。
- ・ 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の届出事項に治験使用製品相当の情報を入力する際には、規則第 275 条の 4 を参考に、各項目を読み替えること。被験製品相当以外の治験使用製品相当については、「構成細胞又は導入遺伝子」のみを記載し、その他の項目は空欄とすることでも差し支えない。
- ・ また、「その他備考」の項は、治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）について、その他特記事項があれば入力すること。
- ・ 「副作用報告の有無」の項には、「有」を入力すること。

4. 実施医療機関ごとの事項

(1) 実施医療機関の名称・実施診療科、所在地及び代表電話番号

- ・ 実施医療機関の名称、実施診療科、所在地及び代表電話番号を入力すること。

(2) 治験責任医師に関する情報

- ・ 氏名、大学番号（基本通知の別添 4、p81 参照）、卒業年、氏名よみかなを入力すること。

【事例】

- ・ 治験責任医師の卒業年については、大学卒業年を優先とするが、履歴書等の記載が大学院卒業年のみであった際に、大学院卒業年を入力して提出した。

(3) 治験分担医師に関する情報

- ・氏名及び氏名よみかなを入力すること。

(4) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の数量情報

- ・治験使用薬の予定交付（入手）数量を種類（剤形、含量）別に入力すること。なお、用法及び用量並びに予定被験者数からみて適正な数量を交付すること。ただし、レスキュー薬等の適正な数量を予測することが困難なものについては、予定被験者数から想定される数量を入力することで差し支えない。
- ・二重盲検比較試験等において組単位で割付を行う場合には、1 組当たりの割付数量を脚注に示したうえで組数を入力することで差し支えないこと。

【事例】

- ・含量違いを組み合わせで交付する場合については、交付する治験薬の含量ごとに順序番号を変えて、それぞれの順序番号、治験薬の名称及び予定交付数量のみを繰り返し入力して提出した。

治験薬数量の入力例：

1. オープンラベル試験で3 製剤を交付する場合

届の種類	順序番号	治験薬名称	予定交付 (入手) 数量	交付 数量	使用 数量	回収 数量	廃棄 数量
計画届又は変更届	1	10mg 錠	100 錠	空欄	空欄	空欄	空欄
	2	50mg 錠	100 錠	空欄	空欄	空欄	空欄
	3	100mg 錠	100 錠	空欄	空欄	空欄	空欄
終了届又は中止届	1	10mg 錠	100 錠	100 錠	25 錠	75 錠	0 錠
	2	50mg 錠	100 錠	100 錠	20 錠	75 錠	5 錠
	3	100mg 錠	100 錠	50 錠	12 錠	38 錠	0 錠

2. プラセボとの二重盲検試験の場合に予定交付数量を組数で入力する場合

届の種類	順序番号	治験薬名称	予定交付 (入手) 数量	交付 数量	使用 数量	回収 数量	廃棄 数量
計画届又は変更届	1	空欄	1 組分	空欄	空欄	空欄	空欄
終了届又は中止届	1	空欄	1 組分	空欄	空欄	空欄	空欄
	2	10mg 錠	空欄	84 錠	84 錠	0 錠	0 錠
	3	プラセボ錠	空欄	84 錠	84 錠	0 錠	0 錠

脚注の入力：1 組（4 症例分）の交付数量として、10mg 錠 84 錠、プラセボ錠 84 錠

(5) 実施医療機関予定被験者数

- ・実施医療機関ごとの予定被験者数（被験薬群及び対照薬群を含む。）を入力すること。

(6) 実施医療機関被験者数

- ・【運用】空欄で提出すること。

(7) 治験の実施に係る業務の一部を実施医療機関から受託する者（治験施設支援機関（SMO）等）の氏名、住所及び委託する業務の範囲

- ・実施医療機関における治験の実施に関する業務の一部を委託する場合には、実施医療機関ごとに当該業務を受託する者の氏名、住所、当該受託する業務範囲を入力すること。

(8) 治験審査委員会に関する情報

- ・治験審査委員会の設置者の名称（法人名及び代表者氏名）及び所在地を実施医療機関ごとに入力すること。なお、当該実施医療機関の長が設置した治験審査委員会（当該実施医療機関の長が他の医療機関の長と共同で設置したものを除く。）に調査審議を行わせる場合には、「院内 IRB」と入力することで、治験審査委員会の設置者の名称（法人名及び代表者氏名）及び所在地について入力する必要はないこと。
- ・複数の医療機関の長が共同で設置した治験審査委員会に調査審議を行わせる場合には、治験審査委員会の設置者の名称の代わりに共同で設置した治験審査委員会の名称を記載し、当該治験審査委員会の事務局が設置されている所在地を入力すること。
- ・届け出する時点で調査審議を行わせる治験審査委員会が決まっていない場合には、事後に治験計画変更届として届け出ることによって差し支えないこと。

(9) その他

- ・各実施医療機関に関する特記事項があれば入力すること。

(10) 脚注

- ・1 組当たりの割付数量など、すべての実施医療機関に共通の事項がある場合に入力すること。

【事例】

- ・ XML ファイルの脚注欄については、GCP 業務支援システムによっては入力文字数に制限（全角で 512 文字、半角で 1024 文字）がある。

5. 参照する治験届出情報

- ・当該治験届出が参照する治験届出の情報があれば、以下の内容を入力すること。
- ・「医薬品/医療機器/再生医療等製品の別」の項に参照する治験届出の主たる被験薬、主たる被験機器又は主たる被験製品の「医薬品」、「医療機器」又は「再生医療等製品」のいずれかを入力すること。
- ・「治験成分記号又は治験識別記号」の項に参照する治験届出の主たる被験薬の治験成分記号又は主たる被験機器若しくは主たる被験製品の治験識別記号を入力すること。また、参照する治験届出の「届出回数」を入力すること。

- ・その上で、「参照の区分」の項は「1」又は「2」を半角数字で入力し、「参照の詳細」の項に、参照内容の詳細について具体的に記載すること。

6. ケース別事例のまとめ

(1) 製造販売後臨床試験への切替え（事例）

【事例】

- ・ 治験から製造販売後臨床試験への切替えを予定している場合の治験届等の記載について、以下の記載とした。
 - 治験計画届、実施計画書等への「開発の相」「試験の種類」の記載については、「第 III 相」「検証的試験」とした。
 - 治験薬の継続提供を行う試験の場合の「開発の相」「試験の種類」は、「第 III 相」「継続投与試験」とした。
 - 承認取得後、治験から製造販売後臨床試験への切替えを予定している旨については、治験実施計画書、治験計画届の両方に記載する。治験計画届への記載については、「備考欄」に①本試験を承認日まで実施すること、②承認取得後は、治験から製造販売後臨床試験へ切り替えることについて記載する。治験実施計画書への記載についても、治験計画届と整合性が合うように記載する。
 - 治験終了日の記載については、仮の予定日を入力すること。仮の予定日については、承認が見込まれる日より後の日付を入力した方がよい。承認日より前になるようであれば、治験計画変更届の提出が必要になる。
 - 治験計画届の予定被験者数の記載については、治験から製造販売後臨床試験を通した全期間の例数ではなく、治験の被験者数を記載する。
 - 治験薬の継続提供を行う試験の場合、治験薬から市販薬への切替えを予定している旨については、治験計画届への記載は必要ない。
 - 治験計画変更届にて同様の届出をすることも可能である。
 - 治験終了届の提出時期については、施設からの治験薬の回収が終了した時点で、すみやかに届け出る。
- ・ 承認までは治験を継続し、それ以降各治験実施医療機関において処方可能となるまで製造販売後臨床試験に切り替えて薬剤投与を継続する場合、備考欄にその旨が明確となるよう記載することとの指示を審査部から受け、以下のように記載した。

「治験実施期間は、製造販売承認取得日までとし、製造販売承認取得後は治験から製造販売後臨床試験に切り替える。製造販売後臨床試験は、製造販売承認取得日から各実施医療機関で処方可能となる日までとする。」
- ・ 備考欄に「承認日まで」と記載した類似事例あり。

(2) 共同開発、会社合併、承継等、治験届に他社が関係する場合の事例（一部再掲）

【事例】

- ・ 既承認の成分を別の会社が単独で開発する場合、新規の治験成分記号を設定できるが、治

験計画届の備考欄に、本薬は異なる治験成分記号で他社により国内開発が実施されている旨を記載した（p52）。

- ・ 既承認の成分を別の会社が単独で開発する場合、同一組成、同一投与経路であるならば、初回治験計画届であっても 30 日調査の対象外となった。なお、備考欄に開発の経緯を記載した（p55）。
- ・ コンパニオン診断薬等の国内外の承認取得の有無、開発企業名、開発に関する連携状況を可能な範囲で簡潔に記載した。その際、以下の通知を参考にした。
 - 「コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事項について（平成 25 年 7 月 1 日 薬食審査発 0701 第 10 号）」
 - 「コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品に関する質疑応答集（Q&A）について（平成 25 年 7 月 1 日 事務連絡）」の Q6・A6（p63）
- ・ A 社が承認会社である品目 X についての効能追加を B 社と共同開発するが、治験は B 社が単独で行う場合の届出内容について確認した（p64）。
 - 届出者について
 - ◇ 治験計画届は、B 社単独名でよい。
 - 備考欄への記載（治験届出と A 社との紐付け）
 - ◇ 本治験は、A 社（業者コード XX00XX000）との共同開発である。
 - ◇ 本治験は、A 社の製造販売承認品目である「品目 X（承認番号〇〇）」の製造販売承認事項一部変更承認申請のために実施するものである。
 - ◇ 本治験は、B 社が単独で治験依頼者となり実施するものである。
 - 治験成分記号については、A 社が過去に使用していた記号が望ましい。別の記号でも可能であるが、その場合は、以下の手続きが必要になる。
 - ◇ 第〇回治験計画届出～第〇回治験計画届出までは A 社が届出し、第〇回治験計画届出は B 社が届出した旨が分かるような一覧表を提出する。
 - ◇ 届出の備考欄への記載
 - 治験成分記号を●から▲に変更すること
 - 治験薬の製造方法及び製造所は共同開発会社で開発中の薬剤と同一であること
 - （既承認医薬品である場合）既承認医薬品であることに加え、投与経路を変更することなく使用すること
 - （既に別の治験成分記号を使用し初回治験計画届が提出され、かつ、バイオ医薬品でない場合）30 日調査には該当しないこと
 - 初回届出年月日・受付番号について
 - ◇ A 社の初回承認時の開発における初回の治験計画届出日を記載する。
なお、品目 X について平成 9 年 4 月以降の治験が無い場合は、初回届出受付番号は今回の治験計画届出時の受付番号になる。
 - 届出回数について
 - ◇ A 社が過去行っていた治験に続けて n 回治験計画届とする。

- 会社の合併時点で継続予定の治験について、治験実施の体制（実態）に変更がなければ、治験計画変更届（治験届出者の変更）で対応可能であった（存続会社、消滅会社とも）。提出時期は「合併後速やかに提出（目安として1か月以内）」で良いとされた。
- 開発品承継に伴う継続中の治験（第 n 回治験計画届）に係る治験届等の手続きについて確認した（治験の途中で治験依頼者が被承継会社→承継会社に変更になる場合）。
 - 治験実施の体制（実態）が変更となる場合は、承継日以降に承継会社より新たに治験計画届（第 $n+1$ 回治験計画届）を提出する。その際、新たな治験実施体制が記載された治験実施計画書等の添付資料一式もあわせて提出する。
 - 承継会社が届け出た第 $n+1$ 回治験計画届の PMDA による調査終了後、被承継会社は第 n 回治験計画届に係る治験終了届を提出すること。その際、治験薬の回収数量の項は「0」と記入し、備考欄に「第 $n+1$ 回届出治験終了時に治験薬回収数量を記入する」旨の記載をする。また、備考欄には「治験依頼者変更に伴う治験終了」である旨を記載する。

(3) 初回治験計画届と n 回治験計画届を同時期に提出する場合の事例（再掲）

【事例】

- 同一薬物について本邦で 30 日調査対象の初回の治験と第 2 回の治験をほぼ同時期に行う場合、30 日調査対象の初回治験計画届と対象外の治験計画届書の提出時期について PMDA（担当審査部及び審査マネジメント部）に相談することが望ましい。状況により、下記のような対応をするよう指示を受けた（p31）。
 - 30 日調査が終了するまで第 2 回治験計画届（以降）の届は提出しない
 - 30 日調査が終了する 2 週間程度前に第 2 回治験計画届（以降）の届を提出する
 - 複数の治験計画届書を同時に提出するが、第 2 回治験計画届以降の届書について「30 日調査での指摘事項を第 2 回治験計画届以降の届書に反映させる、30 日調査終了まで第 2 回治験計画届以降の届書にかかる治験を開始しない」との内容を記載した念書を添付する
- 30 日調査対象の初回治験計画届と第 2 回の治験計画届を同時に提出する場合の「念書」について審査マネジメント部に確認したところ、「初回治験計画届で資料の差替えが必要とされた場合には、その内容が第 2 回治験計画届にも該当する場合には、同じく差替えを行う」ことについても記載するよう連絡を受けた。なお、念書の差出人と宛先は、届書が代表者から PMDA 理事長宛に提出されるものであるため、それに倣って念書も代表者から PMDA 理事長宛としていることが多い（p32）。

治験計画届後に発出された照会事項（参考情報）

【事例】

治験計画届後に発出された照会事項のうち、複数社で類似した照会を受けた事例を以下に示す。

・ 生殖発生毒性試験について

後期第Ⅱ相試験以前の試験で妊娠可能な女性（最大 150 人）が組み入れられ、かつ比較的短期間（最長 3 か月）の治験が実施される際に、予備的発生毒性データが治験薬概要書に記載されていない場合に照会が発出される場合がある。

・ 光毒性試験について

第Ⅰ相試験、第Ⅱ相試験の治験計画届時で治験薬概要書に光毒性試験結果が記載されていない場合に初期評価を質問する照会を発出される場合がある。

・ 構造式について

構造式が治験薬概要書に記載されていなかった際に、照会を受ける場合がある。

・ 治験実施体制について

- 実施医療機関に治験を依頼する際に、本治験の実施に当たって適切な治験責任（分担）医師であることの確認方法に関して、治験薬の作用機序、予想される有害事象、被験者組入れの際の検査内容の観点から、個々の医師の専門性等を踏まえて説明するよう照会を受ける場合がある。
- 実施医療機関に治験を依頼する際に、十分な臨床観察及び試験検査を行う設備及び人員を有すること、緊急時に被験者に対して必要な措置を講ずることができること等を確認する必要があるが、本治験において実施医療機関が緊急時にどのように必要な診断、措置を講じることとなっているのか、被験薬で予想される有害事象を踏まえて詳細に説明するよう、治験を実施するに際して十分な臨床観察及び試験検査を行う設備及び人員を有すると判断した理由を詳細に説明するよう照会を受ける場合がある。
- 実施医療機関について治験責任医師のみが届け出られている場合、今後、治験分担医師を追加する場合には、その旨を回答し、治験分担医師が決定次第、必要な手続きを行うよう照会を受ける場合がある。治験分担医師を追加しない場合には、本治験が治験責任医師 1 名のみで実施可能であると考えた経緯・理由について、被験者の安全性確保の観点から説明するよう照会を受ける場合がある。

・ 安全性情報の入手及び連絡体制について

- 複数の実施医療機関での治験実施が予定される場合、実施医療機関から入手した安全性情報を他の実施医療機関へ連絡する体制（情報入手から他の医療機関へ伝達するまでの時間（hr）、電話・FAX 等の連絡手段、人員等）について、（i）治験継続に影響を及ぼすような重大な安全性情報の場合と、（ii）それ以外の情報の場合に分けて、図表等を用いて説

明するよう照会を受ける場合がある。

- 海外から報告される安全性情報の入手体制（人員や夜間・休日の対応等）及び入手した安全性情報の実施医療機関への連絡体制（情報入手から他の医療機関へ伝達するまでの時間（hr）、電話・FAX等の連絡手段、人員等）について、（i）治験継続に影響を及ぼすような重大な安全性情報の場合と、（ii）それ以外の情報の場合に分けて、図表等を用いて説明するよう照会を受ける場合がある。

・ 治験実施計画書及び治験薬概要書について

日本語版及び英語版が提出されている場合、国内実施医療機関において日本語版と英語版のいずれを正本として使用するかを説明するよう照会を受ける場合がある。また、英語版を正本とする場合、日本語版と英語版が同一の内容であることを担保するよう照会を受ける場合がある。

・ 用量制限毒性（以下、DLT）評価期間における入院規定について

「「抗悪性腫瘍薬の臨床評価方法に関するガイドライン」の改訂について」（平成 17 年 11 月 1 日付け薬食審査発第 1101001 号）を踏まえ、DLT 評価期間は入院とする規定とするよう、DLT 評価期間内に退院が可能とする場合、以下の内容を回答するよう照会を受ける場合がある。

- ① DLT 評価期間内に退院した場合でも、被験者の安全を確保できる理由を説明するとともに、被験者の外来管理下での安全確保に関して、外来管理可能な被験者の条件（被験者の健康状態、被験者の生活環境、被験者への情報提供等）、被験者等との連絡体制、実施医療機関と自宅近隣医療施設との緊急時の連携等について説明する。
- ② 医師が入院被験者の退院の可否を当日判断するための検査・診察等を治験実施計画書に記載する。

・ M7 関連資料について

原薬、製剤の製造工程、保管期間において、それぞれ新たに生成する実際の不純物及び生成する可能性の高い潜在的な不純物を M7 ガイドラインを踏まえて評価結果を説明するよう、また、M7 関連資料に当該評価結果及びリスクを軽減する取組みに関する説明の追記を検討するよう照会を受ける場合がある。

薬効分類

番号	分類名
	中枢神経系用薬
111	全身麻酔剤
112	催眠鎮静剤、抗不安剤
113	抗てんかん剤
114	解熱鎮痛消炎剤
115	興奮剤、覚せい剤
116	抗パーキンソン剤
117	精神神経用剤
118	総合感冒剤
119	その他の中枢神経系用薬
	末梢神経系用薬
121	局所麻酔剤
122	骨格筋弛緩剤
123	自律神経剤
124	鎮けい剤
125	発汗剤、止汗剤
129	その他の末梢神経系用薬
	感覚器官用薬
131	眼科用剤
132	耳鼻科用剤
133	鎮量剤
139	その他の感覚器官用薬
	その他の神経系及び感覚器官用医薬品
190	その他の神経系及び感覚器官用医薬品
	循環器官用薬
211	強心剤
212	不整脈用剤
213	利尿剤
214	血圧降下剤
215	血管補強剤
216	血管収縮剤
217	血管拡張剤
218	高脂血症用剤
219	その他の循環器官用薬
	呼吸器官用薬
221	呼吸促進剤
222	鎮咳剤
223	去たん剤
224	鎮咳去たん剤
225	気管支拡張剤
226	含嗽剤
229	その他の呼吸器官用薬
	消化器官用薬
231	止しゃ剤、整腸剤
232	消化性潰瘍用剤
233	健胃消化剤
234	制酸剤
235	下剤、浣腸剤
236	利胆剤
237	複合胃腸剤
239	その他の消化器官用薬
	ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
241	脳下垂体ホルモン剤
242	唾液腺ホルモン剤
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
244	たん白同化ステロイド剤
245	副腎ホルモン剤

246	男性ホルモン剤
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
248	混合ホルモン剤
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
	泌尿生殖器官及び肛門用薬
251	泌尿器官用剤
252	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）
253	子宮収縮剤
254	避妊剤
255	痔疾用剤
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
	外皮用薬
261	外皮用殺菌消毒剤
262	創傷保護剤
263	化膿性疾患用剤
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
265	寄生性皮膚疾患用剤
266	皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）
267	毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）
268	浴剤
269	その他の外皮用薬
	歯科口腔用薬
271	歯科用局所麻酔剤
272	歯髄失活剤
273	歯科用鎮痛鎮静剤（根管及び齲窩消毒剤を含む。）
274	歯髄乾屍剤（根管充填剤を含む。）
275	歯髄覆罩剤
276	歯科用抗生物質製剤
279	その他の歯科口腔用薬
	その他の個々の器官系用医薬品
290	その他の個々の器官系用医薬品
	ビタミン剤
311	ビタミンA及びD剤
312	ビタミンB ₁ 剤
313	ビタミンB剤（ビタミンB ₁ 剤を除く。）
314	ビタミンC剤
315	ビタミンE剤
316	ビタミンK剤
317	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）
319	その他のビタミン剤
	滋養強壮薬
321	カルシウム剤
322	無機質製剤
323	糖類剤
324	有機酸製剤
325	たん白アミノ酸製剤
326	臓器製剤
327	乳幼児用剤
329	その他の滋養強壮薬
	血液・体液用薬
331	血液代用剤
332	止血剤
333	血液凝固阻止剤
339	その他の血液・体液用薬
	人工透析用薬
341	人工腎臓透析用剤
342	腹膜透析用剤
349	その他の人工透析用薬
	その他の代謝性医薬品

391	肝臓疾患用剤
392	解毒剤
393	習慣性中毒用剤
394	痛風治療剤
395	酵素製剤
396	糖尿病用剤
397	総合代謝性製剤
399	他に分類されない代謝性医薬品
	細胞賦活用薬
411	クロロフィル製剤
412	色素製剤
419	その他の細胞賦活用薬
	腫瘍用薬
421	アルキル化剤
422	代謝拮抗剤
423	抗腫瘍性抗生物質製剤
424	抗腫瘍性植物成分製剤
429	その他の腫瘍用薬
	放射性医薬品
430	放射性医薬品
	アレルギー用薬
441	抗ヒスタミン剤
442	刺激療法剤
443	非特異性免疫原製剤
449	その他のアレルギー用薬
	その他の組織細胞機能用医薬品
490	その他の組織細胞機能用医薬品
	生薬及び漢方処方にに基づく医薬品
510	生薬
520	漢方製剤
590	その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品
	抗生物質製剤
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの
612	主としてグラム陰性菌に作用するもの
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの
616	主として抗酸菌に作用するもの
617	主としてカビに作用するもの
619	その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）
	化学療法剤
621	サルファ剤
622	抗結核剤
623	抗ハンセン病剤
624	合成抗菌剤
625	抗ウイルス剤
629	その他の化学療法剤
	生物学的製剤
631	ワクチン類
632	毒素及びトキシノイド類
633	抗毒素及び抗レプトスピラ血清類
634	血液製剤類
635	生物学的試験用製剤類
636	混合生物学的製剤
639	その他の生物学的製剤
	寄生動物用薬
641	抗原虫剤
642	駆虫剤
649	その他の寄生動物用薬

	その他の病原生物に対する医薬品
690	その他の病原生物に対する医薬品
	調剤用薬
711	賦形剤
712	軟膏基剤
713	溶解剤
714	矯味、矯臭、着色剤
715	乳化剤
719	その他の調剤用薬
	診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
721	X線造影剤
722	機能検査用試薬
729	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
	公衆衛生用薬
731	防腐剤
732	防疫用殺菌消毒剤
733	防虫剤
734	殺虫剤
735	殺そ剤
739	その他の公衆衛生用薬
	体外診断用医薬品
741	一般検査用試薬
742	血液検査用試薬
743	生化学的検査用試薬
744	免疫血清学的検査用試薬
745	細菌学的検査用薬
746	病理組織検査用薬
747	体外診断用放射性医薬品
749	その他の体外診断用医薬品
	その他の治療を主目的としない医薬品
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品
	アルカロイド系麻薬（天然麻薬）
811	あへんアルカロイド系麻薬
812	コカアルカロイド系製剤
819	その他のアルカロイド系麻薬（天然麻薬）
	非アルカロイド系麻薬
821	合成麻薬
829	その他の非アルカロイド系麻薬
	その他の麻薬
890	その他の麻薬

大学番号一覧

010	愛知医科大学	330	慶應義塾大学	650	名古屋市立大学
020	愛知学院大学	340	高知大学	660	名古屋大学
030	秋田大学	350	神戸大学	670	奈良県立医科大学
040	旭川医科大学	360	埼玉医科大学	680	新潟大学
050	朝日大学	370	佐賀大学	690	日本医科大学
060	岩手医科大学	380	札幌医科大学	700	日本歯科大学
070	愛媛大学	390	産業医科大学	710	日本大学
080	大分大学	400	滋賀医科大学	720	浜松医科大学
090	奥羽大学	410	自治医科大学	730	兵庫医科大学
100	大阪医科薬科大学	420	島根大学	740	弘前大学
110	大阪歯科大学	430	順天堂大学	750	広島大学
120	大阪市立大学	440	昭和大学	760	福井大学
130	大阪大学	450	信州大学	770	福岡歯科大学
140	岡山大学	460	聖マリアンナ医科大学	780	福岡大学
150	香川大学	470	千葉大学	790	福島県立医科大学
160	鹿児島大学	480	筑波大学	800	藤田医科大学
170	神奈川歯科大学	490	鶴見大学	810	防衛医科大学校
180	金沢医科大学	500	帝京大学	820	北海道医療大学
190	金沢大学	510	東海大学	830	北海道大学
200	川崎医科大学	520	東京医科歯科大学	840	松本歯科大学
210	関西医科大学	530	東京医科大学	850	三重大学
220	北里大学	540	東京歯科大学	860	宮崎大学
230	岐阜大学	550	東京慈恵会医科大学	870	明海大学
240	九州歯科大学	560	東京女子医科大学	880	山形大学
250	九州大学	570	東京大学	890	山口大学
260	京都大学	580	東邦大学	900	山梨大学
270	京都府立医科大学	590	東北大学	910	横浜市立大学
280	杏林大学	600	徳島大学	920	琉球大学
290	近畿大学	610	獨協医科大学	930	和歌山県立医科大学
300	熊本大学	620	鳥取大学		
310	久留米大学	630	富山大学	999	外国の大学
320	群馬大学	640	長崎大学		

注) 大学の名称が変更された等の理由により該当する名称がない場合には現在の名称に読み替えて入力すること。

6 ファイル名、提出方法等

1. ファイル名

(1) PDF 形式

1) ファイル名は、半角英数字及び記号で作成し以下の形式とする。

届書の種類	届書分類		ファイル名*	ファイル名の例
治験計画届	K	届書	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 .pdf	TYK-123_03_K.pdf
		添付資料**	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 資料情報 .pdf	TYK-123_03_K_P.pdf
治験計画変更届	H	届書	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 変更回数 .pdf	TYK-123_03_H_12.pdf
		添付資料	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 変更回数 - 資料情報 .pdf	TYK-123_03_H_12_etc.pdf
治験終了届	S	届書	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 .pdf	TYK-123_03_S.pdf
		添付資料	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 資料情報 .pdf	TYK-123_03_S_etc.pdf
治験中止届	C	届書	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 .pdf	TYK-123_03_C.pdf
		添付資料	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 資料情報 .pdf	TYK-123_03_C_etc.pdf
開発中止届	END	届書	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 .pdf	TYK-123_00_END.pdf
		添付資料	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 資料情報 .pdf	TYK-123_00_END_etc.pdf

* 「治験成分記号」は主たる被験薬の治験成分記号を指す

** 非臨床安全性試験の最終報告書のファイル名は 5. 参照

2) 同一資料情報のファイルが複数ある場合には、資料情報に続けて「_」と識別するためのアルファベットを A から順につけること。なお、変更届出時のファイル名に用いるアルファベットは、計画届出時のファイル名に用いたものと同じのものを使用すること。

例：TYK-123_01_K_IB_A.pdf、TYK-123_01_K_IB_B.pdf

3) 差替えの場合はファイル名の最後にバージョン番号を記載する。1 回目の差替え時には「1」を設定し、差し替えるごとに番号を 1 つずつ大きくすること。なお、治験計画変更届のようにファイルの最後が数字となる場合は、バージョン番号の前にアンダーバー（半角）を追加すること。差替えの場合には、差替えファイルのみを記録することで差

し支えない。

例：TYK-123_01_K_P1.pdf、TYK-123_01_K_IB_A1.pdf、TYK-123_01_H_02_1.pdf

- 4) 開発中止届書の場合は、届出回数を「00」として作成する。

例：TYK-123_00_END.pdf

【事例】

- 併用薬がある試験において、治験計画届に添付する主たる被験薬と併用薬の各治験薬概要書のファイル名は、いずれも主たる被験薬の成分記号を使用し末尾に A、B をそれぞれ付記するように指示を受けた。

主たる被験薬の治験成分記号_届出回数_届出分類.pdf

主たる被験薬：XXX-1234_回数_K_IB_A.pdf

併用薬：XXX-1234_回数_K_IB_B.pdf

(2) XML 形式

ファイル名は、すべての文字を半角英数字及び記号で作成し以下の形式とする。

ファイル名*			ファイル名の例
届出者の氏名	治験成分記号	届出回数.xml	toyakuseiyaku_TYK-123_03.xml

*「治験成分記号」は主たる被験薬の治験成分記号を指す

なお、以下の点に留意して作成すること。

- 届出者の氏名などは適宜ローマ字などに置き換えること。
- 届出者の氏名及び治験成分記号には、アンダーバー、ピリオド及び空白文字を用いないこと。

(3) 非臨床安全性試験（毒性試験及び安全性薬理試験）の最終報告書の zip ファイルのファイル名

非臨床安全性試験（毒性試験及び安全性薬理試験）の最終報告書のファイルを 1 つのフォルダにまとめ、当該フォルダを zip にする際、zip のファイル名は、すべての文字を半角英数字及び記号で作成し以下の形式とする。

ファイル名*	ファイル名の例
治験成分記号_届出回数_届出分類_TR.zip	TYK-123_01_K_TR.zip

*「治験成分記号」は主たる被験薬の治験成分記号を指す

2. 全般的な留意事項

治験成分記号はハイフン、スペースなども含めて正確に記載する。届出回数は治験計画届書の届出回数とする。拡張子は小文字を用いる。また、「_」はアンダーバー（半角）を用いる。

なお、ファイル名の文字数は、拡張子を含めて 255 バイト以下とすること。

[R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号 別添 2 [一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、
R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号]]

3. 資料情報

当該治験の依頼を科学的に正当と判断した理由を記した文書	R
治験実施計画書	P
インフォームド・コンセントに用いられる説明文書及び同意文書	IC
症例報告書の見本	CRF
最新の治験薬概要書	IB
被験薬以外の治験使用薬に係る最新の科学的知見について記載した文書（添付文書、インタビューフォーム、学術論文等）	SF
その他（【運用】M7 関連資料など）	etc

[R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号 別添 2 [一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、
R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号]]

4. ファイルへの入力形式

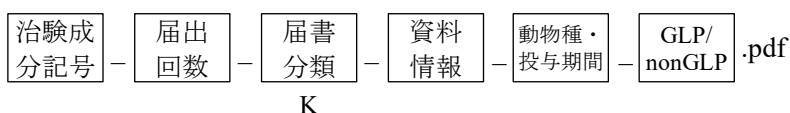
日本産業規格「拡張可能なマーク付け言語 XML」（JISX4159）に準拠すること。

[R2.8.31 薬生薬審発 0831 第 10 号 別添 2 [一部改正 R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 1 号、
R5.3.30 薬生薬審発 0330 第 3 号]]

5. 初めてヒトに投与する薬物に係る治験の計画の届出時における非臨床安全性試験（毒性試験及び安全性薬理試験）の最終報告書の提出方法

- ・ファイルは原則、試験毎とする。ファイルは PDF 形式とすることが望ましく、それ以外の形式の場合には、提出前に PMDA に問い合わせること。
- ・ファイル名は 1)、2) に準じ、半角英数字及び半角記号を用いて、以下の通りとする。ファイル名のうち資料情報は下表を参考とするとともに、当該試験が GLP 準拠で実施されたものであるかを確認して「GLP」又は「nonGLP」の文字列を付すこと。

- ・ファイル名の付け方



- ・資料情報

単回投与毒性試験	TR-SD
反復投与毒性試験	TR-RD
遺伝毒性試験	TR-GT
安全性薬理試験	TR-SP
その他	TR-others

例：治験成分記号が「TYK-123」のときの、GLP 準拠の単回投与毒性試験の最終報告書（ラット）が 1 報、反復投与毒性試験の最終報告書が 2 報（ラット及びイヌの 4 週投与）のファイル名

TYK-123_01_K_TR-SD_Rat_GLP.pdf

TYK-123_01_K_TR-RD_Rat4w_GLP.pdf

TYK-123_01_K_TR-RD_Dog4w_GLP.pdf

[R1.6.20 薬機審査長発第 0620003 号、薬機審長発第 0620004 号]

Ⅲ. 治験計画変更届書

1 治験計画変更届の届出の対象

- ・届出に係る事項を変更したときは、その内容及び理由等を届け出ること（規則第 270 条）。
- ・治験計画の届出事項については、その更新の必要性の有無を確認するために、届出日より半年を目安に定期的に見直しを行うことが望ましいこと。
- ・実態の変更を伴う届出者の変更は、治験計画変更届でなく新規の治験計画届出を要すること。
- ・【運用】臨床検査の追加等（例えば、総コレステロールの追加）、治験実施計画書等の添付資料内容の軽微な変更は、原則として、治験計画変更届書の提出は必要ない。

2 治験計画変更届書の提出時期

- ・治験計画届書に変更が生じる場合に、原則として、治験計画届書ごとに変更の前に届け出ること。
- ・届書に 30 日調査対象の被験薬を追加する場合は、当該被験薬を追加した治験実施計画書で治験を実施する 30 日以上前に届け出ること。
- ・30 日調査対象外の被験薬を追加する場合又は本邦において安全性情報が十分に蓄積されていない治験使用薬（被験薬を除く。）を追加する場合は、当該被験薬又は当該治験使用薬（被験薬を除く。）を追加した治験実施計画書で治験を実施する 2 週間程度前に届け出ること。
- ・目的又は対象疾患を変更する場合、目的又は対象疾患を変更した治験実施計画書で治験を実施する 2 週間程度前に届け出ること。
- ・治験使用薬の追加を当局から指示された場合、既に届け出た届書の差替え対応ではなく、次に届け出る治験計画変更届書において治験使用薬を追加する対応を行ってよいが、治験使用薬の追加について当局と合意した場合においては、速やかに治験使用薬の追加に伴う副作用等報告等の体制を整えた上で、遅滞なく治験計画変更届書を届け出ること。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q7・A7〕

- ・次に掲げる事項については、変更後 6 ヶ月（ただし、治験分担医師の氏名の変更並びに追加及び削除のみの変更については 1 年）を目安としてまとめて届け出ることと差し支えないこと。また、治験使用薬の予定交付（入手）数量及び予定被験者数は、治験の実施に伴って生じた数量及び被験者数の変更については届け出る必要はなく、治験終了届書又は治験中止届書にてまとめて届け出ることと差し支えない。

また、最後の治験計画変更届書を届け出してから 6 ヶ月（ただし、治験分担医師の氏名の変更並びに追加及び削除の変更については 1 年）が経過する前に治験終了届書又は治験中止届書を届け出る場合、それまでに発生した変更事項（次に掲げる事項に限る）については、治験終了届書又は治験中止届書中に入力し、届け出ることと差し支えない。

- ・実態の変更を伴わない製造所又は営業所の名称及び所在地並びに業者コードの変更

- ・日本薬局方の改正に伴う一般名表記の変更及びJAN 決定等の実態の変更を伴わない成分及び分量の変更
- ・輸入先国の製造業者の名称のみの変更及び輸入先国での販売名の変更等の実態の変更を伴わない製造方法の変更
- ・実施期間に関して、治験契約が最も早い実施医療機関との契約締結日のずれによる軽微な変更（なお、実施医療機関における観察終了予定日のうち最も遅い日を延期する場合には事前に届け出ること。）
- ・治験調整医師及び治験調整委員会の構成医師の削除並びに治験調整医師及び治験調整委員会の構成医師の氏名、所属機関、所属の変更
- ・治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を受託する者（開発業務受託機関（CRO））の氏名、住所及び委託する業務範囲の変更並びに追加及び削除
- ・治験届出者の氏名（実態の変更を伴わない法人名の変更及び代表者の変更）、住所及び業者コードの変更
- ・届出担当者の氏名、所属・電話及び FAX 番号又はメールアドレスの変更並びに追加及び削除（変更後の担当者との連絡がとれるよう社内体制を整備しておくこと）
- ・外国製造業者の氏名（実態の変更を伴わない法人名の変更及び代表者の変更）及び住所の変更
- ・契約に至らなかった実施医療機関の削除
- ・実施医療機関の名称・実施診療科及び所在地・代表電話番号の変更
- ・治験責任医師の氏名の変更
- ・実施医療機関の削除に伴う治験責任医師の削除
- ・治験分担医師の氏名の変更並びに追加及び削除
- ・治験の実施に関する業務の一部を実施医療機関から受託する者（治験施設支援機関（SMO）等）の氏名、住所及び委託する業務範囲の変更並びに追加及び削除
- ・治験審査委員会の設置者の名称及び所在地の変更並びに追加及び削除

各変更事項と提出時期の関係を次ページの表に示す。

変更後 6 ヶ月を目安に届出可能な事項

治験計画変更届の項目			届出可能時期及び変更内容	
届出事項			変更事項及び備考	
主たる被験薬の情報	主たる被験薬の製造所又は営業所の名称及び所在地	名称	○	実態の変更を伴わない変更
		所在地		
		業者コード		
	主たる被験薬の成分及び分量情報	成分及び分量	○	日局改正に伴う一般名表記変更、JAN 決定等、実態の変更を伴わない変更
	主たる被験薬の製造方法		○	輸入先国の製造業者の名称のみの変更、輸入先国での販売名の変更等、実態の変更を伴わない変更
治験計画の概要	予定被験者数情報		終了時 or 中止時	治験の実施に伴って生じた変更については、変更の届出は原則として不要である。治験終了届書又は治験中止届書にて当該治験に参加したすべての被験者数を入力する。
	用法及び用量情報*		○	実態の変更を伴わない言い回しの変更 実態の変更を伴う場合は事前に届け出ること。
	実施期間	開始日年月日	○	治験契約が最も早い実施医療機関との契約締結日のずれによる軽微な変更
		終了日年月日	—	実施医療機関における観察終了予定日のうち最も遅い日を延期する場合には事前に届け出ること。
	治験調整医師又は治験調整委員会構成医師に関する情報	追加	—	
		削除	○	
		氏名、所属機関、所属の変更	○	
	治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を受託する者（CRO）の氏名、住所及び委託する業務範囲	変更、追加、削除	○	
治験使用薬等の情報	治験使用薬等*の追加		—	
	製造所又は営業所の名称及び所在地	名称	○	実態の変更を伴わない変更
		所在地		
		業者コード		
	成分及び分量情報	成分及び分量	○	日局改正に伴う一般名表記変更、JAN 決定等、実態の変更を伴わない変更
	製造方法		○	輸入先国の製造業者の名称のみの変更、輸入先国での販売名の変更等、実態の変更を伴わない変更
その他	備考		○	届出内容に応じて届出時期を決めればよい。当該事項のみの変更に対する届出は不要。
	届書添付資料		○	届出内容に応じて届出時期を決めればよい。
治験届出者に関する情報	届出者の氏名（法人名の変更及び代表者の変更）、住所、業者コード		○	実態の変更を伴わない法人名の変更及び代表者の変更住所及び業者コードの変更 実態の変更を伴う届出者の変更は、変更届でなく新規の届出を要する。
	届出担当者の氏名、所属、電話・FAX 番号、メールアドレス	変更、追加、削除	○	変更後の担当者と連絡がとれるよう社内体制を整備しておくこと。
	外国製造業者の氏名（法人名の変更及び代表者の変更）、住所【邦文・外国文】		○	実態の変更を伴わない法人名の変更及び代表者の変更住所の変更
実施医療機関ごと	実施医療機関に関する情報	追加	—	
		名称・実施診療科及び所在地・代表電話番号の変更	○	
		契約に至らなかった実施医療機関の削除	○	
	治験責任医師に関する情報	追加	—	
		実施医療機関の削除に伴う削除	○	
		氏名（姓名）の変更	○	

治験計画変更届の項目			届出可能時期及び変更内容	
の 事 項	治験分担医師に関する情報	追加・削除・ 氏名（姓名）の変更	◎	治験分担医師の氏名（姓名）の変更並びに追加及び削除のみの変更については、変更後1年を目安としてまとめて届け出ること で差し支えない。なお、1年が経過するまでに発生した変更事項については、治験終了届書又は治験中止届書にてまとめて届け出ること で差し支えない。
	治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の数量情報	治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の記号・名称等	—	治験使用薬の予定交付（入手）数量及び予定被験者数は、治験の実施に伴って生じた数量及び被験者数の変更については届け出る必要はなく、治験終了届書又は治験中止届書にてまとめて届け出ること で差し支えない。
		変更	終了時 or 中止時	
	予定被験者数	変更	○	
	治験実施に係る業務の一部を実施医療機関から受託する者（SMO等）の氏名、住所及び委託する業務範囲	変更、追加、削除	○	
	治験審査委員会の設置者の名称、及び所在地	変更、追加、削除	○	
	脚注		○	届出内容に応じて届出時期を決めればよい。当該事項のみの変更に対する届出は不要。
○：変更後6ヵ月を目安に届出可能な事項、 ◎：変更後1年を目安としてまとめて届け出ること で差し支えない事項 一：原則として、変更の前に届け出る事項 ※：便宜的に「治験使用薬等」＝「治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）」として記載した。 ＊：用法及び用量の変更とあわせて目的や対象疾患を変更する場合は、目的又は対象疾患を変更した治験実施計画書で治験を実施する2週間程度前に届け出る。 誤字・脱字の変更については、すべての項目につき随時変更可能なため、本表には記載していない。				

3 治験計画変更届書の作成に関する一般的注意事項

（「Ⅱ．治験計画届書 3 治験計画届書の作成に関する一般的注意事項（p34）」を参照）

1. 治験計画変更届書共通事項

- ・ 治験計画変更届書は治験計画届書ごとに作成すること。
- ・ 治験計画変更届書については、変更後の内容を記載するとともに、変更区分として「追加」、「変更」、「削除」の別、変更年月日、変更理由（200 字以内）を入力すること。また、変更以外の事項についてもすべて入力すること。
- ・ 変更年月日については、変更後の内容での開始（予定）日を変更（予定）年月日として入力すること。
- ・ 治験計画変更届において、以下の変更が行われた場合、主たる治験及び拡大治験に関する情報について PMDA のホームページの更新を行う。
 - 被験薬の追加
 - 本質的な対象疾患の変更

[R4.8.31 薬生薬審発 0831 第 3 号]

2. 添付資料の作成に関する一般的事項

(1) 30 日調査対象となる治験計画変更届書（届出区分「1」に該当）の場合

「Ⅱ．治験計画届書 3 治験計画届書の作成に関する一般的注意事項 3. 添付資料の作成に関する一般的事項 (1) 30 日調査対象となる届書（届出区分「1」に該当）に添付すべき資料（p35）」を参照。

(2) 追加する被験薬が 30 日調査に該当しない治験計画変更届書（届出区分「2」に該当）の場合

「Ⅱ．治験計画届書 3 治験計画届書の作成に関する一般的注意事項 3. 添付資料の作成に関する一般的事項 (2) 30 日調査に該当しない届書（届出区分「2」に該当）に添付すべき資料（p38）」を参照

(3) (1)(2)以外の届書

必要に応じ、変更事項に関する資料を提出する。

- ・ 被験薬以外の治験使用薬に係る最新の科学的知見を記載した文書を既に届書の添付資料としている場合で、当該治験使用薬の成分が同じ別の製剤に治験の途中で変更した場合、変更後の製剤に係る最新の科学的知見を記載した文書の添付は以下とする。
 - 治験計画変更届書の届出の際に、変更後の製剤が国内未承認の製剤であり海外で承認されている製剤である場合：最新の科学的知見を記載した文書を添付資料とする

必要がある。

- 変更後の製剤が国内で既に承認されている製剤の場合：添付資料の備考欄に「本邦既承認製剤■■■の添付文書を用いるため届書に添付しない。」旨記載することにより、添付は要しない。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q21・A21〕

- ・被験薬以外の治験使用薬について、海外輸入品を製剤として使用する場合は最新の科学的知見を記載した文書は以下の通りとする。

- 使用する製剤自体の変更はないものの、当該製剤が製造、販売されている国が変更になる等で、最新の科学的知見を記載した文書が変更になる場合：最新の科学的知見を記載した文書を届書に添付する必要はない。
- 使用する製剤を変更することにより、最新の科学的知見を記載した文書が変更になる場合（例：企業Aの製剤から企業Bの製剤に変更）：届書に添付する必要がある。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q22・A22〕

- ・届出区分が「1」「2」の治験計画変更届を提出する場合で、以下に該当する場合は、治験計画変更届に動画等の内容が把握できる文書をPDF形式で添付する必要がある。

- 治験計画届提出時に、動画等が説明文書に含まれると判断し、動画等の内容が把握できる文書をPDF形式で治験計画届に添付していた場合
- 当該治験計画変更届提出までに実施されたIRBにて動画等が説明文書に含まれると判断された場合
- 治験計画届のPMDA確認期間（30日又は14日）経過後、治験計画届出者が説明文書の改訂により、動画等を説明文書に含めると判断した場合

〔R5.3.30 事務連絡 薬物、機械器具又は加工細胞等に係る治験の計画の届出に関する質疑応答集（Q&A）について Q3・A3〕

4 治験計画変更届書の提出に関する一般的注意事項

（「Ⅰ．申請電子データシステムを利用した治験計画届書等のオンライン提出」（p5）及び「Ⅱ．治験計画届書 4 治験計画届書の提出に関する一般的注意事項（p46）」を参照）

1. 治験計画変更届書共通事項

- ・ファイル名のつけ方については、「Ⅱ．治験計画届書 6 ファイル名、提出方法等（p82）」を参照すること。
- ・届書に30日調査対象の被験薬を追加する場合、当該届書の受理日から起算して30日を経過した後でなければ、当該被験薬の投与等を行ってはならない。ただし、以前から継続している実施医療機関との契約や契約更新手続きを停止したり、当該被験薬を用いないコホ

ートの症例登録を中断したりする必要はない。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答 (Q&A) の改正について Q16・A16〕

- ・ 治験使用薬等を追加等する治験計画変更届の場合、変更届を提出してから当該治験使用薬を追加等した治験が開始されるまでの 30 日間又は 2 週間程度の間、締結済みの実施医療機関との契約や契約更新手続きを停止したり、症例登録を中断したりする必要はない。ただし、当該届書の受理日から起算して 30 日又は 2 週間程度を経過した後でなければ、変更後の治験実施計画書に基づき、当該治験使用薬の投与等は行わないこと。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答 (Q&A) の改正について Q15・A15〕

【事例】

- ・ やむを得ず変更事項の届出が遅延した際、事前に PMDA 審査マネジメント部に連絡の上、遅延理由を示した遅延理由書を添付した。遅延理由書は、【届書添付資料名】欄に「遅延理由書」と記載し、ファイル名末尾は「etc」とするよう指示を受けた。
- ・ PMDA 審査マネジメント部より「遅延理由書に、該当箇所（変更前・変更後）、遅延理由及び再発防止策を記載し、治験届に記載の会社代表者名で PMDA 理事長宛とし、作成日を届出日と同じ日付にすること」との指示を受けた。また、遅延理由書がどの届書に紐づいているか分かるよう、「遅延理由書に、主たる被験薬の治験成分記号、当該治験計画変更届の届出回数、変更回数を記載すること」との指示も受けた。
- ・ PMDA からの修正指示等により届書又は添付資料を差替える場合、期限、提出先、提出方法（該当部分のみ差替えの可否、電子ファイルの要否等）等を確認した。
- ・ 差替えの場合でも、提出日は最初の提出日と同日にするよう指示を受けた。PMDA の受領印は、同日付の場合と差替えた日付の場合があった。

5 治験計画変更届書の記載上の注意事項

（「Ⅱ．治験計画届書 5 治験計画届書の記載上の注意事項（p51）」を参照）

1. 治験届出共通事項

変更年月日については、変更後の内容での開始（予定）日を変更（予定）年月日として入力すること。

(1) 主たる被験薬の治験成分記号

- ・ 主たる被験薬の治験成分記号は、投与経路が異なる被験薬の場合（詳細は「Ⅱ．治験計画届書 5 治験計画届書の記載上の注意事項 1. 治験届出共通事項 (1) 主たる被験薬の治験成分記号（p51）」参照）を除き、同一の有効成分に対して、同一の治験成分記号を用いることを原則とするが、届け出た治験成分記号を変更する場合は、変更を届け出る届書

にて、変更区分、変更年月日及び変更理由を明らかにすること。

- ・複数の被験薬を用いる治験において、複数の被験薬を記載した 1 つの届書を提出している際に主たる被験薬を変更する場合、治験計画変更届書で対応することはできない。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答 (Q&A) の改正について Q55・A55〕

(2) 主たる被験薬の初回届出受付番号

【運用】当該治験計画届書が主たる被験薬の初回の治験計画届書に該当する場合、治験計画届では本項を空欄で提出していることから、最初の治験計画変更届提出のタイミングで、主たる被験薬と同一治験成分記号に係る初回の治験計画届書等の受付番号を半角数字及び半角ハイフンを用いて入力すること。

【事例】（再掲）

- ・ 治験使用薬（主たる被験薬ではない被験薬）として届け出て 30 日調査を実施した製剤を、主たる被験薬として初めて届け出る場合の記載方法について、以下の通り記載するよう PMDA に確認した。
 - 主たる被験薬の初回届出受付番号について、治験計画届は空欄で提出し、治験計画変更届は当該計画届を提出後に付番された（主たる被験薬としての）初回届出受付番号を記載する。

(3) 当該治験計画届出受付番号

当該治験計画届書の受付番号を半角数字及び半角ハイフンを用いて入力すること。

(4) 当該治験計画届出年月日

当該治験計画届書の届出年月日を入力すること。

2. 主たる被験薬に関する届出事項

(1) 届出年月日

当該届出の届出年月日を入力すること。

(2) 届出分類

「治験計画変更届」と入力すること。

(3) 変更回数

治験計画変更届書について、治験計画届書ごとに何回目の変更届にあたるか、その届出回数を半角数字で入力すること。

(4) 届出区分

30 日調査対象の届書は「1」、基本通知の記の 1. (6) ①エ及び②ウに該当する届書は「2」、その他の届書は「3」を半角数字で入力すること。届出区分の考え方については「Ⅱ. 治験計画届書 5 治験計画届書の記載上の注意事項 2. 主たる被験薬に関する届出事項 (4) 届出区分 (p54)」を参照すること。

【事例】

- ・ 治験実施計画書の改訂に伴い治験の目的に軽微な変更があった。事前に審査部に相談し、治験の目的の本質的な変更ではないため、届出区分「3」の治験計画変更届を提出することでよいとの回答を受領し、届出区分「3」で治験計画変更届を提出した。ゲートウェイシステムを利用したオンライン提出時には、備考欄に審査部と事前面談を実施したこと、その際に変更後の治験実施計画書を審査部に提出済みであることを記載した。治験計画変更届提出後、目的が変更されているが、届出区分が「3」になっていることについて、審査部に確認しているかを、審査マネジメント部より確認された。審査部に相談済みであることを回答し、当該変更届は受理された。
- ・ 重要な内容の変更では審査部の確認が必要と考え、変更の 2 週間前に、届出区分「2」で治験計画変更届を提出したところ、治験計画変更届上に記載する届出区分は、通知に記載されている内容のみを「2」とし、それ以外は「3」とすること、重要な変更であると考えられる場合は、届出区分「2」と同じく余裕をもって届け出ることが望ましいことが伝達された。

(5) 主たる被験薬の製造所又は営業所の名称及び所在地

実態の変更を伴わない製造所又は営業所の名称及び所在地並びに業者コードの変更については、変更後 6 ヶ月を目安としてまとめて届け出ることによって差し支えない。

【事例】

- ・ 本社の移転に伴い、PMDA 審査マネジメント部に「製造所又は営業所の名称及び所在地に本社を記載しているが、事前の治験計画変更届出が必要かどうか」を確認したところ、「変更（移転）後 6 ヶ月を目安に届け出ることによって問題ない」との回答を得た。

(6) 主たる被験薬の成分及び分量情報

日本薬局方の改正に伴う一般名表記の変更及び JAN 決定等の実態の変更を伴わない成分及び分量の変更については、変更後 6 ヶ月を目安としてまとめて届け出ることによって差し支えない。

(7) 主たる被験薬の製造方法

輸入先国の製造業者の名称のみの変更及び輸入先国での販売名の変更等の実態の変更を伴わない製造方法の変更については、変更後 6 ヶ月を目安としてまとめて届け出ることによって差し支えない。

支えない。

(8) 治験計画の概要

1) 予定被験者数情報（被験薬、合計）

治験の実施に伴って治験使用薬の交付数量に変更が生じた場合には、当該項目に係る変更の届出は原則として不要である。

2) 主たる被験薬の用法及び用量情報

変更年月日については、変更後の内容での開始（予定）日を変更（予定）年月日として入力すること。

変更理由欄には変更の経過も含め入力する。

3) 実施期間

変更年月日欄については、変更後の内容での開始（予定）日を変更（予定）年月日として入力すること。

実施期間に関して、治験契約が最も早い実施医療機関との契約締結日のずれによる軽微な変更は、変更後 6 ヶ月を目安として届け出ること差し支えないこと。なお、実施医療機関における観察終了予定日のうち最も遅い日を延期する場合には事前に届け出ること。

【事例】

・実施期間変更について、PMDA 審査マネジメント部に問い合わせたところ下記の回答を得た。

- 治験計画届書で届け出た実施期間で網羅された期間内で実際の初回契約が締結される場合（例えば、初回契約締結予定日を 1/1、最終観察終了予定日を翌年 12/31 として届け出し、実際の初回契約締結日が 2/1 となった場合）、変更の届出が実際の初回契約締結日から 6 ヶ月を過ぎた場合でも遅延理由書の提出を求めない。ただし、初回契約締結日が 1 年近く先になる場合には実施期間で網羅された期間内であっても軽微な変更でよいのかとの疑義が生じることから、実態に沿った形で変更届出は行うこと。

なお、同様のケースが発生して PMDA 審査マネジメント部に問い合わせたところ、「遅延理由書」の提出を求められた事例もあることから、6 ヶ月を超えて変更の届出をする場合は PMDA 審査マネジメント部に対応を問い合わせること。

4) 治験調整医師又は治験調整委員会構成医師に関する情報

治験調整医師及び治験調整委員会の構成医師の削除並びに治験調整医師及び治験調整委員会の構成医師の氏名、所属機関、所属の変更は、変更後 6 ヶ月を目安として届け出ること差し支えないこと。

- 5) 治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を受託する者（開発業務受託機関（CRO））の氏名、住所及び委託する業務の範囲

治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を受託する者（開発業務受託機関（CRO））の氏名、住所及び委託する業務範囲の変更並びに追加及び削除は、変更後 6 ヶ月を目安として届け出ることによって差し支えないこと。

(9) 当該届出に関するその他の情報

- ・国際共同治験に関する事項については、当該事項の変更のみの治験計画変更の届出を行う必要はなく、他の理由により、治験計画変更の届出を行う機会があるときに併せて変更することで差し支えないこと。
- ・治験計画を届け出た時点では主たる治験とは考えていなかったが、後に当該治験結果をもって承認申請を行うこととなった場合、治験計画変更届書において、「当該届出に関するその他の情報」の「臨床試験の位置付け」の「該当の有無等」の項を、「該当なし」から「主たる治験」に変更すること。ただし、治験届出者の認識が十分でなかったために主たる治験を表示できず、それにより公開が遅れるという状況は、本制度の趣旨を踏まえると避けなければならない。（p44 参照）

[R4.8.31 事務連絡 人道的見地から実施される治験の実施に関する質疑応答（Q&A）の改正について]

(10) 備考

その他、特記事項があれば入力すること。

- ・1つの届書で主たる被験薬 A と主たる被験薬以外の被験薬 B の届出を行っている場合、被験薬 B に係るコホートが終了したが、他の被験薬（主たる被験薬 A）に係る治験が継続中の場合、被験薬 B に係るコホートが終了した旨の治験計画変更届書を届け出れば、被験薬 B に係る治験終了届書を提出したとみなし、被験薬 B に係るコホートで使用されていた被験薬以外の治験使用薬の副作用等報告義務期間を終了すると考えてよい。

[R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q58・A58]

- ・複数の被験薬を用いる治験において、主たる被験薬以外の被験薬が承認又は開発中止となった場合、治験計画変更届書では以下のとおり対応すること。
 - 主たる被験薬以外の被験薬が承認された場合は、治験計画変更届書で当該被験薬の記載は削除せずそのままとし、備考欄で「被験薬〇〇（治験成分記号）は国内承認取得済みである」旨記載し、当該被験薬の「国内における承認状況」の欄を既承認に変更すること。
 - 主たる被験薬以外の被験薬が開発中止された場合は、治験計画変更届書で当該被験

薬の記載は削除せずそのままとし、備考欄で「被験薬〇〇（治験成分記号）は開発中止された」旨記載すること。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q59・A59〕

【事例】

- ・備考欄に変更がある場合には、備考欄に【変更日】【変更理由】も併せて入力した。
- ・治験から製造販売後臨床試験への切り替えを予定している場合に、治験計画変更届書の備考欄に記載して届け出た。
（記載内容については「Ⅱ．治験計画届書 5. 治験計画届書の記載上の注意事項 6. ケース別事例のまとめ (1) 製造販売後臨床試験への切替え（事例）（p72）」を参照）
- ・旧様式から新様式へ切り替える際の治験計画届について、令和4年8月31日事務連絡「薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について」Q&A69 に従って備考欄に記載して届け出た事項については、その後の治験計画変更届等提出時に削除せず、そのまま残すよう指示された。

(11) 届書添付資料

当該届出に際して添付資料がない場合は空欄とすること。

【事例】

- ・被験者のパートナーの治験中の妊娠に対する説明文書や同意文書を新たに制定するような場合、治験計画変更届提出の際に添付資料として提出することでよく、治験計画変更届でなく別途当該資料のみ提出することも可能であった。
- ・プラットフォーム試験において、複数の新たな薬剤を含むコホートを追加する際、治験薬概要書及び科学的知見を記載した文書としては新たな薬剤のもののみ添付していたが、これまでに提出しているすべての薬剤の治験薬概要書、科学的知見を記載した文書についても添付するよう指示された（それぞれ最新の文書を提出）。
- ・治験実施中に目的及び対象疾患を変更することになったため、治験計画変更届に添付する書類について審査マネジメント部に確認したところ、治験計画届出時に提出が必要な添付資料一式を提出するようとの回答であった。

(12) 治験届出者に関する情報

治験届出者の氏名（実態の変更を伴わない法人名の変更及び代表者の変更）、住所及び業者コードの変更、届出担当者の氏名、所属及び電話・FAX 番号、メールアドレスの変更並びに追加及び削除（変更後の担当者と連絡がとれるよう社内体制を整備しておくこと）は、変更後6ヵ月を目安として届け出ること差し支えないこと。

【事例】

- ・ 本社の移転に伴い、PMDA 審査マネジメント部に「治験届出者の所在地の変更」時期を確認したところ、「変更（移転）後 6 ヶ月を目安に届け出ることにより」との回答を得た。
- ・ 会社の合併時点で継続予定の治験について、治験実施の体制（実態）に変更がなければ、治験計画変更届（治験届出者の変更）で対応可能であった（存続会社、消滅会社とも）。提出時期は「合併後速やかに提出（目安として 1 ヶ月以内）」で良いとされた（p74）。

3. 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の情報

「Ⅱ. 治験計画届書 5 治験計画書の記載上の注意事項 3. 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当（主たる被験薬を除く。）の情報（p66）」を参照。

- ・ 新たな被験薬が同一の治験実施計画書で使用されると治験依頼者等が判断する場合は、治験計画変更届書での対応が可能である。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q18・A18〕

- ・ 届書に 30 日調査対象の被験薬を追加する場合は、当該被験薬を追加した治験実施計画書で治験を実施する 30 日以上前に届け出ること。
- ・ 30 日調査対象外の被験薬を追加する場合又は本邦において安全性情報が十分に蓄積されていない治験使用薬（被験薬を除く。）を追加する場合は、当該被験薬又は当該治験使用薬（被験薬を除く。）を追加した治験実施計画書で治験を実施する 2 週間程度前に届け出ること。
- ・ 上記のうち「安全性情報が十分に蓄積されていない治験使用薬（被験薬を除く。）」とは、例えば、本邦において製造販売承認申請を目的とするものではないが、本邦未承認の有効成分を含有する治験使用薬、本邦既承認の有効成分を含有し新投与経路となる治験使用薬等が該当する。なお、該当するかどうかの判断は、治験依頼者の責任により行うこと。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q6・A6〕

【事例】

- ・ 当初は治験依頼者より治験使用薬として交付していた併用薬について、試験途中より実施医療機関にて通常診療のために常備している製剤の使用へ切替える場合の対応として以下を確認した。
 - ① 治験計画変更届は、実施医療機関において当該製剤が使用される前までに提出すること
 - ② 治験届出上における「治験使用薬の名称」欄の入力方法については、「薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について」Q45・A45 を参照のこと（種類（剤形、含量）別の情報を記載しない一般的名称を追加する）
 - ③ 治験届のシステム上、切替える切替えないに関わらず全実施医療機関を一括で追加せざる

を得ない場合、一度追加したら削除はしないこと（切替えない実施医療機関についても「その他」欄に入力された内容も削除されてしまうため）。最終的に切替えを実施しなかった実施医療機関については「その他」欄に切替えなかった旨を記載すること

4. 実施医療機関ごとの事項

(1) 実施医療機関の名称・実施診療科、所在地及び電話番号

変更年月日については、変更後の内容での開始（予定）日を変更（予定）年月日として入力すること。

契約に至らなかった実施医療機関の削除、実施医療機関の名称・実施診療科及び所在地・代表電話番号の変更は、変更後 6 ヶ月を目安として届け出ること差し支えないこと。

【事例】

- ・試験実施中に施設が統廃合されることになり、以下の対応を行った。
 - 統合先施設との契約締結前に施設追加の治験計画変更届を提出
 - 現在実施中の施設（廃院予定）について、治験届の施設削除はしなくてよい。ただし、その他の欄に「〇〇年〇月〇日付けで～に統廃合され、当該施設で投与を受けていた被験者は～に移管された」旨を記載する。同じ治験責任医師が 2 つの施設に記載されていることについては特に問題なし。
- ・実施医療機関である A 病院が治験中に閉院することとなり、A 病院のすべての原資料と閉院後も治験継続を希望する被験者については、同試験を既に実施していた B 病院に移管・転院することとなった際の対応について、PMDA に確認し以下の対応を行った。
 - 閉院する医療機関のその他の欄に、閉院した旨、閉院の日付、被験者の転院先、治験に関わる記録の移管先について記載する。転院先の医療機関についてもその他の欄に被験者が転院したことがわかるように記載する。
 - 変更届の提出時期について、本事案は実施医療機関の削除や追加ではなく、変更届の提出期限が定められている項目には該当しないため、別の事案で次回変更届を提出する際に、本事案に関わる変更も含めて届け出る。
- ・契約に至らなかった実施医療機関の削除を届け出る場合、「変更理由」に契約に至っていないことが分かるように記載されていると、契約状況の問い合わせが不要になる、との PMDA 見解を得た。
- ・実施医療機関が閉院し別の実施医療機関に承継された場合、閉院した実施医療機関の記載を届書に残すよう PMDA から指示を受けたため、閉院した実施医療機関は削除せず、承継した実施医療機関の追加を行い、当該医療機関の変更理由及びその他欄に、事業承継による旨と経緯説明を記載した。

(2) 治験責任医師に関する情報

治験責任医師の氏名の変更、並びに実施医療機関の削除に伴う治験責任医師の削除は、変更後 6 ヶ月を目安として届け出ることによって差し支えないこと。

【事例】

- ・ 治験責任医師の卒業年については、大学卒業年を優先とするが、履歴書等の記載が大学院卒業年のみであれば、大学院卒業年を入力して提出した。
- ・ 治験責任医師 B で届出を行っていたが、その医師 B が治験分担医師へ、これまで治験分担医師だった医師 A が治験責任医師へ変更になる場合で、治験分担医師であった医師 A を未届けの場合は、治験責任医師の変更として医師 B を届け出た。また、医療機関ごとの項目の最後にある「その他」欄に、「医師 A は、201〇/〇/〇から 201×/×/×まで、治験分担医師として登録されていた。」という情報を入力した。

(3) 治験分担医師に関する情報

治験分担医師の氏名の変更並びに追加及び削除のみの変更については 1 年を目安としてまとめて届け出ることによって差し支えないこと。

【事例】

- ・ 治験分担医師が短期間内に追加され削除された場合の対応方法を審査マネジメント部に確認したところ、以下の 3 つの方法を提案された。
 - ① 予定している治験計画変更届で治験分担医師を追加、次回変更時に削除対応を行う。
 - ② 予定している治験計画変更届の医療機関ごとの項目「その他」の欄に、治験分担医師の追加・削除に関する記載（追加・削除年月日を含む）を行う。なお、「その他」の欄は、以降の治験計画変更届で削除せず記載を残すこと。
 - ③ 予定している治験計画変更届に、該当する治験分担医師を【削除】フラグを立てて記載し、【削除理由】に追加の経緯並びに削除の経緯を記載する（ただし、当該対応の可否は、届出作成システムでの対応可否による）。また、以下の対応方法により作成した届書についても受理された。
 - ④ 予定している治験計画変更届に、該当する治験分担医師【追加】フラグと【削除】フラグを同時にたてる。（ただし、当該対応の可否は、届出作成システムでの対応可否による）

例) 分担医師「田中 花子」さんが短時間に追加・削除された場合

順序番号 1

【追加日付】 20221001

【追加理由】 〇〇のため

治験分担医師の氏名 田中 花子

氏名よみかな たなか はなこ

順序番号 2

【削除日付】 20230401

【削除理由】 ○○のため

治験分担医師の氏名 田中 花子

氏名よみかな たなか はなこ

(4) 治験使用薬、治験使用機器相当、治験使用製品相当の数量情報・実施医療機関予定被験者数

- ・ 治験使用薬の予定交付（入手）数量及び予定被験者数は、治験の実施に伴って生じた数量及び被験者数の変更については届け出る必要はなく、治験終了届書又は治験中止届書にてまとめて届け出ることで差し支えない。
- ・ 治験の実施に伴って治験使用薬の交付数量や予定被験者数に変更が生じた場合には、当該項目に係る変更の届出は原則として不要であること。
- ・ 治験使用薬の輸入に関する手続きに伴い、予定交付（入手）数量及び予定被験者数の項目を変更する必要がある場合においては、必要に応じて、治験計画変更届書を届け出ることで差し支えない。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q9・A9〕

【事例】

- ・ 含量違いを組み合わせで交付する場合については、交付する治験薬の含量ごとに順序番号を変えて、それぞれの順序番号、治験薬の名称及び予定交付数量のみを繰り返し入力した。
- ・ 治験継続希望の被験者が転院して治験を継続する場合、PMDA から治験届にも記録を残すよう指示を受けた（記載場所についての指示はなかった）。「予定交付（入手）数量」や「実施医療機関予定被験者数」に変更が生じ、被験者の転院経緯を明確にするため、それぞれの施設の脚注に以下のように入力した。
 - 転出先：「転居に伴い○○病院の 1 症例が▽▽病院に転院後 YYYY 年 MM 月 DD 日に同意取得し、治験を継続した」
 - 転入先：「転居に伴い○○病院の 1 症例が▽▽病院へ転院し治験を継続する」

(5) 治験の実施に係る業務の一部を実施医療機関から受託する者（治験施設支援機関（SMO）等）の氏名、住所及び委託する業務の範囲

治験の実施に係る業務の一部を実施医療機関から受託する者（治験施設支援機関（SMO）等）の氏名、住所及び委託する業務範囲の変更並びに追加及び削除は、変更後 6 ヶ月を目安として届け出ることで差し支えないこと。

【事例】

- ・新たに SMO を追加する際、変更届で届け出る前に所在地が変更した場合の対応について PMDA 審査マネジメント部に問い合わせ、下記の通り回答を得た。
 - 新住所で届け出ること。その場合、氏名の追加年月日は契約日、住所の追加年月日は住所変更日とし、追加理由に「住所は○年○月○日に変更された新住所である」旨を記載すること。
 - 追加理由に文字制限等があり、入りきらない場合は、各実施医療機関情報の最後にある「その他」に記載すること。

(6) 治験審査委員会の設置者の名称及び所在地

治験審査委員会の設置者の名称及び所在地の変更並びに追加及び削除は、変更後 6 ヶ月を目安として届け出ることによって差し支えないこと。

届け出する時点で調査審議を行わせる治験審査委員会が決まっていなかった場合には、事後に変更届として届け出ることによって差し支えないこと。

IV. 治験中止届書

1 治験中止届の届出の対象

治験を中止したときは、その内容及び理由等を PMDA に届け出ること（規則第 270 条）。

2 治験中止届書の提出時期

（「Ⅲ. 治験計画変更届書 2 治験計画変更届書の提出時期（p86）」を参照）

治験計画届書ごとに治験が中止された都度遅滞なく届け出ること。

3 治験中止届書の作成に関する一般的注意事項

（「Ⅱ. 治験計画届書 3 治験計画届書の作成に関する一般的注意事項（p34）」を参照）

4 治験中止届書の提出に関する一般的注意事項

（「Ⅰ. 申請電子データシステムを利用した治験計画届書等のオンライン提出」（p5）及び「Ⅱ. 治験計画届書 4 治験計画届書の提出に関する一般的注意事項（p46）」を参照）

- ・基本通知に基づく様式で届け出の場合は、その旨入力すること。
- ・主たる治験の治験中止届が提出された場合には、当該治験に係る情報の削除を依頼する旨のメールを、可能な限り速やかに kakudaitiken@pmda.go.jp 宛に送付すること。その際のメールの件名は「【人道的見地からの治験】【削除】治験届出者名_提出年月日（YYYYMMDD）」とし、メール本文に削除したいリストの内容、治験計画届受付番号及び治験中止届書等の情報（届出日、受付番号等）を記載すること。

なお、その際の PMDA ウェブサイトの更新は、毎月 15 日までに連絡があった場合には当月末を目処に、16 日以降に連絡があった場合は翌月末を目処に行われる予定である（p44 参照）。

〔R4.8.31 事務連絡 人道的見地から実施される治験の実施に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q20・A20〕

5 治験中止届書の記載上の注意事項

（「Ⅱ. 治験計画届書 5 治験計画届書の記載上の注意事項（p51）」を参照）

1. 治験届出共通事項

(1) 当該治験計画届出受付番号

当該治験計画届書の受付番号を半角数字及び半角ハイフンを用いて入力すること。

(2) 当該治験計画届出年月日

当該治験計画届書の提出年月日を入力すること。

2. 主たる被験薬に関する届出事項

(1) 届出年月日

当該届出の提出年月日を入力すること。

(2) 届出分類

「治験中止届」と入力すること。

(3) 届出区分

「3」を半角数字で入力すること。

(4) 中止情報

治験の中止時期（中止を決定した年月日）、中止理由（具体的に記載）、その後の対応状況（中止を決定した後の対応状況を具体的に記載）について入力すること。

(5) 予定被験者数情報

- ・当該治験に参加したすべての被験者数（被験薬群及び対照薬群を含む。）を入力すること。
- ・当該治験に参加したすべての被験者数は、実際に割り付けられた日本国内の被験者数を記載等すること。例えば、国際共同治験の場合は、日本国内で実際に割り付けられた被験者数を記載等すること。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q11・A11〕

(6) 届書添付資料

必要に応じ中止理由に関する資料（中止に至るまでの投与症例に関する情報を含むものであること。）

資料を添付した場合には、その資料名を入力する。

3. 実施医療機関ごとの事項

- ・予定交付（入手）数量：治験の実施に伴って生じた数量の変更については治験計画変更届にて届け出る必要はなく、治験終了届書又は治験中止届書にてまとめて届け出ることで差し支えない。
- ・交付数量／使用数量／回収数量／廃棄数量：実際に交付、使用及び回収、廃棄した治験使用薬の数量を種類（剤形・含量）別に入力する。

- ・実施医療機関（予定）被験者数：治験の実施に伴って生じた被験者数の変更については治験計画変更届にて届け出る必要はなく、治験終了届書又は治験中止届書にてまとめて届け出ることと差し支えない。
- ・実施医療機関被験者数：実施医療機関ごとの被験者数（被験薬群及び対照薬群を含む。）を入力する。
- ・治験使用薬数量の記載例については、「Ⅱ．治験計画届書 5 治験計画届書の記載上の注意事項 4. 実施医療機関ごとの事項」（p68）を参照のこと。なお、治験終了届書又は治験中止届書における治験使用薬の数量として、包装単位（PTP シート、ボトル等）での内訳を記載することで差し支えない。（記載例）1 ボトル（X mg 錠、X 錠入り） X ボトル交付、X ボトル使用、X ボトル回収。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q44・A44〕

【事例】

- ・治験終了届/治験中止届における治験薬の予定交付数量/予定被験者数の記載の変更の必要性について PMDA 審査マネジメント部を通じて厚生労働省医薬局医薬品審査管理課に通知の解釈を確認したところ、「予定交付数量/予定被験者数について、治験終了届書又は治験中止届書で変更するかどうかは企業側で判断して差し支えない」との回答を得た。

V. 治験終了届書

1 治験終了届の届出の対象

治験を終了したときは、その内容を PMDA に届け出ること（規則第 270 条）。

治験終了届は添付資料の提出が必要とされないため、届書のみファイルを作成すること。

2 治験終了届書の提出時期

（「Ⅲ. 治験計画変更届書 2 治験計画変更届書の提出時期（p86）」を参照）

治験計画届書ごとにすべての実施医療機関から治験を終了する旨の通知を受け、かつ、治験薬の回収が終了した時点で遅滞なく届け出ること。

3 治験終了届書の作成に関する一般的注意事項

（「Ⅱ. 治験計画届書 3 治験計画届書の作成に関する一般的注意事項（p34）」を参照）

4 治験終了届書の提出に関する一般的注意事項

（「Ⅰ. 申請電子データシステムを利用した治験計画届書等のオンライン提出」（p5）及び「Ⅱ. 治験計画届書 4 治験計画届書の提出に関する一般的注意事項（p46）」を参照）

基本通知に基づく様式で届け出の場合は、その旨入力すること。

5 治験終了届書の記載上の注意事項

（「Ⅱ. 治験計画届書 5 治験計画届書の記載上の注意事項（p51）」を参照）

1. 治験届出共通事項

(1) 当該治験計画届出受付番号

当該治験計画届書の受付番号を半角数字及び半角ハイフンを用いて入力すること。

(2) 当該治験計画届出年月日

当該治験計画届書の提出年月日を入力すること。

2. 主たる被験薬に関する届出事項

(1) 届出年月日

当該届出の提出年月日を入力すること。

(2) 届出分類

「治験終了届」と入力すること。

(3) 届出区分

「3」を半角数字で入力すること。

(4) 予定被験者数情報

- ・当該治験に参加したすべての被験者数（被験薬群及び対照薬群を含む。）を入力すること。
- ・当該治験に参加したすべての被験者数は、実際に割り付けられた日本国内の被験者数を記載等すること。例えば、国際共同治験の場合は、日本国内で実際に割り付けられた被験者数を記載等すること。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q11・A11〕

(5) 届書添付資料

当該届出に資料を添付した場合には、その資料名を入力する。

3. 実施医療機関ごとの事項

- ・予定交付（入手）数量：治験の実施に伴って生じた数量の変更については治験計画変更届にて届け出る必要はなく、治験終了届書又は治験中止届書にてまとめて届け出ることで差し支えない。
- ・交付数量／使用数量／回収数量／廃棄数量：実際に交付、使用及び回収、廃棄した治験使用薬の数量を種類（剤形・含量）別に入力する。
- ・実施医療機関（予定）被験者数：治験の実施に伴って生じた被験者数の変更については治験計画変更届にて届け出る必要はなく、治験終了届書又は治験中止届書にてまとめて届け出ることで差し支えない。
- ・実施医療機関被験者数：実施医療機関ごとの被験者数（被験薬群及び対照薬群を含む。）を入力する。
- ・治験使用薬の数量の記載例については「Ⅱ. 治験計画届書 5 治験計画届書の記載上の注意事項 4. 実施医療機関ごとの事項」（p68）を参照のこと。なお、治験終了届書又は治験中止届書における治験使用薬の数量として、包装単位（PTP シート、ボトル等）での内訳を記載することで差し支えない。（記載例）1 ボトル（X mg 錠、X 錠入り） X ボトル交付、X ボトル使用、X ボトル回収。

〔R4.8.31 事務連絡 薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q44・A44〕

【事例】

- ・治験終了届/治験中止届における治験薬の予定交付数量/予定被験者数の記載の変更の必要性

について PMDA 審査マネジメント部を通じて厚生労働省医薬局医薬品審査管理課に通知の解釈を確認したところ、「予定交付数量/予定被験者数について、治験終了届書又は治験中止届書で変更するかどうかは企業側で判断して差し支えない」との回答を得た。

- ・実施医療機関の体制変更により、新たな実施医療機関にて治験が継続されたケースで、もとの実施医療機関の「実施医療機関被験者数」について空欄としていたが、空欄では受付が来ないので例えば 0 と数字を入力し、「その他」欄に説明を記載するように指示を受けた。
- ・治験届作成システム上、治験薬の【使用数量】、【回収数量】、【破棄数量】が「〇.〇g」のように小数点以下 1 桁、小数点以下が入力できない場合は、上記各項目に小数点以下を四捨五入した値を入力した。さらに、各実施医療機関の「その他」欄に以下の情報を入力した。
 - 使用数量、回収数量、破棄数量について小数点以下 1 桁のデータ
 - 【使用数量】、【回収数量】、【破棄数量】欄のデータは小数点以下を四捨五入した値を入力している旨
- ・回収した当該薬剤の一部が実薬とプラセボどちらなのか特定できなかった場合に、紛失分をプラセボ錠として計上し、対応する実施医療機関の備考欄に「回収時に薬剤の種類を特定できなかった 2 錠は治験薬名称「〇〇プラセボ錠」に含めた」と入力した。
- ・開封したが、被験者には投与されなかった治験薬で、治験依頼者側に返却されたものは、回収数量に含めた。また、廃棄数量には、被験者に投与されずに医療機関側で廃棄され、治験依頼者側に返却されなかった治験薬数量を入力した。
- ・変更後 6 ヶ月を目安として届け出てもよい事項について、治験終了届にて変更を届け出ることになっていたが、PMDA に問い合わせた時点で変更から 6 ヶ月を大きく超過していたため、治験終了届に遅延理由書を添付して提出することでよいか確認したところ、問題ないとの回答を得た。電子媒体のファイル名末尾は「_S_etc」として格納することを確認した。
- ・旧様式で届け出た治験計画届を経過措置期間終了後に終了させるにあたって、新様式で治験計画変更届及び治験終了届の同時提出を行った。提出時には既に治験自体は終了していたものの、PMDA からは提出日（1 日だけ）の治験使用薬の副作用等報告を行う義務があるとされた。
- ・日本も含めた国際共同試験で、当初予定した組み入れ期間が満了した時点で、国内では 1 例も被験者が組み入れられず、また、組み入れ期間を延長しても国内で新たに被験者が組み入れられる見込みはないと判断されたため、国内では治験を終了することとした。なお、試験全体としては、その時点でまだ海外で被験者の組み入れが進んでおり、組み入れ期間を延長することで、予定した被験者数を確保し、試験を継続する予定であった。この場合、（治験中止届ではなく）治験終了届を出すことで良いか、PMDA 審査マネジメント部に確認したところ、治験終了届を出すことで差し支えないとの回答を得た。
- ・承認後に治験から製造販売後臨床試験に切り替える際に治験終了届を提出するが、製造販売後臨床試験部分の期間が長期にわたるような場合（継続提供目的に加え、更なる長期投与デ

ータの取得等の理由)における、治験終了届の提出時期や治験薬の収支を PMDA 審査マネジメント部に確認した(市販後までの継続提供が主目的の試験では、承認後速やかに終了するため、製造販売後臨床試験部分も含めた治験薬の収支、それが終わった段階での治験終了届になっている)。その結果、治験終了届は承認取得後速やかに提出し、治験薬の収支は承認日をおおよそその終点とした情報を記載する形でよいとの回答を得た。

VI. 開発中止届書

1 開発中止届の届出の対象

治験の計画を届け出た被験薬の開発について中止することを決定した場合には、決定後遅滞なく、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長宛てとして PMDA に届け出ること。この場合、開発中止とは、例えば当初複数の効能について治験を行っていた薬物の場合であれば、そのすべての効能についての開発中止を指すものであること。また、開発中止理由を具体的に説明すること。

治験成分記号、初回届出受付番号、初回届出年月日、届出年月日、届出分類、中止情報（中止時期（開発中止を決定した年月日）、中止理由（開発中止の具体的理由）を含む。）、備考、届書添付資料（資料を添付した場合）及び治験届出者に関する情報を入力して届け出ること。

【運用】届書の宛先は厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長だが、提出先は PMDA となる。

【運用】開発中止届の提出後、開発を再開する場合には、事前に審査マネジメント部審査企画課審査情報室に連絡し、当時の開発中止理由や再開に至る経緯等を説明すること。なお、再開時に提出する治験計画届の備考欄に開発中止届日及び当時の治験成分記号を記載し、添付資料の「治験の依頼を科学的に正当とした理由を記した文書」に開発中止及び再開に至る経緯を記載すること。

【事例】

- ・開発を長期間中止していた品目について開発中止届を提出する場合は、提出前に社内安全性部門へ「治験薬副作用・感染症症例報告留保申出書（以下「留保申出書」という。）」を提出していないか確認する方が良い。開発中止届提出時に「留保申出書」の提出の有無を確認されることがあり、提出している場合は、留保解除後でないと開発中止届は受け付けられなかった。
- ・留保申出書を提出している場合、留保解除申出書と同時に開発中止届を提出しても受理された。
- ・開発中止届を提出済みではあるが、その後医師主導治験の実施により再度治験実施が計画された場合の対応について以下の内容を PMDA に確認した。
 - 開発中止届を提出済みの医薬品について、医師主導治験の計画がされた場合であっても、治験計画届の提出は可能
 - 届出回数は、連番でよい（「第 1 回」にする必要なし）
 - 計画届の備考欄に開発中止届を提出した治験成分記号（開発中止後、治験成分記号が変わることがあるため）、開発中止届出日を記載する。提出にあたり、PMDA への事前連絡などは不要
 - 「当該治験の依頼を科学的に正当と判断した理由を記した文書」に開発中止届を提出してから計画届を提出するまでの経緯を記載する。

2 開発中止届書の提出時期

開発について中止決定後遅滞なく届け出ること。

3 開発中止届書の作成に関する一般的注意事項

（「Ⅱ．治験計画届書 3 治験計画届書の作成に関する一般的注意事項（p34）」を参照）

4 開発中止届書の提出に関する一般的注意事項

（「Ⅰ．申請電子データシステムを利用した治験計画届書等のオンライン提出」（p5）及び「Ⅱ．治験計画届書 4 治験計画届書の提出に関する一般的注意事項（p46）」を参照）

- ・基本通知に基づく様式で届け出の場合は、その旨入力すること。
- ・主たる治験の開発中止届が提出された場合には、当該治験に係る情報の削除を依頼する旨のメールを、可能な限り速やかに kakudaitiken@pmda.go.jp 宛に送付すること。その際のメールの件名は「【人道的見地からの治験】【削除】治験届出者名_提出年月日（YYYYMMDD）」とし、メール本文に削除したいリストの内容、治験計画届受付番号及び治験中止届書等の情報（届出日、受付番号等）を記載すること。

なお、その際の PMDA ウェブサイトの更新は、毎月 15 日までに連絡があった場合には当月末を目処に、16 日以降に連絡があった場合は翌月末を目処に行われる予定である（p44 参照）。

〔R4.8.31 事務連絡 人道的見地から実施される治験の実施に関する質疑応答（Q&A）の改正について Q20・A20〕

5 開発中止届書の記載上の注意事項

（「Ⅱ．治験計画届書 5 治験計画届書の記載上の注意事項（p51）」を参照）

1. 主たる被験薬に関する届出事項

(1) 届出年月日

当該届出の提出年月日を入力すること。

(2) 届出分類

「開発中止届」と入力すること。

(3) 届出区分

半角数字「3」であることを確認すること（【運用】使用するシステムによっては、「届出区分」の入力欄はなく、届出用ファイルを出力する際に自動で「3」が入力される場合がある）。

(4) 中止情報（中止時期、中止理由を含む）

開発中止を決定した年月日及び開発中止の具体的理由について入力すること。なお、「備考」欄に「開発中止を決定した被験薬について、実施中の治験はない」旨記載すること。

(5) 届書添付資料

届書に資料を添付した場合には、その資料名を入力すること。

引用通知一覧

【根拠条文】

薬機法第 80 条の 2、第 80 条の 3

薬機法施行規則第 268 条、第 270 条、第 275 条、第 283 条

【通知・事務連絡等】

発信日付	表題	発信番号
H9.3.13	中央薬事審議会答申	中薬審第 40 号
H9.3.27	薬事法等の一部を改正する法律の施行について	薬発第 421 号
H10.4.21 R4.12.23 改正	臨床試験の一般指針について 「臨床試験の一般指針」の改正について	医薬審第 380 号 薬生薬審発 1223 第 5 号
H10.12.1	医薬品の承認申請後の臨床試験の実施の取扱いについて	医薬審第 1061 号
H11.7.30 (H22.11.1 改正、H23.8.31 廃止)	細胞・組織を利用した医療機器又は医薬品の品質及び安全性の確保について	医薬発第 906 号
H15.5.15	薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律の一部の施行について	医薬発第 0515017 号
H15.6.12	「薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について	医薬審発第 0612004 号
H16.2.19	遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行について	薬食発第 0219008 号
H16.2.19	遺伝子組換え微生物の使用等による医薬品等の製造における拡散防止措置等について	薬食発第 0219011 号
H16.3.19 H28.7.29 一部改正	遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行に伴う事務取扱い等について 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行に伴う事務取扱い等について」の一部改正について	薬食審査発第 0319001 号 薬生薬審発 0729 第 4 号、 薬生機審発 0729 第 5 号
H16.3.25	独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による薬事法の一部改正等について	薬食発第 0325013 号
H22.2.19	「医薬品の臨床試験及び製造販売承認申請のための非臨床安全性試験の実施についてのガイダンス」について	薬食審査発 0219 第 4 号
H23.6.30 R3.7.30 改正	医薬品・医療機器薬事戦略相談事業の実施について レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部改正について (タイトル変更)	薬機発第 0630007 号 薬機発第 0730001 号
H23.6.30	薬事戦略相談の実施に伴う細胞・組織を加工した医薬品又は医療機器の取扱いの変更について	薬食発 0630 第 2 号
H24.3.21	「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う審査等業務に係る申請・届出等の受付等業務の取扱いについて」の一部改正について 別紙 4	薬機発第 0321025 号
H24.10.1	「第十六改正日本薬局方の制定に伴うコード等について」の一部改正について	事務連絡（審査管理課）
H25.5.31	治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて	薬食審査発 0531 第 8 号
H25.7.1	コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事項について	薬食審査発 0701 第 10 号
H25.7.1	コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品に関する質疑応答集（Q&A）について	事務連絡（審査管理課）
H25.8.30 (H27.12.14 、 R2.12.9、R4.2.7、 R4.8.31 改正)	薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答（Q&A）について	事務連絡（審査管理課）
R26.6.30 (H27.7.16 廃止、 R3.11.25 廃止、 R4.2.3 廃止、 R5.6.30 改正)	遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく承認の申請等の事務手続等に関する質疑応答集（Q&A）について	事務連絡（審査管理課）

発信日付	表題	発信番号
H26.10.27	フレキシブルディスク等を利用した申請等の記録項目、コード表等について	薬食審査発 1027 第 1 号
H27.11.10	潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中 DNA 反応性（変異原性）不純物の評価及び管理ガイドラインについて（ICH-M7）	薬生審査発 1110 第 3 号
H30.6.27 一部改正	「潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中 DNA 反応性（変異原性）不純物の評価及び管理ガイドラインについて」の一部改正について	薬生薬審発 0627 第 1 号
H28.1.22	人道的見地から実施される治験の実施について	薬生審査発 0122 第 7 号
R4.8.31 改正	「人道的見地から実施される治験の実施について」の改正について	薬生薬審発 0381 第 3 号
H28.1.22	人道的見地から実施される治験の実施に関する質疑応答（Q&A）	事務連絡（審査管理課）
H28.11.30 改正	人道的見地から実施される治験の実施に関する質疑応答（Q&A）の改正について	事務連絡（医薬品審査管理課）
R4.8.31 改正	人道的見地から実施される治験の実施に関する質疑応答（Q&A）の改正について	事務連絡（医薬品審査管理課）
H28.7.14	遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく手続の見直しについて	薬生発 0714 第 2 号
R3.9.30 一部改正	「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく手続の見直しについて」の一部改正について	薬生発 0930 第 5 号
R3.11.25 一部改正	遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく手続の見直しについて	薬生発 1125 第 1 号
R1.6.20	初めてヒトに投与する薬物に係る治験の計画の届出時における非臨床安全性試験の最終報告書の提出について	薬機審長発第 0620003 号
R1.6.20	初めてヒトに投与する薬物に係る治験の計画の届出時における非臨床安全性試験の最終報告書の提出に関する質疑応答集（Q&A）について	薬機審長発第 0620004 号
R2.8.31	治験の実施状況等の登録について	薬生薬審発 0831 第 9 号
R2.8.31	治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて	薬生薬審発 0831 第 10 号
R4.8.31 一部改正	「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について	薬生薬審発 0831 第 1 号
R5.3.30 一部改正	「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について	薬生薬審発 0330 第 3 号
R2.8.31	「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の改正について	薬生薬審発 0831 第 15 号
R3.7.30 改正	「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の改正について	薬生薬審発 0730 第 3 号
R3.6.4	遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る 事務取扱い等について	薬生薬審発 0604 第 2 号、薬生機審発 0604 第 1 号
R4.2.3 改正	遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る事務取扱い等について	薬生薬審発 0203 第 1 号、薬生機審発 0203 第 1 号
R3.8.31	届出等のオンライン提出に関する質疑応答集（Q&A）について	事務連絡（医薬品審査管理課・局医療機器審査管理課・医薬安全対策課・監視指導・麻薬対策課）
R4.11.16	治験計画等の届出の取扱い（申請電子データシステムを利用したオンライン提出）について	薬生薬審発 1116 第 4 号、薬生機審発 1116 第 1 号、薬生監麻発 1116 第 2 号
R4.12.26	独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う審査等業務に係る申請・届出等の受付等業務の取扱いについて	薬機発第 1226040 号
R5.3.22	申請書等のオンライン提出に係る取扱い等について	薬生薬審発 0322 第 1 号、薬生機審発 0322 第 2 号、薬生安発 0322 第 1 号、薬生監麻発 0322 第 2 号

発信日付	表題	発信番号
R5.3.30	治験計画等の届出の取扱い（申請電子データシステムを利用したオンライン提出）の留意点について	なし（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 審査マネジメント部）
R5.3.30	薬物、機械器具又は加工細胞等に係る治験の計画の届出に関する質疑応答集（Q&A）について	事務連絡（医薬品審査管理課・医療機器審査管理課）
R5.8.17	30日調査等の対象となる治験計画等の届出に係る担当審査部による照会に対する回答等の提出時（申請電子データシステムを利用したオンライン提出）の留意点について	なし（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 審査マネジメント部）

【説明会・講習会等】

H28.4.22	第13回医薬品評価フォーラム
R3.6.8	医薬品医療機器等法改正説明会
R5.2.6	改正医薬品医療機器等法関連通知及び治験届オンライン提出説明会

本書の内容を無断で複写・転載することを禁じます

治験届の手引き

公益社団法人 東京医薬品工業協会
薬事法規委員会

103-0022 東京都中央区日本橋室町 3-3-9

日本橋アイティビル 7 階
電話 03-3270-3561
FAX 03-3278-9867

2024 年 3 月